



Optimal
Untuk
Negeri



optimal

Bunga Rampai

ASUHAN KEPERAWATAN KELUARGA

Pada Keluarga Dengan Anggota
Yang Menderita Hipertensi

Noor Rochmah I. A. Trisno Putri • Rizqy Iftitah Alam • Barto Mansyah
Syaiful • Prima Trisna Aji • Antonius Yogi Pratama • Prasanti Adriani

Editor: Dwi Agustanti



BUNGA RAMPAI ASUHAN KEPERAWATAN KELUARGA PADA KELUARGA DENGAN ANGGOTA YANG MENDERITA HIPERTENSI

Penulis:

Noor Rochmah Ida Ayu Trisno Putri, S.Kep.Ns., M.Kep.

Rizqy Iftitah Alam, S.Kep., Ns., M.Kes.

Barto Mansyah, S.Pd., MH.

Syaiful, S.Pd., S.Kep., Ns., M.Pd., M.Kes.

Ns. Prima Trisna Aji, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.MB.

Antonius Yogi Pratama, S.Kep., Ns., MSN.

Dr. Prasanti Adriani, S.SiT., S.Kep., Ns., M.Kes.

Editor:

Dwi Agustanti, SKp., M.Kep., Sp.Kom.



Bunga Rampai Asuhan Keperawatan Keluarga Pada Keluarga Dengan Anggota Yang Menderita Hipertensi

Penulis:

Noor Rochmah Ida Ayu Trisno Putri, S.Kep.Ns., M.Kep.

Rizqy Iftitah Alam, S.Kep., Ns., M.Kes.

Barto Mansyah, S.Pd., MH.

Syaiful, S.Pd., S.Kep., Ns., M.Pd., M.Kes.

Ns. Prima Trisna Aji, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.MB.

Antonius Yogi Pratama, S.Kep., Ns., MSN.

Dr. Prasanti Adriani, S.SiT., S.Kep., Ns., M.Kes.

Editor: Dwi Agustanti, SKp., M.Kep., Sp.Kom.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Muhamad Ilham

ISBN: 978-634-7756-30-5

Cetakan Pertama: Mei, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2026

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya buku bunga rampai berjudul "Asuhan Keperawatan Keluarga pada Keluarga dengan Anggota yang Menderita Hipertensi." Buku ini hadir sebagai bentuk kontribusi akademik dalam memperkuat pengembangan ilmu keperawatan keluarga, khususnya dalam penanganan hipertensi sebagai salah satu penyakit tidak menular dengan prevalensi tinggi di Indonesia. Hipertensi tidak hanya berdampak pada kondisi fisik individu, tetapi juga memengaruhi fungsi, peran, dan kualitas hidup keluarga. Oleh karena itu, pendekatan keperawatan keluarga menjadi sangat penting untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang mengalami hipertensi secara mandiri, berkelanjutan, dan terintegrasi.

Buku ini disusun secara sistematis dengan membahas konsep dasar keperawatan keluarga, tugas kesehatan keluarga dalam pengelolaan hipertensi, hingga proses pengkajian keperawatan keluarga pada anggota keluarga yang mengalami hipertensi. Selain itu, pembaca juga akan memperoleh pemahaman mengenai diagnosis keperawatan keluarga yang sering muncul, penentuan prioritas masalah, serta integrasi standar diagnosis, luaran, dan intervensi keperawatan. Berbagai bentuk intervensi edukasi juga dibahas secara aplikatif, meliputi edukasi diet, aktivitas fisik, kepatuhan minum obat, dan pemantauan tekanan darah yang menjadi bagian penting dalam pengendalian hipertensi berbasis keluarga.

Pada bagian akhir, buku ini menguraikan pemberdayaan keluarga dalam pengambilan keputusan dan pencegahan komplikasi hipertensi, termasuk strategi perawat dalam memfasilitasi keluarga agar mampu menjalankan tugas kesehatan secara optimal. Evaluasi hasil asuhan keperawatan keluarga juga dibahas untuk membantu perawat dalam menilai keberhasilan intervensi dan keberlanjutan perawatan di rumah. Penulis berharap buku bunga rampai ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, perawat, tenaga kesehatan, serta pemerhati kesehatan keluarga dalam meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan keluarga pada masalah hipertensi di Indonesia.

Editor

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
---------------------	------------

DAFTAR ISI.....	iv
------------------------	-----------

CHAPTER 1 KONSEP DASAR KEPERAWATAN KELUARGA 1

Noor Rochmah Ida Ayu Trisno Putri, S.Kep.Ns., M.Kep.	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Konsep Keluarga.....	2
C. Konsep Keperawatan Keluarga	9
D. Prinsip dan Pendekatan Keperawatan Keluarga	11
E. Peran Perawat dalam Keperawatan Keluarga	13
F. Referensi.....	14

CHAPTER 2 TUGAS KESEHATAN KELUARGA DALAM MERAWAT

ANGGOTA KELUARGA PADA MASALAH HIPERTENSI..... 15

Rizqy Iftitah Alam, S.Kep., Ns., M.Kes.	15
A. Pendahuluan.....	15
B. Konsep Keluarga dalam Keperawatan.....	16
C. Konsep Tugas Kesehatan Keluarga.....	17
D. Konsep Hipertensi.....	19
E. <i>Evidence Based Practice</i> dalam Pengelolaan Hipertensi Berbasis Keluarga.....	20
F. Strategi Pemberdayaan Keluarga dalam Pengendalian Hipertensi	21
G. Hambatan Keluarga dalam Pengelolaan Hipertensi	22
H. Simpulan.....	23

CHAPTER 3 PENGKAJIAN KEPERAWATAN KELUARGA PADA MASALAH

HIPERTENSI..... 25

Barto Mansyah, S.Pd., MH.	25
A. Pendahuluan/Prolog	25
B. Makna Pengkajian Keperawatan Keluarga pada Hipertensi.....	26
C. Data Dasar Keluarga yang Perlu Dikaji.....	27
D. Pengkajian Kondisi Anggota Keluarga yang Menderita Hipertensi	29
E. Pengkajian Tekanan Darah di Rumah.....	30
F. Pengkajian Pola Makan Keluarga.....	32

G. Pengkajian Aktivitas Fisik dan Kebiasaan Harian.....	34
H. Pengkajian Tugas Kesehatan Keluarga.....	36
I. Pengkajian Lingkungan Rumah dan Dukungan Sosial.....	38
J. Data Fokus dalam Pengkajian Hipertensi Keluarga.....	39
K. Prinsip Komunikasi Saat Melakukan Pengkajian	40
L. Mengidentifikasi Masalah dari Hasil Pengkajian	41
M. Contoh Narasi Hasil Pengkajian.....	43
N. Simpulan.....	43
O. Referensi.....	44

CHAPTER 4 DIAGNOSIS KEPERAWATAN KELUARGA YANG SERING

MUNCUL.....	51
Syaiful, S.Pd., S.Kep., Ns., M.Pd., M.Kes.	51
A. Pendahuluan.....	51
B. Konsep Dasar Diagnosis Keperawatan Keluarga	52
C. Landasan Pengkajian untuk Menegakkan Diagnosis Keluarga	53
D. Diagnosis Keperawatan Keluarga yang Sering Muncul.....	55
E. Menentukan Prioritas Diagnosis Keluarga.....	63
F. Contoh Perumusan Diagnosis pada Kasus Keluarga	65
G. Integrasi SDKI-SLKI-SIKI dengan NANDA-I, NOC, dan NIC.....	66
H. Kesalahan yang Sering Terjadi dalam Menetapkan Diagnosis.....	68
I. Peran Perawat dalam Menindaklanjuti Diagnosis.....	69
J. Penutup	70
K. Glosarium.....	71
L. Referensi.....	72

CHAPTER 5 INTERVENSI EDUKASI DIET, AKTIVITAS FISIK, KEPATUHAN

OBAT DAN PEMANTAUAN TEKANAN DARAH	75
Ns. Prima Trisna Aji, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.MB.	75
A. Pendahuluan.....	75
B. Peran Keluarga dalam Pengelolaan Hipertensi.....	78
C. Intervensi Edukasi Diet pada Hipertensi.....	81
D. Intervensi Edukasi Aktivitas Fisik pada Hipertensi	84
E. Intervensi Edukasi Kepatuhan Obat pada Hipertensi	88
F. Intervensi Edukasi Pemantauan Tekanan Darah.....	91
G. Implementasi Asuhan Keperawatan Keluarga pada Hipertensi	95
H. Simpulan.....	98
I. Referensi.....	100

J. Glosarium.....	102
 CHAPTER 6 PEMBERDAYAAN KELUARGA DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PENCEGAHAN KOMPLIKASI.....105	
Antonius Yogi Pratama, S.Kep., Ns., MSN.....	105
A. Pendahuluan.....	105
B. Konsep Pemberdayaan Keluarga	106
C. Teori-Teori yang Mendasari Pemberdayaan Keluarga.....	107
D. Lima Tugas Keluarga.....	107
E. Peran Keluarga Dalam Manajemen Hipertensi	108
F. Pengambilan Keputusan Keluarga.....	110
G. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan	111
H. Strategi Perawat dalam Memfasilitasi Pengambilan Keputusan.....	111
I. Strategi Pencegahan Komplikasi Berbasis Keluarga.....	112
J. Strategi Implementasi Program Pemberdayaan Keluarga Hipertensi	115
K. Simpulan.....	117
L. Referensi.....	117
 CHAPTER 7 EVALUASI HASIL ASUHAN KEPERAWATAN KELUARGA PADA MASALAH HIPERTENSI125	
Dr. Prasanti Adriani, S.SiT., S.Kep., Ns., M.Kes.....	125
A. Konsep Dasar Evaluasi Keperawatan Keluarga.....	125
B. Evaluasi Berdasarkan Lima Tugas Kesehatan Keluarga	129
C. Pendekatan dan Metode Evaluasi dalam Asuhan Keperawatan Keluarga ..	134
D. Dokumentasi Evaluasi Keperawatan.....	138
E. Tantangan dalam Evaluasi Asuhan Keperawatan Keluarga	141
F. Simpulan.....	146
G. Referensi.....	146
H. Glosarium.....	148
 PROFIL PENULIS149	

CHAPTER 1

KONSEP DASAR KEPERAWATAN KELUARGA

Noor Rochmah Ida Ayu Trisno Putri, S.Kep.Ns., M.Kep.

A. Pendahuluan

Keluarga merupakan bagian terkecil masyarakat yang memiliki peran penting dalam menentukan perkembangan kehidupan sosial serta status kesehatan anggotanya (Stanhope & Lancaster, 2022). Secara tradisional, keluarga diartikan sebagai kelompok individu yang terikat dalam hubungan pernikahan, hubungan darah maupun adopsi yang hidup bersama dalam satu rumah tangga, memiliki ikatan emosional yang kuat serta memiliki peran sosial yang saling berkaitan (Kaakinen et al., 2015). Keluarga dalam kehidupan sehari-hari berfungsi sebagai sistem pendukung utama dalam pemenuhan kebutuhan fisik, emosional, sosial dan psikologis setiap anggotanya (Astuti et al., 2024). Oleh karena itu, keluarga dipandang sebagai fokus penting dalam suatu pelayanan keperawatan.

Adanya perubahan pola penyakit dari penyakit infeksi menuju penyakit degeneratif hingga kronis, peningkatan angka harapan hidup, perubahan struktur keluarga serta perkembangan masalah kesehatan mental dan sosial menuntut pelayanan kesehatan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada keluarga (Qasim et al., 2025). Pendekatan secara individu tidak lagi cukup untuk mengatasi berbagai permasalahan kesehatan yang terjadi di masyarakat. Keberhasilan dari upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sangat dipengaruhi oleh adanya keterlibatan keluarga dalam proses perawatan (Aliffatunisa et al., 2021).

Keperawatan keluarga merupakan salah satu area praktik keperawatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada individu sebagai bagian dari sistem keluarga. Pelayanan keperawatan keluarga dilakukan komprehensif dengan melibatkan keluarga sebagai bagian penting dalam proses perawatan (Bailon & Maglaya, 1997). Pendekatan ini sejalan dengan paradigma layanan kesehatan primer yang menempatkan keluarga sebagai pusat layanan kesehatan (*family centered care*) (Fadhilah & Yuliarsih, 2024).

B. Konsep Keluarga

1. Definisi Keluarga

Keluarga merupakan unit terkecil yang berada dalam masyarakat dan terbentuk melalui adanya hubungan pernikahan, hubungan darah maupun adopsi, serta hidup bersama dalam satu rumah tangga. Pada konteks kesehatan, keluarga menjadi sistem pendukung utama yang mempengaruhi status kesehatan individu maupun kelompok, serta memiliki peran dalam pemenuhan kebutuhan fisik, psikologis, sosial dan spiritual setiap anggotanya (Astuti et al., 2024). Beberapa ahli telah menjabarkan pengertian keluarga sesuai dengan perkembangan sosial di masyarakat. Berikut adalah beberapa batasan konseptual dari pengertian keluarga:

a. World Health Organization (1994)

Keluarga diartikan sebagai anggota dalam rumah tangga yang saling memiliki hubungan ikatan darah, adopsi, atau pernikahan yang berfungsi menciptakan, mempertahankan, meningkatkan kesehatan anggota keluarga. Konteks kesehatan, keluarga sebagai suatu sistem yang saling berinteraksi dan mempengaruhi

b. Bailon dan Maglaya (1997)

Keluarga sebagai sekelompok individu yang memiliki ikatan darah, perkawinan atau adopsi, tinggal dalam satu lingkungan rumah tangga, saling berinteraksi dan menjalankan fungsi sesuai dengan perannya masing-masing, saling mendukung dalam membentuk dan melestarikan nilai budaya yang diyakini

c. Marilyn M. Friedman (2022)

Keluarga merupakan kumpulan dua orang atau lebih yang hidup bersama dengan ikatan emosional, kedekatan, serta identitas yang saling mempengaruhi antar anggota keluarga

d. Undang-Undang Republik Indonesia No 17 (2023)

Keluarga sebagai unit utama dalam upaya kesehatan yang berperan dalam menciptakan interaksi positif antar anggota keluarga untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa keluarga merupakan sistem sosial yang terdiri dari kumpulan individu yang memiliki hubungan emosional, biologis, hukum, sosial, hidup bersama dan saling berinteraksi untuk menjalankan fungsi keluarga mencapai kesejahteraan dan kesehatan anggota keluarga.

2. Konsep Keluarga

Keluarga dipandang sebagai unit pelayanan kesehatan. Dalam konsep sistem keluarga, perubahan yang terjadi pada salah satu anggota akan sangat berpengaruh terhadap anggota keluarga lain serta mempengaruhi keseimbangan keluarga secara keseluruhan. Keluarga berperan dalam membentuk perilaku kesehatan, pengambilan keputusan, serta mempertahankan kesehatan anggota keluarga. Selain itu keluarga menjadi lingkungan pertama individu untuk mendapatkan nilai, norma, pola perilaku serta dukungan psikologis dan sosial.

Konsep keluarga dalam keperawatan memiliki beberapa karakteristik utama yaitu:

1. Keluarga merupakan sistem terbuka yang selalu melakukan interaksi dengan lingkungan sekitar
2. Keluarga memiliki struktur, peran, nilai dan juga norma tertentu
3. Antar anggota keluarga memiliki ketergantungan satu dan lainnya dan juga saling mempengaruhi
4. Keluarga berfungsi memenuhi kebutuhan anggota keluarga
5. Keluarga memiliki kemampuan beradaptasi terhadap adanya perubahan dan stressor.

Keberhasilan pelayanan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh individu, tetapi juga oleh kemampuan keluarga dalam menjalankan fungsi kesehatannya (Fadhilah & Yuliarsih, 2024).

3. Tipe Keluarga

Keefektifan pemberian asuhan keperawatan dapat terlihat dari pemahaman perawat tentang tipe keluarga. Hal ini penting untuk mendukung keterlibatan keluarga dalam meningkatkan derajat kesehatan di setiap anggota keluarga. Setiap tipe keluarga memiliki perbedaan karakteristik, struktur, pola peran serta mekanisme coping sehingga memerlukan adanya pendekatan keperawatan yang berbeda. Secara umum, tipe keluarga dibedakan menjadi dua kelompok besar yaitu tipe keluarga tradisional dan tipe keluarga modern atau non-tradisional.

Terdapat beberapa tipe keluarga tradisional yang umum dikenal dalam keperawatan keluarga, salah satunya adalah keluarga inti (*nuclear family*). Struktur keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, dan anak dalam satu kesatuan. Ikatan yang terbentuk pada hubungan pernikahan yang sah, sementara anak berasal dari hubungan biologis maupun melalui jalur adopsi yang legal. Kedekatan secara fisik dalam keluarga ini dapat menghasilkan pola komunikasi yang

intensif. Keluarga inti juga dapat berkembang menjadi keluarga besar (*extended family*). Tipe ini terdiri dari keluarga inti ditambah dengan anggota lintas generasi seperti kakek-nenek, paman-tante, sepupu atau kerabat lain yang tinggal dalam satu rumah. Dalam praktik keperawatan, tipe keluarga *extended* menjadi sangat kuat dalam penyediaan dukungan sosial dan emosional saat terdapat anggota keluarga yang mengalami permasalahan kesehatan yang lebih kompleks. (Qasim et al., 2025).

Rumah tangga yang hanya terdiri dari sepasang suami istri tanpa adanya kehadiran anak atau keturunan dikenal sebagai keluarga pasangan (*dyad family*). Kondisi ini bersifat sementara seperti pada pasangan yang baru menikah atau sengaja menunggu kehamilan, namun dapat juga terjadi pada pasangan yang belum atau memilih tidak memiliki anak. Jika pasangan tersebut memutuskan untuk mendapatkan anak melalui proses adopsi, maka tipe keluarga berganti menjadi keluarga adopsi (*adoption family*). Tanggungjawab dan pengasuhan orang tua kandung akan beralih kepada pasangan atau orang tua angkat.

Tantangan perkembangan jaman dan ekonomi, membentuk tipe *commuter family*. Tipe ini dicirikan oleh pasangan suami istri yang tinggal terpisah di kota atau wilayah berbeda guna mengakomodasi tuntutan pekerjaan maupun pendidikan. Komitmen pernikahan tetap terjaga dan mereka dapat memanfaatkan waktu tertentu untuk berkumpul bersama. Apabila komitmen pernikahan tidak bisa dipertahankan, maka akan berujung pada perceraian. Struktur keluarga akan berekonstruksi menjadi keluarga binuklir (*bicnuclear family*). Pada tipe struktur ini anak-anak tidak kehilangan figur orang tua dan tumbuh menjadi bagian dari dua rumah tangga inti yang berbeda yaitu rumah tangga ibu atau rumah tangga ayah yang telah hidup berpisah.

Perkembangan struktur sosial masyarakat modern memunculkan variasi bentuk keluarga non-tradisional. Salah satu bentuk keluarga modern yang paling kompleks dan sering dijumpai dalam tatanan keperawatan keluarga salah satunya adalah *reconstituted nuclear*. Tipe keluarga ini terbentuk ketika individu yang mengalami perceraian atau kematian pasangan memutuskan untuk membentuk keluarga inti baru dengan menyatukan anak-anak dari hubungan sebelumnya ke dalam satu rumah tangga. Struktur keluarga ini terdapat anak kandung, anak tiri ataupun kombinasi keduanya sehingga proses adaptasi dan penyesuaian peran sering menjadi kendala.

Keluarga dengan orang tua tiri (*the step parent family*). Keluarga ini menitikberatkan keberadaan orang tua tiri dalam struktur keluarga yaitu ketika anak tinggal bersama dengan orang tua kandung dan pasangan baru yang

berperan sebagai orang tua tiri. Dinamika yang sering muncul berkaitan dengan penyesuaian hubungan emosional, penerimaan anggota baru dan ketidakjelasan batas peran pengasuhan anak. Tipe kedua keluarga tersebut yaitu *reconstituted nuclear* dan *the step parent family* sama-sama terbentuk dari hasil pernikahan kembali, namun untuk *reconstituted nuclear family* lebih menggambarkan pembentukan kembali keluarga inti baru sedangkan *the step parent family* berfokus pada hubungan dan interaksi antara anak dengan orang tua tiri dalam suatu keluarga.

Bentuk keluarga non-tradisional berikutnya yang memiliki kerentanan tinggi terhadap masalah kesehatan adalah *the unmarried teenage mother*. Struktur keluarga ini berfokus pada ibu remaja yang membesarkan anak secara mandiri diluar hubungan pernikahan. Secara perkembangan, kematangan emosional belum mencapai kematangan dan harus berhadapan dengan adanya keterbatasan finansial, isolasi sosial hingga putus sekolah. Kondisi ini tidak jarang membuat gangguan kesehatan mental ibu serta risiko keterlambatan tumbuh kembang anak akibat kurangnya pengetahuan pola asuh yang efektif.

Seiring dengan adanya pergeseran sosiologis, tipe keluarga gay dan lesbian menjadi bagian dari tipe keluarga modern. Tipe ini di definisikan sebagai dua individu yang memiliki orientasi seksual sesama jenis, memiliki komitmen hidup bersama, mengelola rumah tangga dan ikut membesarkan anak melalui proses adopsi. Stressor utama yang sering dialami adalah stigma sosial, diskriminasi lingkungan serta keterbatasan dalam akses perlindungan secara hukum.

Cohabiting family adalah dua orang dewasa yang tinggal bersama dalam satu rumah dan berbagi peran suami istri namun tidak melakukan pernikahan secara hukum maupun agama. Masalah yang sering ditemukan pada tipe keluarga ini adalah tidak adanya jaminan legalitas yang kuat sehingga menjadi rentan mengalami ketidakstabilan finansial jangka panjang, kesulitan administrasi saat mengurus jaminan kesehatan ataupun akta kelahiran.

Tipe keluarga modern lain yang juga memerlukan intervensi keperawatan keluarga adalah keluarga asuh (*foster family*). Hubungan dalam keluarga asuh didasarkan penempatan satu atau beberapa anak oleh lembaga sosial atau negara untuk dirawat sementara oleh orang dewasa yang tidak memiliki hubungan darah biologis dengan anak tersebut. Tantangan terbesar adalah pembentukan kelekatan emosional yang sehat. Anak yang berada di keluarga asuh tidak jarang membawa trauma masa lalu akibat penelantaran atau kekerasan dari orang tua kandung mereka, sementara, orang tua asuh dituntut

siap menghadapi stres perpisahan ketika masa kontrak asuh selesai dan anak harus dikembalikan.

Tipe keluarga jaringan kelompok (*group network family*). Tipe ini terbentuk dari kesepakatan beberapa keluarga inti yang memilih hidup berdekatan dalam suatu komunal, terikat aturan atau norma kelompok yang sama, serta berkomitmen saling berbagi mempergunakan barang, sumber ekonomi, hingga kendaraan bersama. Karakteristik yang paling menonjol adalah adanya pembagian tanggung jawab kolektif dalam membesarkan dan mendidik anak-anak.

4. Fungsi Keluarga dalam Kesehatan

Keluarga berperan penting mempertahankan serta meningkatkan derajat kesehatan bagi anggota keluarganya. Keluarga juga sebagai sistem pendukung utama pembentukan perilaku sehat, pengambilan keputusan kesehatan serta memberikan perawatan bagi anggota keluarga yang sakit. Kemampuan yang dimiliki keluarga untuk menjalankan fungsi kesehatan akan mempengaruhi status kesehatan seluruh anggota keluarga terutama bagi keluarga yang masuk dalam kelompok rentan.

Keluarga memiliki beberapa fungsi utama yaitu: (Friedman, 2010)

- a. Fungsi afektif berhubungan dengan kemampuan seluruh anggota keluarga dalam memberikan kasih sayang, rasa aman nyaman, perhatian, dukungan emosional hingga membentuk hubungan yang harmonis. Hal ini sangat penting untuk mendukung kesehatan mental serta menjaga perkembangan psikososial bagi seluruh anggota keluarga.
- b. Fungsi sosialisasi merupakan fungsi keluarga untuk membentuk perilaku, kepribadian, nilai, norma serta kebiasaan anggota keluarga yang didapatkan dari proses interaksi sosial.
- c. Fungsi reproduktif berhubungan dengan kemampuan keluarga untuk melanjutkan keturunan serta mempertahankan generasi. Fungsi ini juga mencakup pemeliharaan kesehatan reproduksi, pengasuhan anak serta pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi keluarga.
- d. Fungsi ekonomi dikaitkan dengan kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan dasar seperti papan, sandang, pangan, pendidikan hingga pemenuhan pelayanan kesehatan. Kondisi perekonomian keluarga mempengaruhi kemampuan keluarga dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan antar anggota keluarga.
- e. Fungsi perawatan kesehatan berhubungan dengan kemampuan keluarga menjaga kondisi kesehatan, melakukan pencegahan terhadap penyakit,

melakukan perawatan kesehatan sederhana, serta memanfaatkan fasilitas layanan kesehatan dengan optimal. Terdapat lima tugas kesehatan keluarga yang harus mampu dilakukan yaitu: (Astuti et al., 2024)

- 1) Keluarga mengenal masalah kesehatan dan menyadari adanya perubahan kondisi yang dialami oleh anggota keluarga
- 2) Keluarga dapat mengambil keputusan tindakan kesehatan yang tepat dan sesuai untuk mengatasi masalah kesehatan yang dialami
- 3) Keluarga mampu memberikan perawatan anggota keluarga yang sakit. Keluarga dalam hal ini mampu memberikan perawatan, memberikan dukungan fisik, emosional, sosial dan spiritual kepada anggota keluarga yang sedang mengalami gangguan kesehatan
- 4) Keluarga mampu memodifikasi lingkungan rumah yang sehat untuk menunjang kesehatan keluarga. Lingkungan rumah yang sehat mencakup tersedianya pencahayaan yang cukup, sirkulasi udara optimal, akses air bersih, pengelolaan limbah yang baik dan bebas dari vektor penyakit
- 5) Keluarga mampu memanfaatkan atau menggunakan fasilitas kesehatan yang tepat untuk mempertahankan dan meningkatkan kesehatan anggota keluarga

5. Tahap dan Tugas Perkembangan Keluarga

Kegagalan keluarga dalam pemenuhan tugas perkembangan di setiap fasenya dapat memicu stress dan gangguan fungsi keluarga. Kemampuan penyelesaian tugas ini menjadi penentu utama dalam mempertahankan keseimbangan dan status kesehatan secara menyeluruh. Pendekatan dalam praktik keperawatan keluarga menurut Duvall memandang dinamika dalam keluarga secara bertahap sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anggota keluarga (Friedman, 2010).

- a. Keluarga pasangan baru dimulai dari pasangan menikah hingga hamil anak pertama. Tahap ini prioritas utama adalah penyesuaian peran, membangun komunikasi yang efektif, mempertahankan hubungan yang harmonis hingga mempersiapkan masa depan keluarga
- b. Keluarga dengan anak bayi dimulai sejak kelahiran anak pertama hingga anak berusia 30 bulan atau 2,5 tahun. Keluarga akan mulai beradaptasi terhadap peran menjadi orang tua, memenuhi kebutuhan bayi serta mempertahankan hubungan intim dengan pasangan
- c. Keluarga dengan anak prasekolah terjadi saat anak pertama berusia 2,5 tahun hingga 6 tahun. Pada fase ini tanggung jawab orang tua adalah dengan

mengoptimalkan tumbuh kembang, memberikan stimulasi psikomotorik, menerapkan batasan dan aturan dalam rumah tangga.

- d. Keluarga dengan anak usia sekolah dimulai saat anak pertama mulai menjalankan proses belajar di jenjang pendidikan resmi. Keluarga bertanggungjawab dalam mendukung proses pendidikan, membangun hubungan sosial serta mempertahankan komunikasi keluarga dengan baik
- e. Keluarga dengan anak remaja ditandai dengan adanya perubahan fisik, emosional dan sosial pada anak remaja. Tahapan ini keluarga perlu memberikan dukungan secara emosional, membantu remaja untuk mencapai kemandirian serta mempertahankan komunikasi terbuka dan efektif
- f. Keluarga dengan anak dewasa dimulai ketika anak pertama mulai meninggalkan rumah untuk bekerja, menikah atau mulai hidup mandiri. Keluarga pada tahap ini perlu untuk beradaptasi terhadap perubahan struktur keluarga dan tetap mempertahankan hubungan emosional antar anggota keluarga
- g. Keluarga dengan usia pertengahan ditandai dengan adanya proses penuaan pada pasangan. Tahap ini mulai terdapat perubahan peran, persiapan masa pensiun, dan kemungkinan untuk merawat orang tua dengan usia lanjut. Tantangan yang sering dihadapi adalah adaptasi terhadap penurunan fungsi fisik serta potensi beban ganda saat merawat lansia
- h. Keluarga dengan lanjut usia merupakan tahapan paling akhir dimana pasangan sudah memasuki masa tua. Tugas perkembangan fokus pada penerimaan kemunduran kondisi fisik, coping kehilangan pasangan atau teman-teman, penyesuaian gaya hidup pascapensiun serta mempertahankan derajat kesehatan optimal.

Keberhasilan dalam melewati setiap fase bergantung pada pemenuhan fungsi internal yang wajib dipenuhi. Secara umum, tugas perkembangan keluarga meliputi:

- a. Mempertahankan hubungan harmonis antaranggota keluarga
- b. Menyesuaikan diri terhadap adanya perubahan peran dan struktur keluarga
- c. Memenuhi kebutuhan fisik, psikologis, sosial dan spiritual anggota keluarga
- d. Membantu proses tumbuh kembang anggota keluarga sesuai tahap perkembangan
- e. Mempertahankan dan meningkatkan kesehatan anggota keluarga
- f. Mengembangkan mekanisme coping keluarga terhadap stress dan perubahan kehidupan
- g. Mempersiapkan anggota keluarga menghadapi tugas perkembangan berikutnya

Perawat perlu memahami tahap dan tugas perkembangan keluarga untuk membantu perawat dalam mengidentifikasi masalah kesehatan, menentukan kebutuhan keluarga serta merencanakan intervensi sesuai dengan tahap perkembangan keluarga.

C. Konsep Keperawatan Keluarga

1. Definisi Keperawatan Keluarga

Keperawatan keluarga adalah bentuk layanan keperawatan yang mengintegrasikan unit keluarga sebagai subjek sekaligus menjadi fokus intervensi utama. Praktik keperawatan keluarga memahami bahwa keluarga merupakan suatu sistem yang saling memiliki hubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Ketika terdapat salah satu anggota keluarga yang memiliki masalah kesehatan maka akan berdampak pada anggota keluarga lainnya serta dapat merubah fungsi keluarga (Qasim, 2025). Beban yang muncul seperti beban secara emosional, tenaga hingga finansial akan menuntut anggota keluarga lain beradaptasi dengan peran baru.

Keluarga berperan krusial membentuk status kesehatan pada setiap anggotanya. Tujuan pemberian intervensi pada keperawatan keluarga adalah untuk mengoptimalkan kemandirian sekaligus meningkatkan kemampuan pemeliharaan kesehatan sehingga dapat meningkatkan status kesehatan seluruh anggota keluarga (Bailon & Maglaya, 1997). Keperawatan keluarga menekankan pada pendekatan secara holistik yang mencakup aspek biologis, psikologis, sosial, budaya dan juga spiritual.

Penerima layanan perawatan kesehatan keluarga terdiri dari tiga tingkatan yaitu pada tingkat individu, tingkat keluarga dan tingkat masyarakat. Perawatan kesehatan keluarga pada tingkat individu mengarah pada masalah kesehatan individu yang fokus pada pemecahan masalah yang dialami seperti mengatasi keluhan dan kesembuhan individu secara personal. Individu akan dijadikan sebagai klien utama. Keluarga pada tingkat ini tidak selalu diikutsertakan dalam pemecahan masalah. Pada tingkat keluarga, perawatan mengarah kepada kesatuan individu yang terikat oleh hubungan darah, perkawinan atau adopsi yang tinggal dalam satu rumah. Intervensi perawatan diberikan kepada anggota keluarga yang sakit dan juga menyediakan sistem pendukung. Perawatan kesehatan keluarga pada tingkat masyarakat berfokus pada pencegahan penyakit, penyuluhan, pemberian support sistem bagi anggota keluarga.

2. Sasaran Keperawatan Keluarga

Sasaran utama layanan keperawatan keluarga adalah sebagai satu kesatuan sistem yang berperan dalam mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan anggota keluarga. Pelayanan keperawatan keluarga tidak hanya ditujukan kepada individu yang sakit, tetapi juga kepada seluruh anggota keluarga, kelompok berisiko serta lingkungan keluarga yang memengaruhi status kesehatan (Friedman, 2010). Sasaran keperawatan keluarga meliputi:

- a. Keluarga sehat, menjadi sasaran layanan keperawatan untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan status kesehatan melalui upaya promotif dan preventif
- b. Keluarga dengan risiko masalah kesehatan, ditujukan kepada keluarga yang memiliki faktor risiko tertentu seperti penyakit keturunan, kondisi lingkungan tidak sehat, perilaku hidup tidak sehat maupun adanya masalah psikososial. Keluarga ini memerlukan perhatian khusus dalam layanan keperawatan keluarga
- c. Keluarga dengan anggota yang mengalami masalah kesehatan. Layanan diberikan kepada keluarga yang memiliki anggota dengan penyakit akut, kronis, degeneratif, gangguan mental maupun dengan kondisi ketergantungan tertentu
- d. Keluarga yang memiliki permasalahan dalam menjalankan tugas perkembangan, perubahan struktur keluarga maupun adaptasi stressor kehidupan sehingga membutuhkan dukungan untuk mempertahankan fungsi keluarga
- e. Keluarga rentan dengan kondisi sosial ekonomi rendah, keluarga lansia, keluarga dengan disabilitas, atau keluarga yang memiliki keterbatasan akses layanan kesehatan secara komprehensif

Pelayanan keperawatan keluarga diharapkan mampu membantu keluarga mencapai kemandirian dalam pemeliharaan kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup pada seluruh anggota keluarga.

3. Ruang lingkup Keperawatan Keluarga

Ruang lingkup keperawatan keluarga mencakup seluruh layanan kesehatan yang diberikan kepada keluarga dalam kondisi sehat maupun sakit (Padila, 2020). Pelayanan yang diberikan mencakup upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan resosialitatif.

- a. Upaya promotif diberikan untuk meningkatkan kesehatan keluarga yang dilakukan melalui kegiatan edukasi kesehatan, peningkatan gizi keluarga, pemeliharaan lingkungan sehat, pemeliharaan kesehatan individu dan keluarga, pemberian edukasi seksualitas dan reproduksi, peningkatan aktivitas fisik, pencegahan penyakit menular serta berhenti merokok
- b. Upaya preventif dilakukan untuk mencegah adanya masalah dan gangguan kesehatan dengan langkah pemberian vaksinasi, pemeriksaan kesehatan berkala, perawatan kesehatan ibu dan anak, edukasi cuci tangan, hingga melakukan kunjungan rumah
- c. Upaya kuratif dilakukan untuk memberikan pengobatan bagi anggota keluarga yang sakit, memberikan perawatan, pendampingan dan mencegah terjadinya komplikasi. Tindakan yang dilakukan meliputi memberikan pendampingan pasien dan keluarga untuk mematuhi terapi pengobatan, melakukan observasi perkembangan penyakit dan deteksi tanda komplikasi, melatih keluarga agar mampu mengambil keputusan medis yang sesuai serta memberikan perawatan secara langsung seperti membantu mobilisasi dan perawatan luka
- d. Upaya rehabilitatif dilakukan untuk membantu memulihkan fungsi fisik, psikologis dan sosial anggota keluarga yang mengalami penyakit kronis, ataupun kecacatan. Intervensi yang dapat dilakukan seperti melatih rentang gerak, memberikan konseling dan dukungan mental kepada keluarga dan anggota keluarga yang sakit, memberikan edukasi penyesuaian peran pada keluarga (Jannah & Irawati, 2024)
- e. Upaya resosialitatif diberikan untuk mengembalikan anggota keluarga yang memiliki masalah kesehatan disertai stigma sosial agar dapat kembali bersosialisasi normal. Fokus layanan yang diberikan adalah pada penerimaan lingkungan terdekat dan mencegah terjadinya isolasi sosial. Intervensi yang dilakukan meliputi edukasi keluarga dan masyarakat terkait dengan masalah kesehatan yang dialami, membangun rasa percaya diri dan memberikan dukungan emosional, serta membantu anggota keluarga yang sebelumnya diasingkan agar dapat melakukan interaksi dan beraktivitas normal

D. Prinsip dan Pendekatan Keperawatan Keluarga

Pelaksanaan intervensi keperawatan keluarga terarah pada keluarga dalam satu kesatuan sistem yang utuh. Pendekatan keperawatan keluarga bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan yang tidak hanya fokus pada individu

namun juga memperhatikan kondisi, kemampuan serta keterlibatan anggota keluarga dalam mempertahankan kesehatan.

1. Family Center Nursing (FCN)

Family Center Nursing (FCN) merupakan salah satu pendekatan keperawatan yang menempatkan keluarga sebagai pusat layanan kesehatan, dan unit yang aktif dalam proses perawatan dan pengambilan keputusan. Asuhan keperawatan tidak hanya diberikan kepada anggota keluarga yang sakit tetapi melibatkan seluruh anggota keluarga yang berada di dalamnya untuk bersama melakukan intervensi. Perawat bertindak sebagai fasilitator untuk melakukan pengecekan dan memonitoring kemampuan anggota keluarga untuk merawat dan mempertahankan kesehatan keluarga.

Keberhasilan implementasi didasarkan dari empat dasar yaitu:

- a. Penghormatan dan martabat, dimana pada aspek ini perawat memerlukan kemampuan untuk mendengarkan, menghormati pilihan, latar belakang budaya, serta keyakinan dari pasien dan keluarga
- b. Adanya keterbukaan dari tenaga kesehatan untuk menyampaikan informasi lengkap, jujur, akurat dan tepat agar keluarga dapat berpartisipasi dalam mengambil keputusan klinis
- c. Keluarga didorong untuk melakukan partisipasi penuh dan mendukung keterlibatan langsung dalam memberikan perawatan sesuai tingkat kenyamanan
- d. Perawat melakukan kolaborasi bersama dengan keluarga dalam hal pengembangan kebijakan program, evaluasi pelayanan serta pelaksanaan asuhan

Pendekatan FCN yang melibatkan keluarga terbukti tidak hanya menyembuhkan secara fisik namun melindungi kesejahteraan psikologis keluarga dan mempersiapkan anggota keluarga menjadi caregiver yang mandiri di rumah.

2. Pendekatan Holistik

Pendekatan holistik memandang keluarga secara menyeluruh dari segala aspek biologis, psikologis, sosial, budaya dan spiritual. Masalah kesehatan yang dialami keluarga tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi fisik namun juga dipengaruhi oleh kondisi emosional, lingkungan sosial budaya serta keyakinan yang ada pada keluarga. Perawat perlu memahami faktor-faktor tersebut agar dapat memberikan layanan komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan keluarga. Pendekatan secara holistik membantu perawat dalam

melakukan identifikasi masalah kesehatan lebih mendalam serta menentukan intervensi yang sesuai dengan kondisi.

3. Promotif dan Preventif dalam Keluarga

Pendekatan promotif dalam intervensi keperawatan keluarga bertujuan meningkatkan kemampuan keluarga untuk mempertahankan kesehatan dengan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat. Intervensi yang biasa dilakukan adalah dengan pemberian edukasi kesehatan, pemenuhan gizi seimbang, aktivitas fisik hingga pengelolaan stress. Pendekatan preventif dilakukan dengan tujuan mencegah terjadinya penyakit dan komplikasi kesehatan. Hal ini dilakukan melalui pemberian vaksinasi, pemeriksaan kesehatan berkala, pengendalian risiko penyakit hingga melakukan deteksi masalah kesehatan secara diri. Pendekatan promotif dan preventif diharapkan dapat membantu keluarga menjadi lebih mandiri dan berkelanjutan dalam menjaga kesehatan anggota keluarga.

E. Peran Perawat dalam Keperawatan Keluarga

Perawat memiliki peranan penting untuk membantu keluarga mencapai derajat kesehatan yang optimal. Perawat tidak hanya memberikan layanan kesehatan kepada individu yang sakit tetapi juga membantu seluruh anggota keluarga yang ada didalamnya untuk dapat meningkatkan kemampuan dalam memelihara kesehatan secara mandiri. Pelaksanaan asuhan keperawatan keluarga dilakukan melalui peran profesional sesuai dengan kebutuhan keluarga.

Perawat berperan sebagai edukator untuk memberikan edukasi kesehatan terkait pencegahan penyakit, cara perawatan kesehatan di rumah, pola hidup sehat dan pemanfaatan fasilitas layanan kesehatan (Lidiyawati & Sukabumi, 2025). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan keluarga dalam menjalankan kesehatan anggota keluarga. Selain itu, perawat sebagai caregiver berkewajiban memberikan asuhan keperawatan secara langsung melalui intervensi keperawatan. Perawat dalam hal ini membantu keluarga untuk melakukan pemantauan kondisi kesehatan serta memberikan dukungan secara fisik dan emosional selama menjalani proses pengobatan.

Perawat berperan sebagai konselor, dimana membantu keluarga dalam mengatasi masalah kesehatan fisik maupun psikososial (Singarimbun et al., 2024). Perawat memberikan dukungan emosional, membantu keluarga dalam mengenali masalah, serta memfasilitasi pengambilan keputusan kesehatan dengan tepat. Perawat juga memiliki peran sebagai koordinator dan kolaborator dalam melakukan koordinasi layanan kesehatan dan bekerjasama dengan tenaga

kesehatan lain dengan tujuan memberikan layanan kesehatan yang komprehensif dan berkesinambungan bagi keluarga.

F. Referensi

- Aliffatunisa, F., Putri, N. R. I. A. T., Dewi, F. K., & Apriliyani, I. (2021). Hubungan Aspek Dukungan Sosial Keluarga terhadap Tekanan Darah Terkontrol pada Lansia dengan Hipertensi. *Jurnal Keperawatan Rafflesia*, 3(2), 1–10. <https://doi.org/10.33088/jkr.v3i2.695>
- Astuti, V. W., Yan, L. S., & Putri, N. R. I. A. T. (2024). *Asuhan Keperawatan Keluarga Pada Anak Usia Sekolah (Aus) Dengan Berbagai Masalah Kesehatan (Pertama)*. Rizmedia Pustaka Indonesia.
- Fadhilah, N., & Yuliarsih, L. (2024). *Buku Ajar Keperawatan Keluarga Untuk S1 Keperawatan*. PT Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta.
- Friedman, M. M. (2010). *Keperawatan Keluarga Riser, Teori, & Praktik* (5th ed.). EGC.
- Jannah, St. N., & Irawati. (2024). Peran Perawat dalam Melaksanakan Konseling Kesehatan pada Masyarakat. *Idea Pengabdian Masyarakat*, 4(3), 188–192. <https://ideapengabdianmasyarakat.ideajournal.id/index.php/ipm/article/view/363>
- Kaakinen, J. R., Coehlo, P. D., Steele, R., Tabacco, A., & Hanson, S. M. H. (2015). *Family Health Care Nursing: Theory, Practice, and Research* (Fifth Edition). F.A. Davis Company.
- Lidiyawati, H., & Sukabumi, S. (2025). Integration of Community Nursing in Family Empowerment Program to Improve Adolescent Reproductive Health. *Indonesian Journal of Public Health*, 2(2), 119–126. <https://doi.org/10.62872/2thpj312>
- Padila. (2020). *Keperawatan Keluarga dan Komunitas*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Qasim, M., Holida, S. S., Insani, N., Juliana, D., Suhariyanti, E., Purwanti, N. S., Susyanti, E., & Syafridawita, Y. (2025). *Bunga Rampai Asuhan Keperawatan Keluarga Komprehensif: Pendekatan Praktis Berbasis Evidence-Based Practice (EBP)* (N. Fadhilah, Ed.; Vol. 1). Optimal Untuk Negeri.
- Singarimbun, R. J., Kes, M., Dan, F., Grace, N., Tarigan, S., & Kep, N. (2024). *Buku Ajar: Keperawatan Keluarga Dan Komunitas*. PT Yapindo Jaya Abadi.
- Stanhope, M., & Lancaster, J. (2022). *Foundations for Population Health in Community/Public Health Nursing* (Sixth Edition). Elsevier.

CHAPTER 2

TUGAS KESEHATAN KELUARGA DALAM MERAWAT ANGGOTA KELUARGA PADA MASALAH HIPERTENSI

Rizqy Iftitah Alam, S.Kep., Ns., M.Kes.

A. Pendahuluan

Hipertensi merupakan salah satu penyakit tidak menular yang menjadi masalah kesehatan utama di dunia karena berkontribusi besar terhadap peningkatan angka morbiditas dan mortalitas akibat penyakit kardiovaskular. Hipertensi juga dikenal sebagai *silent killer* karena sebagian besar penderita tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Namun, jika tidak ditangani maka dapat memicu terjadinya gagal ginjal, stroke, demensia, gagal jantung, serangan jantung, gangguan penglihatan, serta komplikasi lainnya (Rizqy Iftitah Alam, 2025).

Menurut *World Health Organization*, lebih dari satu miliar penduduk dunia mengalami hipertensi dan sebagian besar dari jumlah populasi tersebut berada di negara berkembang dengan tingkat pengendalian tekanan darah yang masih rendah ((WHO) World Health Organization, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa hipertensi bukan hanya sekedar menjadi masalah individu saja, tetapi juga menjadi masalah keluarga dan masyarakat karena membutuhkan pengelolaan jangka panjang dan perubahan perilaku kesehatan secara terus-menerus.

Di Indonesia, prevalensi kejadian hipertensi masih terus meningkat seiring dengan adanya perubahan pola hidup masyarakat modern. Pola makan tinggi garam dan lemak, kurang aktivitas fisik, obesitas, merokok, konsumsi alkohol, serta stres psikologis menjadi faktor risiko utama dari hipertensi (Kemenkes RI, 2024). Selain itu, jumlah lansia yang terus mengalami peningkatan juga menyebabkan meningkatnya angka kejadian hipertensi akibat perubahan degeneratif pada sistem kardiovaskular (Potter, 2021).

Hipertensi memberikan dampak multidimensional baik terhadap kehidupan penderita maupun keluarganya. Penyakit kronis yang berlangsung lama dapat menyebabkan berbagai perubahan, seperti perubahan peran dalam keluarga, peningkatan beban ekonomi, gangguan psikologis, penurunan produktivitas, dan penurunan kualitas hidup pasien (Stanhope, 2022). Dalam kondisi tersebut, dibutuhkan peran keluarga sebagai sistem pendukung utama dalam membantu pengelolaan hipertensi.

Marilyn M. Friedman dalam bukunya yang berjudul *"Family Nursing: Research, Theory, and Practice"* mengatakan bahwa keluarga merupakan unit sosial yang memiliki fungsi penting dalam mempertahankan kesehatan anggota keluarganya melalui dukungan emosional, pengambilan keputusan kesehatan, serta pelaksanaan perawatan sehari-hari (Friedman, 2020). Dengan adanya dukungan keluarga terbukti mampu meningkatkan kepatuhan pengobatan, *self-management*, serta kualitas hidup pasien hipertensi (Shahin, 2021); (Kessek, 2026).

Konsep tugas kesehatan keluarga menjadi dasar yang penting khususnya dalam praktik keperawatan keluarga. Tugas kesehatan keluarga meliputi kemampuan mengenali masalah kesehatan, mengambil keputusan tindakan kesehatan yang tepat, merawat anggota keluarga yang sakit, memodifikasi lingkungan yang mendukung kesehatan, serta memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan secara optimal (Friedman, 2020). Pelaksanaan tugas kesehatan keluarga yang baik dalam suatu keluarga akan membantu meningkatkan keberhasilan pengendalian hipertensi dan mencegah terjadinya komplikasi.

Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan keluarga dalam membantu penderita mengelola penyakit hipertensinya terbukti mampu meningkatkan kepatuhan pengobatan serta memperbaiki perilaku hidup sehat (Chrismilasari, 2024). Sementara itu, hasil penelitian dari (Rahayu, 2023) bahwa pelibatan keluarga dalam pengelolaan penyakit hipertensinya dapat membantu meningkatkan *self-efficacy* pasien, serta membantu mempertahankan kontrol tekanan darah dalam jangka panjang.

B. Konsep Keluarga dalam Keperawatan

Keluarga memiliki beberapa fungsi utama, diantaranya fungsi afektif, fungsi sosialisasi, fungsi reproduksi, fungsi ekonomi, dan fungsi perawatan kesehatan. Fungsi-fungsi tersebut saling berkaitan dalam mendukung kesejahteraan anggota keluarga (Friedman, 2020).

Fungsi afektif keluarga berkaitan dengan kemampuan keluarga dalam memberikan kasih sayang, perhatian, rasa aman, serta dukungan emosional kepada anggota keluarga. Pada penderita hipertensi, dukungan emosional sangat dibutuhkan. Hal tersebut dikarenakan penyakit kronis yang sering menimbulkan kecemasan, stres, dan ketakutan terhadap komplikasi penyakit (Wright, 2021).

Fungsi sosialisasi keluarga berkaitan dengan pembentukan perilaku serta kebiasaan dari setiap anggota keluarga. Kebiasaan hidup sehat seperti pola makan rendah garam, olahraga teratur, berhenti merokok, dan pengelolaan stres dapat dibentuk melalui proses sosialisasi yang ada di dalam keluarga (Potter, 2021).

Fungsi ekonomi keluarga berkaitan dengan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan finansial anggota keluarga, termasuk kebutuhan pengobatan serta perawatan kesehatan. Hipertensi yang membutuhkan pengobatan jangka panjang sering kali meningkatkan beban ekonomi keluarga terutama apabila telah terjadi komplikasi yang ditimbulkan dari hipertensi tersebut (Stanhope, M., & Lancaster, J., 2022).

Sementara itu, fungsi perawatan kesehatan keluarga berkaitan dengan kemampuan keluarga dalam mengenali masalah kesehatan, mengambil keputusan kesehatan, merawat anggota keluarga yang sakit, memodifikasi lingkungan, dan memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan (Friedman, 2020).

Dalam teori sistem keluarga, keluarga dipandang sebagai satu kesatuan yang saling bergantung satu sama lain. Perubahan kondisi kesehatan satu anggota keluarga akan mempengaruhi seluruh anggota keluarga lainnya. Oleh karena itu, pendekatan keperawatan keluarga tidak hanya berfokus pada individu yang sakit tetapi juga pada seluruh sistem keluarga (Wright L. M., 2021).

C. Konsep Tugas Kesehatan Keluarga

Tugas kesehatan keluarga merupakan kemampuan keluarga dalam menjalankan fungsi kesehatan. Hal tersebut bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan status kesehatan anggota keluarganya (Friedman, 2020). Konsep ini yang menjadi dasar dalam praktik keperawatan keluarga karena keluarga merupakan sistem pendukung utama bagi individu yang mengalami masalah kesehatan.

Marilyn M. Friedman mengemukakan bahwa terdapat lima tugas kesehatan keluarga yang harus mampu dijalankan oleh keluarga. Kelima tugas kesehatan tersebut antara lain mengenali masalah kesehatan, mengambil keputusan tindakan kesehatan, merawat anggota keluarga yang sakit, memodifikasi lingkungan, dan memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan (Friedman, 2020).

1. Mengenali Masalah Kesehatan

Tugas kesehatan keluarga yang pertama adalah mengenali masalah kesehatan, yaitu kemampuan keluarga dalam memahami tanda dan gejala penyakit, faktor risiko, penyebab, serta komplikasi yang mungkin terjadi. Pada kasus hipertensi, keluarga perlu memahami bahwa tekanan darah tinggi sering kali tidak menimbulkan gejala namun dapat menyebabkan komplikasi yang serius apabila tidak dikontrol (Smeltzer, S. C., Bare, B., Hinkle, J. L., & Cheever, K. H., 2021).

Pengetahuan keluarga mengenai hipertensi sangat mempengaruhi kemampuan keluarga dalam melakukan deteksi dini dan pencegahan

komplikasi. Rendahnya pengetahuan keluarga dapat menyebabkan terjadinya keterlambatan pengobatan serta rendahnya kepatuhan terhadap terapi (Potter, 2021).

2. Mengambil Keputusan Tindakan Kesehatan

Keluarga harus mampu mengambil keputusan kesehatan yang tepat berdasarkan kondisi dari anggota keluarganya. Pengambilan keputusan ini meliputi keputusan untuk memeriksakan anggota keluarga ke fasilitas kesehatan, menjalani pengobatan, mempertahankan perubahan gaya hidup sehat, dan melakukan kontrol rutin (Friedman, 2020). Dalam pengelolaan hipertensi, dukungan keluarga dalam pengambilan keputusan terbukti mampu meningkatkan kepatuhan pengobatan dan keberhasilan dalam pengendalian tekanan darah (Shahin, 2021).

3. Merawat Anggota Keluarga yang Sakit

Keluarga memiliki tanggung jawab dalam memberikan perawatan sehari-hari kepada anggota keluarga yang menderita hipertensi. Bentuk perawatan yang diberikan meliputi mengingatkan konsumsi obat, membantu memonitoring tekanan darah, menyediakan makanan sehat, mendampingi aktivitas fisik, dan memberikan dukungan emosional (Stanhope, 2022).

Kepatuhan pengobatan menjadi salah satu tantangan utama dalam pengelolaan hipertensi. Banyak pasien yang menghentikan pengobatan ketika merasa sehat sehingga meningkatkan risiko terjadinya komplikasi. Dalam kondisi ini, peran keluarga sebagai pengawas dan motivator terapi sangat dibutuhkan (Hinkle, 2021).

Hasil studi menunjukkan bahwa pasien hipertensi yang memperoleh dukungan keluarga yang baik memiliki tingkat kepatuhan pengobatan yang lebih tinggi dibandingkan pasien yang kurang mendapatkan dukungan keluarga. Dukungan emosional dan instrumental keluarga menjadi faktor penting dalam mempertahankan terapi jangka panjang (Usnaini, 2025).

4. Memodifikasi Lingkungan

Lingkungan rumah yang sehat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan hipertensi. Oleh sebab itu, keluarga perlu menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku hidup sehat seperti membatasi konsumsi garam, menyediakan makanan bergizi, menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi stres, dan mendukung aktivitas fisik (Potter, 2021).

Perubahan gaya hidup yang akan dilakukan akan lebih efektif apabila dilakukan bersama seluruh anggota keluarga dibandingkan dengan hanya dibebankan kepada penderita hipertensi (Stanhope, M., & Lancaster, J., 2022). Dukungan keluarga dalam menjaga pola makan dan aktivitas fisik terbukti dapat membantu dalam mengontrol tekanan darah pada pasien hipertensi (Rahayu, 2023).

5. Memanfaatkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Keluarga harus mampu menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan secara optimal untuk pemeriksaan rutin, pengobatan, rehabilitasi, serta pencegahan komplikasi (Friedman, 2020). Pemanfaatan fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, posbindu PTM, dan layanan *home care* sangat penting dalam membantu pengendalian hipertensi jangka panjang (Kemenkes RI, 2024). Pemeriksaan tekanan darah secara rutin memungkinkan deteksi dini komplikasi dan membantu evaluasi keberhasilan terapi.

D. Konsep Hipertensi

Hipertensi merupakan suatu kondisi dimana terjadi peningkatan tekanan darah sistolik ≥ 140 mmHg dan/atau tekanan darah diastolik ≥ 90 mmHg berdasarkan dari hasil pengukuran yang dilakukan secara berulang ((WHO) World Health Organization, 2025). Hipertensi menjadi salah satu penyakit kronis dengan prevalensi tertinggi di dunia dan merupakan faktor risiko utama dari penyakit kardiovaskular.

Hipertensi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer merupakan jenis hipertensi yang paling banyak ditemukan namun penyebabnya tidak diketahui secara spesifiknya. Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor genetik, gaya hidup, obesitas, konsumsi garam berlebih, kurang aktivitas fisik, dan stres (Hinkle, 2021). Sementara itu, hipertensi sekunder merupakan jenis hipertensi yang disebabkan oleh penyakit tertentu seperti gangguan ginjal, gangguan endokrin, penyakit kardiovaskular, atau penggunaan obat tertentu (Smeltzer, S. C., Bare, B., Hinkle, J. L., & Cheever, K. H., 2021).

Patofisiologi dari hipertensi melibatkan terjadinya peningkatan resistensi perifer pembuluh darah dan gangguan regulasi tekanan darah. Aktivasi sistem saraf simpatis dan sistem renin-angiotensin-aldosteron menyebabkan terjadinya vasokonstriksi dan retensi cairan sehingga tekanan darah meningkat (Hinkle, 2021).

Dalam jangka panjang, hipertensi dapat menyebabkan terjadinya kerusakan organ target seperti jantung, otak, ginjal, retina, dan pembuluh darah perifer. Oleh

sebab itu, pengendalian tekanan darah menjadi sangat penting untuk mencegah komplikasi serius ((WHO) World Health Organization, 2025).

Faktor risiko hipertensi terdiri atas faktor yang tidak dapat dimodifikasi dan faktor yang dapat dimodifikasi. Faktor yang tidak dapat dimodifikasi meliputi usia, jenis kelamin, riwayat keluarga, dan genetik, sedangkan faktor yang dapat dimodifikasi meliputi pola makan tidak sehat, konsumsi garam berlebih, obesitas, merokok, konsumsi alkohol, kurang aktivitas fisik, dan stres (Potter, 2021).

Penatalaksanaan dari hipertensi dapat dilakukan melalui terapi farmakologis dan nonfarmakologis. Pendekatan nonfarmakologis meliputi diet rendah garam, aktivitas fisik teratur, pengendalian berat badan, berhenti merokok, pembatasan konsumsi alkohol, dan manajemen stres (Smeltzer, S. C., Bare, B., Hinkle, J. L., & Cheever, K. H., 2021). Keberhasilan terapi hipertensi sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktif pasien dan dukungan keluarga.

E. *Evidence Based Practice* dalam Pengelolaan Hipertensi Berbasis Keluarga

Pendekatan *evidence based practice* dalam pengelolaan hipertensi berbasis keluarga menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan kontrol tekanan darah dan kualitas hidup pasien. Berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa dukungan keluarga berhubungan erat dengan kepatuhan pengobatan pasien hipertensi (Shahin, 2021).

Penelitian yang telah dilakukan oleh (Kessek, 2026) menemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga dan kepatuhan terapi pengobatan anti hipertensi pada lansia hipertensi. Lansia yang memperoleh dukungan keluarga yang tinggi lebih mampu mempertahankan kepatuhan pengobatannya dibandingkan dengan mereka yang memiliki dukungan keluarga rendah.

Selain dari kepatuhan pengobatan, dukungan keluarga juga berpengaruh terhadap *self-management* pasien hipertensi. Penelitian yang dilakukan oleh (Chrismilasari, 2024) menunjukkan bahwa *self-efficacy* dan dukungan keluarga berhubungan dengan kemampuan pasien hipertensi dalam menjalankan *self-care* seperti diet rendah garam, olahraga yang teratur, serta kontrol tekanan darah secara rutin. Sementara itu, studi literatur yang dilakukan oleh (Rahayu, 2023) menjelaskan bahwa dukungan keluarga dapat membantu pasien hipertensi dalam mempertahankan perilaku hidup sehat, mengurangi stres, meningkatkan kualitas hidup, dan membantu mengontrol tekanan darah dalam jangka panjang.

Pendekatan *family centered care* juga efektif dalam meningkatkan motivasi pasien hipertensi dalam menjalani terapi jangka panjang. Adanya dukungan emosional yang diberikan oleh keluarga dapat membantu pasien merasa lebih

percaya diri dalam mempertahankan perubahan gaya hidup sehat (Wright L. M., 2021). Selain pemberian edukasi keluarga, intervensi berbasis komunitas seperti *home visit*, monitoring tekanan darah mandiri, *telehealth*, dan *peer support* juga terbukti efektif dalam membantu pengendalian hipertensi (Stanhope, M., & Lancaster, J., 2022).

F. Strategi Pemberdayaan Keluarga dalam Pengendalian Hipertensi

Pemberdayaan keluarga merupakan suatu proses peningkatan kemampuan keluarga dalam mengambil keputusan dan melakukan tindakan yang tepat terkait dengan kesehatan anggota keluarganya. Dalam pengelolaan hipertensi, pemberdayaan keluarga menjadi sebuah hal yang sangat penting. Hal tersebut dikarenakan keberhasilan pengendalian tekanan darah sangat dipengaruhi oleh keterlibatan keluarga dalam mendukung perubahan perilaku hidup sehat (Friedman, 2020).

Keluarga yang diberdayakan akan memiliki pengetahuan, keterampilan, serta motivasi yang lebih baik dalam membantu anggota keluarga menjalani pengobatan serta mempertahankan gaya hidup yang sehat. Pemberdayaan keluarga dapat dilakukan melalui pemberian edukasi kesehatan, konseling keluarga, pelatihan *self-management* tentang hipertensi, dan pendampingan keluarga oleh tenaga kesehatan (Stanhope, 2022). Salah satu bentuk pemberdayaan keluarga adalah dengan meningkatkan literasi kesehatan keluarga terkait hipertensi. Literasi kesehatan yang baik dapat membantu keluarga dalam memahami faktor risiko hipertensi, pentingnya kepatuhan pengobatan, pengaturan diet, aktivitas fisik, serta deteksi dini akan komplikasi hipertensi (Potter, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh (Laila, 2024) menunjukkan bahwa keluarga yang memiliki tingkat pengetahuan kesehatan yang baik lebih mampu mendukung pasien hipertensi dalam mempertahankan kepatuhan pengobatan dan perubahan gaya hidup sehat. Dukungan keluarga juga terbukti meningkatkan motivasi pasien dalam menjalani terapi jangka panjang. Pemberdayaan keluarga juga dapat dilakukan melalui pendekatan *family centered care* yang melibatkan keluarga dalam setiap proses pengambilan keputusan kesehatan. Pendekatan ini membantu meningkatkan rasa tanggung jawab keluarga terhadap keberhasilan terapi pasien hipertensi (Wright L. M., 2021).

Selain itu, tenaga kesehatan juga dapat memberikan pelatihan keterampilan sederhana kepada keluarga seperti cara mengukur tekanan darah mandiri, mengenali tanda bahaya hipertensi, mengatur menu rendah garam, dan melakukan aktivitas fisik yang aman bagi pasien hipertensi. Keterampilan tersebut

dapat membantu keluarga agar dapat lebih mandiri dalam melakukan perawatan di rumah (Hinkle, 2021). Sementara itu, dalam konteks pelayanan kesehatan masyarakat, pemberdayaan keluarga dapat dilakukan melalui program Posbindu Penyakit Tidak Menular (PTM), penyuluhan kesehatan, kunjungan rumah, dan kelompok pendukung pasien hipertensi. Program-program tersebut juga dapat membantu meningkatkan keterlibatan keluarga dalam upaya promotif dan preventif hipertensi (Kemenkes RI, 2024).

G. Hambatan Keluarga dalam Pengelolaan Hipertensi

Meskipun keluarga memiliki peranan yang penting dalam pengelolaan hipertensi, namun masih terdapat berbagai hambatan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas kesehatan keluarga. Hambatan tersebut dapat berasal dari faktor individu, keluarga, lingkungan, maupun sistem pelayanan kesehatan. Salah satu hambatan yang utama adalah rendahnya pengetahuan keluarga mengenai hipertensi. Banyak keluarga yang belum memahami bahwa hipertensi merupakan penyakit kronis yang membutuhkan pengobatan jangka panjang. Sebagian keluarga beranggapan bahwa pasien tidak perlu minum obat ketika tekanan darah sudah normal atau ketika tidak merasakan keluhan apapun (Hinkle, 2021).

Hambatan lainnya adalah rendahnya kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan maupun perubahan gaya hidup sehat. Kebanyakan pasien hipertensi sering merasa bosan dalam menjalani terapi jangka panjang. Oleh sebab itu, mereka memutuskan untuk menghentikan pengobatan tanpa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan (Smeltzer, S. C., Bare, B., Hinkle, J. L., & Cheever, K. H., 2021).

Faktor berikutnya adalah ekonomi. Faktor ekonomi juga sering kali menjadi hambatan penting dalam pengelolaan hipertensi. Keterbatasan biaya menyebabkan sebagian pasien tidak melakukan kontrol pengobatan secara rutin atau tidak membeli obat secara teratur. Selain itu, biaya pengobatan komplikasi hipertensi sering menambah beban ekonomi keluarga (Stanhope, M., & Lancaster, J., 2022).

Budaya dan kebiasaan masyarakat juga dapat mempengaruhi pengelolaan hipertensi. Konsumsi makanan yang mengandung tinggi garam, makanan berlemak, kebiasaan merokok, serta kurangnya aktivitas fisik masih menjadi bagian dari pola hidup masyarakat yang sulit untuk diubah (Potter, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh (Geleta, 2025) menyebutkan bahwa dukungan keluarga yang rendah, stres keluarga, serta keterbatasan akses pelayanan kesehatan memiliki hubungan dengan buruknya pengendalian hipertensi pada pasien. Dukungan sosial yang rendah menyebabkan pasien kurang termotivasi

menjalani terapi hipertensi secara konsisten. Selain itu, *caregiver burden* juga menjadi tantangan dalam keluarga yang sedang merawat pasien hipertensi terutama pada lansia dengan komplikasi. Anggota keluarga yang menjadi *caregiver* sering mengalami kelelahan fisik dan psikologis. Hal tersebut diakibatkan oleh tanggung jawab perawatan pada jangka panjang (Wright L. M., 2021).

Oleh sebab itu, tenaga kesehatan perlu memberikan dukungan serta pendampingan kepada keluarga agar keluarga mampu menghadapi berbagai hambatan yang muncul dalam pengelolaan hipertensi. Pendekatan holistik dan berpusat pada keluarga menjadi suatu hal yang penting guna meningkatkan keberhasilan pengendalian hipertensi berbasis keluarga.

H. Simpulan

Hipertensi merupakan penyakit kronis yang menjadi masalah kesehatan global dan membutuhkan pengelolaan jangka panjang secara berkesinambungan. Keberhasilan pengendalian hipertensi tidak hanya bergantung pada terapi farmakologis semata, tetapi juga dipengaruhi berbagai faktor, diantaranya perubahan gaya hidup sehat, kepatuhan pengobatan, *self-management*, serta dukungan keluarga yang optimal. Dalam konteks ini, keluarga sebagai sistem pendukung utama memiliki peran yang sangat penting dalam membantu anggota keluarga sehingga dapat menjalani proses perawatan dan pengendalian hipertensi.

Konsep tugas kesehatan keluarga menjadi landasan utama dalam melaksanakan praktik keperawatan keluarga pada pasien hipertensi. Tugas kesehatan keluarga meliputi kemampuan keluarga dalam mengenali masalah kesehatan, kemampuan keluarga dalam mengambil keputusan tindakan kesehatan yang tepat, kemampuan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang sakit, kemampuan keluarga dalam memodifikasi lingkungan yang mendukung kesehatan, serta kemampuan keluarga dalam memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan secara optimal (Friedman, 2020). Pelaksanaan tugas kesehatan keluarga yang baik terbukti mampu membantu meningkatkan kepatuhan dalam pengobatan, memperbaiki perilaku hidup sehat, meningkatkan motivasi pasien, serta membantu pasien mempertahankan kontrol tekanan darah dalam jangka panjang (Wright L. M., 2021).

Berbagai *evidence-based practice* menunjukkan bahwa dukungan keluarga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan hipertensi. Dukungan emosional, instrumental, informasional, dan penghargaan dari keluarga membantu pasien mempertahankan terapi, menjalankan diet rendah garam, melakukan aktivitas fisik, serta mengurangi faktor risiko hipertensi lainnya (Shahin, 2021). Selain itu, pendekatan *family-centered care*, pemberian edukasi kesehatan

berbasis keluarga, *home care*, *telehealth*, serta pemberdayaan keluarga menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan *self-management* pasien hipertensi. (Laila, 2024).

Namun demikian, masih terdapat berbagai hambatan dalam pelaksanaan tugas kesehatan keluarga. Hambatan tersebut seperti rendahnya literasi kesehatan, adanya keterbatasan ekonomi, budaya masyarakat, rendahnya kepatuhan pasien, serta keterbatasan akses pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu, tenaga kesehatan khususnya perawat memiliki peran penting, yakni sebagai edukator, fasilitator, konselor, dan advokat guna meningkatkan kemampuan keluarga dalam menjalankan tugas kesehatan keluarga secara optimal.

Dengan demikian, penguatan terkait dengan peran keluarga dalam pengelolaan hipertensi perlu terus dikembangkan, baik melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang berbasis keluarga dan komunitas. Kolaborasi antara pasien, keluarga, tenaga kesehatan, dan masyarakat menjadi kunci utama untuk meningkatkan kualitas hidup pasien hipertensi serta mencegah terjadinya komplikasi penyakit secara berkelanjutan.

CHAPTER 3

PENGAJIAN KEPERAWATAN KELUARGA PADA MASALAH HIPERTENSI

Barto Mansyah, S.Pd., MH.

A. Pendahuluan/Prolog

Hipertensi merupakan salah satu masalah kesehatan yang banyak ditemukan di masyarakat dan sering menjadi perhatian dalam keluarga karena prevalensinya tinggi serta dapat menimbulkan komplikasi serius apabila tidak terkontrol (World Health Organization, 2025; Kementerian Kesehatan RI, 2023). Seseorang dengan hipertensi dapat tetap tampak sehat, mampu bekerja, beraktivitas, dan menjalankan peran sehari-hari karena hipertensi sering tidak menimbulkan gejala yang jelas, sehingga pemeriksaan tekanan darah menjadi cara utama untuk mengetahuinya (World Health Organization, 2025; Kementerian Kesehatan RI, 2024). Kondisi ini sering membuat hipertensi tidak disadari sejak awal karena tekanan darah tinggi umumnya tidak memiliki tanda atau gejala peringatan yang jelas. Oleh karena itu, pemeriksaan tekanan darah menjadi cara utama untuk mengetahui apakah seseorang mengalami hipertensi (Centers for Disease Control and Prevention, 2024). WHO menjelaskan bahwa hipertensi yang tidak terdeteksi dan tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius, seperti penyakit jantung, stroke, gagal jantung, serta kerusakan ginjal (World Health Organization, 2023).

Dalam konteks keluarga, hipertensi tidak hanya menjadi masalah individu, tetapi juga berkaitan dengan perilaku dan dukungan keluarga dalam kehidupan sehari-hari (Friedman et al., 2010; Kaakinen et al., 2018). Hipertensi dapat dipengaruhi oleh kebiasaan makan tinggi garam, kurang aktivitas fisik, kebiasaan merokok, stres, pola istirahat, kepatuhan minum obat, serta kemampuan keluarga memanfaatkan fasilitas kesehatan (World Health Organization, 2025; Centers for Disease Control and Prevention, 2024; American Heart Association, 2024). Oleh karena itu, pengkajian keperawatan keluarga perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya mencatat tekanan darah, tetapi juga menilai kemampuan keluarga mengenal masalah, mengambil keputusan, merawat anggota keluarga, memodifikasi lingkungan, dan menggunakan pelayanan kesehatan (Maglaya, 2009; Friedman et al., 2010). Data hasil pengkajian menjadi dasar bagi perawat untuk menentukan masalah keperawatan, menyusun prioritas, merancang edukasi,

dan mengevaluasi perubahan perilaku keluarga dalam pengendalian hipertensi (Friedman et al., 2010; Nies & McEwen, 2019).

B. Makna Pengkajian Keperawatan Keluarga pada Hipertensi

Pengkajian keperawatan keluarga merupakan proses pengumpulan data keluarga secara menyeluruh, mencakup aspek biologis, psikologis, sosial, budaya, spiritual, lingkungan, serta kemampuan keluarga dalam menjalankan fungsi kesehatannya (Friedman et al., 2010; OpenStax, 2024). Pada keluarga dengan anggota yang menderita hipertensi, pengkajian diarahkan untuk memahami hubungan antara kondisi tekanan darah dengan kebiasaan hidup sehari-hari keluarga, seperti pola makan, aktivitas fisik, kepatuhan minum obat, dukungan keluarga, dan pemanfaatan fasilitas kesehatan (World Health Organization, 2025; Centers for Disease Control and Prevention, 2024).

Hipertensi merupakan kondisi peningkatan tekanan darah sistolik dan/atau diastolik di atas batas normal (Kementerian Kesehatan RI, 2024; World Health Organization, 2025). Kementerian Kesehatan RI menjelaskan bahwa seseorang dikatakan menderita hipertensi apabila tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan/atau tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg, yang diukur dalam kondisi tenang dengan teknik pemeriksaan yang tepat (Kementerian Kesehatan RI, 2024). WHO juga menyebutkan bahwa hipertensi didiagnosis apabila hasil pengukuran pada dua hari berbeda menunjukkan tekanan darah sistolik ≥ 140 mmHg dan/atau tekanan darah diastolik ≥ 90 mmHg (World Health Organization, 2025). Bagi perawat keluarga, angka tekanan darah penting untuk dikaji, tetapi pengkajian tidak boleh berhenti pada angka tersebut karena pengendalian hipertensi juga dipengaruhi oleh pemahaman keluarga, kepatuhan minum obat, pola makan, konsumsi garam, pemantauan tekanan darah di rumah, dan pemanfaatan fasilitas kesehatan (World Health Organization, 2025; Kementerian Kesehatan RI, 2024).

Pengkajian yang baik membantu perawat memahami bahwa hipertensi dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti kepatuhan minum obat, pola makan tinggi garam, aktivitas fisik, kebiasaan merokok, stres, serta dukungan keluarga (World Health Organization, 2025; Centers for Disease Control and Prevention, 2024). Seorang anggota keluarga dengan hipertensi dapat mengalami hambatan perawatan, misalnya lupa minum obat karena bekerja, sulit mengurangi garam karena kebiasaan makan keluarga, atau tidak rutin kontrol karena kurang dukungan untuk datang ke fasilitas kesehatan (Friedman et al., 2010; Maglaya, 2009). Situasi tersebut menunjukkan bahwa pengkajian tidak cukup hanya berfokus pada angka tekanan darah, tetapi juga perlu menggali kebiasaan, peran, dukungan, dan kemampuan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang sakit

(Kaakinen et al., 2018; Friedman et al., 2010). Oleh karena itu, pengkajian keluarga perlu dilakukan dengan pendekatan yang ramah, terbuka, dan tidak menyalahkan agar keluarga bersedia menyampaikan masalah yang sebenarnya (Kaakinen et al., 2018; Maglaya, 2009).

C. Data Dasar Keluarga yang Perlu Dikaji

Pengkajian dimulai dengan mengenal keluarga secara umum melalui pengumpulan data dasar keluarga (Friedman et al., 2010; Kaakinen et al., 2018). Data dasar keluarga meliputi identitas kepala keluarga, nama anggota keluarga, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, agama, suku, status perkawinan, serta hubungan antaranggota keluarga (Maglaya, 2009; Friedman et al., 2010). Data tersebut membantu perawat memahami latar belakang keluarga, struktur keluarga, peran masing-masing anggota keluarga, serta kemungkinan faktor yang memengaruhi perilaku kesehatan keluarga (Kaakinen et al., 2018; OpenStax, 2024). Dengan memahami data dasar keluarga, perawat dapat melakukan pengkajian lanjutan secara lebih terarah sesuai kebutuhan keluarga yang memiliki anggota dengan hipertensi (Friedman et al., 2010; Nies & McEwen, 2019).

Komposisi keluarga penting dikaji karena risiko hipertensi dapat berkaitan dengan usia, riwayat keluarga, penyakit penyerta, serta pola hidup yang terbentuk dalam keluarga (World Health Organization, 2025; Centers for Disease Control and Prevention, 2024). WHO menjelaskan bahwa faktor risiko hipertensi yang tidak dapat dimodifikasi meliputi riwayat keluarga hipertensi, usia lebih dari 65 tahun, serta penyakit penyerta seperti diabetes atau penyakit ginjal (World Health Organization, 2025). Faktor risiko yang dapat dimodifikasi meliputi pola makan tidak sehat, konsumsi garam berlebih, rendahnya konsumsi buah dan sayur, kurang aktivitas fisik, konsumsi tembakau dan alkohol, serta berat badan berlebih atau obesitas (World Health Organization, 2025). Oleh karena itu, perawat perlu mengkaji komposisi keluarga dan kebiasaan hidup sehari-hari untuk mengetahui faktor yang dapat meningkatkan risiko hipertensi maupun faktor yang dapat diperbaiki melalui edukasi dan dukungan keluarga (Centers for Disease Control and Prevention, 2024; Friedman et al., 2010).

Selain data identitas, perawat perlu menggali tipe keluarga, tahap perkembangan keluarga, budaya keluarga, kebiasaan harian, serta pola komunikasi karena keberhasilan pengelolaan hipertensi dipengaruhi oleh fungsi keluarga, dukungan keluarga, dan keterlibatan aktif anggota keluarga dalam perawatan (Ramadhani et al., 2024; Rifai et al., 2025). Hal ini sejalan dengan kesimpulan Ramadhani et al. (2024) bahwa fungsi keluarga berhubungan dengan manajemen

diri penderita hipertensi, serta kesimpulan Rifai et al. (2025) bahwa pendekatan keperawatan berbasis keluarga yang kontekstual dan melibatkan partisipasi aktif anggota keluarga efektif meningkatkan kemandirian keluarga dalam pengelolaan hipertensi.

Tahap perkembangan keluarga juga perlu diperhatikan karena setiap keluarga memiliki tantangan yang berbeda dalam menghadapi hipertensi. Pada keluarga dengan lansia, pengkajian perlu menilai keterbatasan aktivitas, kebutuhan pendampingan kontrol, dan dukungan perawatan jangka panjang karena edukasi yang melibatkan keluarga terbukti dapat menurunkan tekanan darah, meningkatkan efikasi diri, memperbaiki perilaku kesehatan, meningkatkan kualitas hidup, dan memberdayakan keluarga (Isnaini et al., 2025). Pada keluarga dengan anggota usia produktif, perawat perlu menggali beban kerja dan kendala waktu karena jam kerja panjang berhubungan dengan peningkatan tekanan darah (Gilbert-Ouimet et al., 2022). Pada keluarga dengan anak remaja, edukasi pola makan dan aktivitas fisik sejak dini penting dilakukan karena intervensi aktivitas fisik pada anak dan remaja terbukti membantu menurunkan tekanan darah serta mencegah risiko kardiovaskular di kemudian hari (Yuan et al., 2025).

Riwayat kesehatan keluarga perlu dikaji karena adanya anggota keluarga yang memiliki hipertensi, stroke, penyakit jantung, diabetes, penyakit ginjal, atau obesitas dapat menunjukkan peningkatan risiko masalah kardiovaskular pada anggota keluarga lainnya (World Health Organization, 2025; Centers for Disease Control and Prevention, 2024). Perawat perlu menanyakan riwayat penyakit tersebut karena riwayat keluarga merupakan faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi, sedangkan obesitas, pola makan tidak sehat, kurang aktivitas fisik, merokok, dan konsumsi alkohol merupakan faktor risiko yang masih dapat diubah melalui edukasi dan dukungan keluarga (World Health Organization, 2025; American Heart Association, 2024). Keluarga dengan riwayat penyakit kardiovaskular membutuhkan kewaspadaan lebih tinggi karena Ahmed et al. (2024) menyimpulkan bahwa riwayat penyakit kardiovaskular dalam keluarga yang disertai hipertensi memiliki interaksi positif terhadap kejadian penyakit kardiovaskular, sehingga riwayat keluarga penting digunakan dalam penilaian risiko dan pencegahan. Pengkajian juga perlu melihat apakah anggota keluarga rutin memeriksa tekanan darah atau hanya memeriksakan diri saat muncul keluhan, karena hipertensi sering tidak menimbulkan gejala dan pemeriksaan tekanan darah merupakan cara utama untuk mengetahui tekanan darah tinggi (Centers for Disease Control and Prevention, 2024; World Health Organization, 2025).

D. Pengkajian Kondisi Anggota Keluarga yang Menderita Hipertensi

Setelah mengenal keluarga secara umum, perawat perlu mengkaji secara khusus anggota keluarga yang menderita hipertensi agar data yang diperoleh lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan perawatan (American Nurses Association, 2024). Data yang dikumpulkan meliputi lama menderita hipertensi, tekanan darah terakhir, keluhan yang sering dirasakan, obat yang dikonsumsi, jadwal kontrol, penyakit penyerta, riwayat rawat inap, serta pengalaman keluarga dalam menghadapi hipertensi (World Health Organization, 2025; OpenStax, 2024). Pengkajian tersebut penting karena pengelolaan hipertensi tidak hanya bergantung pada hasil tekanan darah, tetapi juga pada keteraturan pemantauan, kepatuhan pengobatan, kondisi penyakit penyerta, dan dukungan keluarga dalam perawatan sehari-hari (Centers for Disease Control and Prevention, 2024; American Heart Association, 2025). Hasil pengkajian khusus ini menjadi dasar bagi perawat untuk menentukan masalah keperawatan keluarga, menyusun prioritas, dan merencanakan edukasi yang sesuai dengan kondisi keluarga (American Nurses Association, 2024).

Keluhan yang perlu dikaji pada anggota keluarga dengan hipertensi meliputi sakit kepala, pusing, rasa berat di tengkuk, mudah lelah, dada berdebar, sesak napas, pandangan kabur, nyeri dada, kesemutan, gangguan tidur, serta keluhan lain yang dirasakan dalam aktivitas sehari-hari (Horne et al., 2023; Zieliński et al., 2023). Horne et al. (2023) menyimpulkan bahwa gejala hipertensi dapat bervariasi pada setiap individu dan dipengaruhi oleh faktor budaya, keyakinan, psikososial, serta pengetahuan pasien, sehingga perawat perlu menggali keluhan secara terbuka. Namun, keluarga juga perlu diberi pemahaman bahwa hipertensi dapat terjadi tanpa gejala yang jelas, sehingga tidak adanya keluhan tidak selalu berarti tekanan darah dalam keadaan normal (Degtyar et al., 2025; World Health Organization, 2025). Oleh karena itu, pemeriksaan tekanan darah tetap menjadi langkah utama untuk mengetahui kondisi hipertensi dan menilai kebutuhan tindak lanjut perawatan (Mizuno et al., 2023; Centers for Disease Control and Prevention, 2026). Dengan demikian, pengkajian keluhan harus tetap disertai pemantauan tekanan darah secara teratur agar keluarga tidak hanya bergantung pada muncul atau tidaknya gejala (Horne et al., 2023; Mizuno et al., 2023).

Perawat juga perlu mengkaji kepatuhan anggota keluarga yang menderita hipertensi dalam menjalani pengobatan karena kepatuhan terhadap terapi antihipertensi berperan penting dalam pengendalian tekanan darah dan pencegahan komplikasi (Guo et al., 2023; Peng et al., 2025). Pertanyaan pengkajian dapat diarahkan secara sederhana, seperti "Apakah obat diminum setiap hari?", "Pada jam berapa biasanya obat diminum?", "Apakah pernah lupa minum obat?",

“Apa yang dilakukan keluarga jika obat habis?”, dan “Apakah obat pernah dihentikan karena tekanan darah sudah turun?” untuk mengetahui hambatan nyata yang dialami pasien dan keluarga (Guo et al., 2023; Shahin et al., 2021). Pengkajian ini penting karena kepatuhan minum obat pada pasien hipertensi dipengaruhi oleh literasi kesehatan, dukungan sosial, dukungan keluarga, pemahaman tentang penyakit, serta kemampuan keluarga membantu pasien menjalani terapi secara teratur (Pan et al., 2021; Guo et al., 2023). Dukungan keluarga perlu dikaji karena beberapa artikel menyimpulkan bahwa dukungan keluarga dan dukungan sosial berhubungan positif dengan kepatuhan pengobatan hipertensi, sehingga keluarga dapat berperan dalam mengingatkan jadwal minum obat, membantu kontrol ulang, menyediakan obat, dan memberi motivasi agar pasien tidak merasa menjalani perawatan sendirian (Shahin et al., 2021; Usnaini et al., 2025).

Pengkajian penyakit penyerta juga sangat penting karena hipertensi sering muncul bersama diabetes melitus, penyakit ginjal kronis, gangguan jantung, obesitas, dan dislipidemia yang dapat memperbesar risiko komplikasi kardiovaskular maupun ginjal (Lauder et al., 2023; Hlyan et al., 2024). Perawat perlu menanyakan riwayat penyakit penyerta tersebut karena diabetes, hipertensi, obesitas, dan penyakit ginjal kronis saling berkaitan serta dapat memperburuk kondisi kesehatan apabila tidak dikelola secara terpadu (Hlyan et al., 2024). Perawat juga perlu menanyakan hasil pemeriksaan laboratorium yang pernah dilakukan, seperti gula darah atau HbA1c, profil kolesterol, kreatinin, laju filtrasi glomerulus, urinalisis, serta pemeriksaan lain yang tersedia karena penilaian awal hipertensi perlu mencakup riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, dan pemeriksaan penunjang sesuai kebutuhan (Kreutz et al., 2024). Bila keluarga tidak memiliki catatan hasil pemeriksaan, perawat dapat menganjurkan keluarga menyimpan dokumen kesehatan dalam satu map atau buku khusus agar hasil tekanan darah, obat yang digunakan, hasil laboratorium, dan jadwal kontrol mudah dibawa saat berobat serta membantu kesinambungan perawatan keluarga (Kreutz et al., 2024).

E. Pengkajian Tekanan Darah di Rumah

Pengukuran tekanan darah menjadi bagian utama dalam pengkajian hipertensi karena hasil pengukuran yang akurat diperlukan untuk menilai kondisi pasien dan menentukan tindak lanjut perawatan (Centers for Disease Control and Prevention, 2024; McEvoy et al., 2024). Perawat perlu memastikan bahwa pengukuran dilakukan dengan cara yang benar karena posisi tubuh, ukuran manset, posisi lengan, aktivitas sebelum pengukuran, dan kebiasaan berbicara saat pemeriksaan dapat memengaruhi hasil tekanan darah (Centers for Disease Control

and Prevention, 2024; American Heart Association, 2025). Kesalahan posisi lengan dapat menyebabkan hasil tekanan darah tampak lebih tinggi dari kondisi sebenarnya, sebagaimana ditunjukkan dalam uji klinis acak bahwa lengan yang diletakkan di pangkuan atau menggantung di sisi tubuh dapat meningkatkan hasil tekanan darah dibandingkan posisi lengan yang ditopang setinggi jantung (Liu et al., 2024). Ukuran manset yang tidak sesuai juga dapat menghasilkan pembacaan tekanan darah yang tidak akurat, sehingga pemilihan manset perlu disesuaikan dengan ukuran lingkaran lengan pasien (Ishigami et al., 2023). Sebelum pengukuran, pasien dianjurkan tidak makan atau minum selama 30 menit, mengosongkan kandung kemih, duduk nyaman dengan punggung tersangga minimal lima menit, kaki menapak lantai dan tidak disilangkan, lengan ditopang setinggi dada, manset menempel pada kulit, serta tidak berbicara selama pengukuran (Centers for Disease Control and Prevention, 2024).

Keluarga yang memiliki alat tensi di rumah perlu dikaji kemampuannya dalam menggunakan alat tersebut karena pemantauan tekanan darah di rumah memerlukan edukasi agar kesalahan penggunaan dapat dikurangi (Lee, 2024). Perawat dapat meminta keluarga memperagakan cara mengukur tekanan darah untuk menilai apakah alat yang digunakan sudah sesuai, manset terpasang pada kulit dengan ukuran yang tepat, posisi lengan berada setinggi jantung, dan keluarga tidak berbicara selama pengukuran (American Heart Association, 2025; Centers for Disease Control and Prevention, 2024). Perawat juga perlu menilai apakah keluarga mencatat hasil pengukuran secara teratur karena American Heart Association menganjurkan pengukuran dilakukan lebih dari satu kali dan hasilnya dicatat untuk dibawa saat kontrol kesehatan (American Heart Association, 2025). Selain itu, keluarga perlu memahami arti angka sistolik dan diastolik karena tekanan darah dicatat dalam dua angka, yaitu sistolik sebagai angka atas dan diastolik sebagai angka bawah, yang digunakan untuk menilai kategori tekanan darah (American Heart Association, 2025).

Pemantauan tekanan darah di rumah dianjurkan pada anggota keluarga yang telah didiagnosis hipertensi karena hasil pengukuran mandiri dapat membantu tenaga kesehatan menilai efektivitas terapi dan pengendalian tekanan darah (American Heart Association, 2025; McEvoy et al., 2024). American Heart Association menganjurkan penggunaan alat tekanan darah otomatis dengan manset lengan atas, bukan alat pergelangan tangan atau jari, karena alat lengan atas lebih direkomendasikan untuk memperoleh hasil yang lebih dapat diandalkan (American Heart Association, 2025). Oleh karena itu, dalam pengkajian keluarga, perawat perlu menanyakan jenis alat yang digunakan, memastikan alat sudah tervalidasi, menilai kesesuaian ukuran manset dengan lingkaran lengan, serta

menganjurkan keluarga membawa alat tersebut saat kontrol agar dapat dibandingkan dengan alat di fasilitas kesehatan (American Heart Association, 2025; Validate BP, 2026). Perawat juga perlu menanyakan kapan terakhir alat diperiksa atau dibandingkan dengan alat tenaga kesehatan karena American Heart Association menyarankan agar alat dibawa saat kunjungan kesehatan dan diperiksa kembali setidaknya setahun sekali atau sesuai petunjuk tenaga kesehatan (American Heart Association, 2025).

Catatan tekanan darah di rumah sangat membantu proses pengkajian karena pemantauan tekanan darah dari waktu ke waktu memberikan gambaran yang lebih lengkap dibandingkan satu kali hasil pengukuran (American Heart Association, 2025). Satu kali hasil tekanan darah hanya menunjukkan kondisi pada saat pengukuran, sedangkan hasil yang dicatat secara berkala dapat membantu perawat dan tenaga kesehatan menilai pola tekanan darah, respons terhadap terapi, serta kebutuhan tindak lanjut perawatan (McEvoy et al., 2024; Shimbo et al., 2025). American Heart Association menjelaskan bahwa catatan tekanan darah dari waktu ke waktu dapat membantu pasien dan tenaga kesehatan memastikan apakah terapi untuk menurunkan tekanan darah sudah berjalan efektif (American Heart Association, 2025). Oleh karena itu, perawat dapat mendorong keluarga membuat buku pemantauan sederhana yang berisi tanggal, jam, hasil tekanan darah, denyut nadi, keluhan, obat yang diminum, serta catatan khusus seperti kurang tidur, stres, atau konsumsi makanan asin (American Heart Association, 2025; Shimbo et al., 2025).

F. Pengkajian Pola Makan Keluarga

Pola makan keluarga sangat berpengaruh terhadap pengendalian hipertensi karena asupan tinggi natrium, makanan tinggi lemak, gula, serta makanan ultra-proses berhubungan dengan peningkatan risiko tekanan darah tinggi (Sakir et al., 2024; Barbosa et al., 2022). Pengkajian pola makan tidak cukup hanya menanyakan "Apakah sering makan asin?" karena sumber natrium dapat berasal dari garam yang ditambahkan saat memasak, penyedap rasa, makanan instan, makanan kaleng, lauk olahan, makanan cepat saji, serta makanan yang dibeli di luar rumah (Zhang et al., 2023; Barbosa et al., 2022). Perawat perlu menggali jenis makanan yang biasa dikonsumsi, cara memasak, penggunaan garam dan penyedap, kebiasaan mengonsumsi gorengan, santan, makanan kemasan, serta frekuensi membeli makanan di luar rumah karena penelitian di Jakarta menyimpulkan bahwa makanan tinggi lemak, gula, dan natrium berkaitan dengan risiko obesitas, diabetes melitus tipe 2, dan hipertensi (Sakir et al., 2024). Hal ini juga sejalan dengan kesimpulan Zhang et al. (2023) bahwa intervensi pengurangan garam yang

menyasar juru masak rumah tangga dan anggota keluarga efektif menurunkan asupan garam serta tekanan darah, sehingga pengkajian pola makan keluarga perlu menilai kebiasaan memasak dan pilihan makanan sehari-hari.

Pertanyaan pengkajian pola makan dapat dibuat sederhana, misalnya "Siapa yang biasanya memasak di rumah?", "Apakah keluarga sering menggunakan ikan asin, telur asin, mi instan, kerupuk, atau makanan kemasan?", "Berapa kali keluarga membeli makanan siap saji dalam seminggu?", "Apakah tersedia buah dan sayur setiap hari?", dan "Apakah anggota keluarga lain bersedia mendukung makanan rendah garam?" Pertanyaan tersebut penting karena pola makan pasien hipertensi banyak dipengaruhi oleh kebiasaan makan keluarga, orang yang memasak di rumah, serta dukungan anggota keluarga dalam menjalankan diet rendah garam. Zhang et al. (2023) menyimpulkan bahwa intervensi pengurangan garam yang melibatkan juru masak rumah tangga dan anggota keluarga efektif menurunkan asupan garam serta tekanan darah. Selain itu, penelitian Simamora et al. (2024) menunjukkan adanya hubungan bermakna antara dukungan keluarga dan kepatuhan diet rendah garam pada lansia dengan hipertensi, sehingga pasien hipertensi akan lebih mudah mengubah pola makan apabila keluarga ikut mendukung perubahan tersebut.

Perawat juga perlu mengkaji kebiasaan makan bersama karena pola makan pasien hipertensi sering dipengaruhi oleh menu keluarga, kebiasaan memasak, dan dukungan anggota keluarga di rumah (Zhang et al., 2023; Simamora et al., 2024). Jika makanan keluarga disajikan dalam satu menu yang sama, perubahan pola makan rendah garam akan lebih mudah dilakukan apabila seluruh anggota keluarga ikut menyesuaikan, terutama anggota keluarga yang berperan memasak dan menyiapkan makanan (Zhang et al., 2023). Sebaliknya, pasien hipertensi dapat merasa terbebani dan sulit mempertahankan diet apabila harus makan menu berbeda sementara anggota keluarga lain tetap mengonsumsi makanan tinggi garam atau makanan olahan tinggi natrium (Barbosa et al., 2022; Vargas-Meza et al., 2023). Hal ini sejalan dengan kesimpulan Zhang et al. (2023) bahwa intervensi pengurangan garam yang melibatkan juru masak rumah tangga dan anggota keluarga efektif menurunkan asupan garam serta tekanan darah, serta kesimpulan Simamora et al. (2024) bahwa dukungan keluarga berhubungan dengan kepatuhan diet rendah garam pada lansia hipertensi.

Pengkajian pola makan juga perlu memperhatikan kemampuan ekonomi keluarga karena keterjangkauan bahan makanan memengaruhi kemampuan keluarga dalam menjalankan pola makan sehat secara berkelanjutan (Odoms-Young et al., 2024; Balagamwala et al., 2024). Anjuran makan sehat perlu disesuaikan dengan kondisi keluarga, sebab kesimpulan Balagamwala et al. (2024)

menunjukkan bahwa kesenjangan kemampuan membeli makanan bergizi perlu dipertimbangkan dalam merancang intervensi gizi, termasuk pada konteks Indonesia. Perawat dapat menggali bahan makanan lokal yang mudah diperoleh, seperti sayuran, buah musiman, kacang-kacangan, tahu, tempe, ikan, telur, serta cara memasak yang lebih sehat karena pola makan yang kaya buah, sayur, biji-bijian, dan rendah natrium mendukung pengendalian tekanan darah (Aljuraiban et al., 2023). Tujuan pengkajian bukan memaksakan menu mahal, tetapi membantu keluarga menemukan pilihan makanan yang realistis, aman, sesuai kemampuan ekonomi, dan dapat dilakukan terus-menerus (Odoms-Young et al., 2024; Balagamwala et al., 2024).

G. Pengkajian Aktivitas Fisik dan Kebiasaan Harian

Aktivitas fisik merupakan bagian penting dalam pengendalian tekanan darah karena berbagai bentuk aktivitas fisik terbukti dapat membantu menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi (Mohamed et al., 2024). Dalam pengkajian keluarga, perawat perlu mengetahui pekerjaan sehari-hari, kebiasaan bergerak, lama waktu duduk, kebiasaan olahraga, serta hambatan keluarga untuk beraktivitas fisik agar intervensi yang diberikan sesuai dengan kondisi keluarga (International Society of Hypertension, 2023). WHO menjelaskan bahwa kurang aktivitas fisik dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan termasuk faktor risiko yang dapat dimodifikasi melalui perubahan gaya hidup (World Health Organization, 2024). Oleh karena itu, perawat perlu membantu keluarga mengenali aktivitas sederhana yang dapat dilakukan secara rutin, seperti berjalan kaki, mengurangi waktu duduk terlalu lama, melakukan pekerjaan rumah tangga secara aktif, atau olahraga ringan sesuai kemampuan anggota keluarga (World Health Organization, 2024; Mohamed et al., 2024).

Pertanyaan yang dapat diajukan antara lain: "Apa aktivitas harian Bapak/Ibu?", "Apakah ada kebiasaan berjalan kaki?", "Berapa lama biasanya duduk menonton televisi atau menggunakan gawai?", "Apakah ada keluhan nyeri lutut, sesak, mudah lelah, atau pusing saat beraktivitas?", dan "Siapa anggota keluarga yang dapat menemani aktivitas fisik ringan?" Pertanyaan tersebut penting karena pengkajian aktivitas fisik perlu menilai kebiasaan bergerak, waktu sedentari, kemampuan fisik, keluhan saat aktivitas, serta dukungan keluarga agar rencana aktivitas yang diberikan aman dan sesuai kondisi pasien (World Health Organization, 2020; Charchar et al., 2024). Kesimpulan pedoman WHO menegaskan bahwa melakukan sebagian aktivitas fisik lebih baik daripada tidak sama sekali dan perilaku sedentari perlu dikurangi, sedangkan position paper International Society of Hypertension menyimpulkan bahwa perubahan gaya

hidup, termasuk aktivitas fisik teratur, merupakan strategi utama dalam pencegahan dan pengendalian hipertensi (World Health Organization, 2020; Charchar et al., 2024). Selain itu, tinjauan sistematis Mohamed et al. (2024) menyimpulkan bahwa intervensi aktivitas fisik dapat membantu menurunkan tekanan darah, sehingga hasil pengkajian dapat digunakan perawat untuk menyusun aktivitas sederhana seperti berjalan kaki, mengurangi duduk terlalu lama, atau olahraga ringan yang didampingi keluarga sesuai kemampuan pasien (Mohamed et al., 2024).

Perawat juga perlu mengkaji pola tidur dan stres karena durasi tidur yang pendek berhubungan dengan peningkatan risiko hipertensi, sehingga kebiasaan tidur keluarga perlu menjadi bagian dari pengkajian (Hosseini et al., 2024). Kurang tidur, beban kerja, konflik keluarga, masalah ekonomi, dan kecemasan dapat memengaruhi perilaku kesehatan, termasuk kemampuan keluarga menjaga pola makan, minum obat tepat waktu, dan melakukan kontrol rutin (Shahin et al., 2021; Almaghamisi & Alzahrani, 2024). Keluarga yang sedang mengalami stres berat mungkin lebih sulit menjalankan perawatan hipertensi secara konsisten, sehingga pengkajian psikososial perlu dilakukan untuk mengetahui hambatan emosional, sosial, dan ekonomi yang dialami keluarga (Webster et al., 2025). Oleh karena itu, perawat perlu membangun komunikasi yang empatik, terbuka, dan berpusat pada keluarga agar keluarga merasa aman untuk bercerita serta lebih mudah dilibatkan dalam perawatan hipertensi (Byrne et al., 2023).

Kebiasaan merokok juga perlu dikaji karena merokok dan paparan asap rokok merupakan faktor risiko yang dapat memperburuk kesehatan kardiovaskular, termasuk pada keluarga dengan masalah hipertensi (Li et al., 2024; Kementerian Kesehatan RI, 2023). Pengkajian tidak hanya dilakukan pada pasien hipertensi yang merokok, tetapi juga pada anggota keluarga lain yang merokok di rumah karena paparan asap rokok pasif terbukti berhubungan dengan peningkatan risiko hipertensi pada orang yang tidak merokok (Lin et al., 2025). Perawat dapat menanyakan siapa yang merokok, jumlah batang rokok per hari, lokasi merokok, paparan asap rokok di dalam rumah, serta keinginan untuk mengurangi atau berhenti merokok agar intervensi edukasi lebih sesuai dengan kondisi keluarga (Kementerian Kesehatan RI, 2023). Kementerian Kesehatan RI memperkenalkan perilaku CERDIK sebagai upaya pencegahan penyakit tidak menular dan pengendalian hipertensi, yaitu cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

H. Pengkajian Tugas Kesehatan Keluarga

Dalam keperawatan keluarga, kemampuan keluarga menjalankan tugas kesehatan menjadi bagian penting dalam pengkajian karena keluarga berperan langsung dalam mengenali, merawat, dan mengambil keputusan terkait masalah kesehatan anggota keluarganya (Suhariyanti et al., 2024). Pada keluarga dengan anggota yang menderita hipertensi, tugas kesehatan keluarga dapat dikaji melalui lima kemampuan utama, yaitu mengenal masalah hipertensi, mengambil keputusan kesehatan yang tepat, merawat anggota keluarga yang sakit, memodifikasi lingkungan agar mendukung kesehatan, dan memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan (Suhariyanti et al., 2024). Pengkajian lima tugas kesehatan keluarga penting dilakukan karena pelaksanaan tugas kesehatan keluarga berhubungan dengan kepatuhan penderita hipertensi dalam mengonsumsi obat antihipertensi (Hasanah et al., 2022). Selain itu, pendampingan keluarga dalam menjalankan lima tugas kesehatan keluarga terbukti dapat meningkatkan kualitas hidup lansia dengan hipertensi, sehingga perawat perlu menilai kemampuan keluarga secara menyeluruh sejak tahap pengkajian (Suhariyanti et al., 2024).

Kemampuan mengenal masalah dikaji melalui pemahaman keluarga tentang hipertensi, termasuk pengertian hipertensi, penyebab, tanda bahaya, komplikasi, dan cara mengontrol tekanan darah (Guo et al., 2023; Siregar et al., 2024). Perawat dapat menanyakan secara sederhana apa yang keluarga ketahui tentang hipertensi, kapan tekanan darah perlu diperiksa, bagaimana cara minum obat yang benar, serta makanan apa saja yang perlu dibatasi (Guo et al., 2023; Kartikasari et al., 2025). Pengkajian ini penting karena kurangnya pengetahuan dapat membuat keluarga menganggap obat hanya perlu diminum saat muncul keluhan, tekanan darah cukup diperiksa ketika merasa sakit, atau makanan tinggi garam tidak berpengaruh selama tubuh masih terasa sehat (Usnaini et al., 2025; Kartikasari et al., 2025). Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa pengetahuan, penerimaan terhadap penyakit, dukungan keluarga, pemantauan penyakit, dan tindak lanjut pelayanan kesehatan berperan dalam meningkatkan kepatuhan pengobatan hipertensi, sehingga perawat perlu menilai pemahaman keluarga sejak awal pengkajian (Siregar et al., 2024; Ashktorab et al., 2024).

Kemampuan mengambil keputusan dikaji dari cara keluarga merespons ketika tekanan darah anggota keluarga meningkat, seperti apakah keluarga segera meminta pasien beristirahat, mengulang pengukuran, menghubungi tenaga kesehatan, mengantar kontrol, atau justru menunggu sampai muncul keluhan berat. Pengkajian ini penting karena pengambilan keputusan dalam pengelolaan hipertensi membutuhkan pemahaman pasien dan keluarga terhadap kondisi penyakit, pilihan tindakan, serta kapan harus mencari pertolongan tenaga

kesehatan (Johnson et al., 2021). American Heart Association menjelaskan bahwa bila tekanan darah lebih dari 180/120 mmHg, pengukuran perlu diulang setelah minimal satu menit; apabila hasil tetap tinggi dan disertai gejala seperti nyeri dada, sesak napas, nyeri punggung, mati rasa, kelemahan, perubahan penglihatan, atau kesulitan bicara, kondisi tersebut termasuk keadaan darurat dan perlu segera mendapatkan pertolongan medis (American Heart Association, 2025). Dengan demikian, perawat perlu menilai apakah keluarga mampu mengenali tanda bahaya, mengambil keputusan cepat, dan memanfaatkan layanan kesehatan secara tepat saat terjadi peningkatan tekanan darah.

Kemampuan merawat anggota keluarga dikaji melalui dukungan sehari-hari yang diberikan keluarga kepada anggota keluarga yang menderita hipertensi. Perawat dapat menanyakan siapa yang mengingatkan minum obat, siapa yang menyiapkan makanan, siapa yang mengantar kontrol, dan siapa yang membantu mencatat tekanan darah. Pengkajian ini membantu perawat menemukan anggota keluarga yang dapat menjadi pendukung utama karena dukungan keluarga berhubungan dengan kepatuhan minum obat dan keberhasilan perawatan hipertensi di rumah (Guo et al., 2023; Usnaini et al., 2025).

Kemampuan memodifikasi lingkungan dikaji dari kondisi rumah dan kebiasaan keluarga yang dapat mendukung atau menghambat pengendalian hipertensi. Lingkungan yang mendukung pengendalian hipertensi antara lain rumah bebas asap rokok, tersedianya makanan rendah garam, adanya tempat yang aman untuk berjalan kaki, suasana rumah yang mendukung istirahat, serta pengingat minum obat. Lingkungan dalam pengkajian keluarga tidak hanya berarti bangunan fisik, tetapi juga kebiasaan, dukungan sosial, dan pola hidup di dalam rumah karena paparan asap rokok, pola makan tinggi natrium, kurang aktivitas fisik, serta rendahnya dukungan sosial dapat memengaruhi pengendalian hipertensi (Li et al., 2024; Kim et al., 2024; Mohamed et al., 2024).

Kemampuan memanfaatkan fasilitas kesehatan dikaji dari kebiasaan keluarga menggunakan puskesmas, posbindu, klinik, rumah sakit, apotek, atau layanan kesehatan lain. Perawat perlu mengetahui apakah keluarga memiliki akses ke fasilitas kesehatan, memiliki jaminan kesehatan, memahami jadwal kontrol, mengetahui ketersediaan obat, serta memahami ke mana harus mencari bantuan ketika tekanan darah meningkat atau muncul tanda bahaya. Hal ini penting karena WHO melalui paket HEARTS menekankan bahwa pengelolaan penyakit kardiovaskular di pelayanan primer perlu didukung oleh konseling gaya hidup sehat, protokol pengobatan berbasis bukti, akses obat dan teknologi esensial, penilaian risiko, kerja tim, dan sistem pemantauan (World Health Organization, 2020). Selain itu, pendekatan pelayanan yang melibatkan keluarga dalam

pengelolaan hipertensi terbukti memberi dampak baik bagi pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan, sehingga perawat perlu menilai sejauh mana keluarga mampu bekerja sama dengan fasilitas kesehatan dalam kontrol rutin, konsultasi, pemantauan tekanan darah, dan tindak lanjut pengobatan (Say et al., 2023).

I. Pengkajian Lingkungan Rumah dan Dukungan Sosial

Lingkungan rumah dapat membantu atau menghambat pengendalian hipertensi karena kondisi tempat tinggal, keamanan rumah, dan dukungan sosial keluarga berperan dalam keberhasilan perawatan penyakit kronis di rumah (Heller et al., 2023; Guo et al., 2023). Perawat perlu mengamati kebersihan rumah, ventilasi, pencahayaan, kepadatan hunian, ketersediaan air bersih, keamanan lantai, serta tempat penyimpanan obat agar dapat menilai faktor lingkungan yang mendukung atau menghambat perawatan hipertensi (Heller et al., 2023; Vaismoradi & Logan, 2025). Bagi pasien lansia dengan hipertensi, lingkungan rumah yang tidak aman dapat meningkatkan risiko jatuh, terutama bila terdapat lantai licin, pencahayaan kurang, hambatan di area berjalan, pusing, hipotensi ortostatik, atau efek samping obat antihipertensi (Montero-Odasso et al., 2022). Pedoman pencegahan jatuh pada lansia juga menekankan pentingnya identifikasi bahaya lingkungan rumah, seperti tangga licin, pencahayaan buruk, tidak adanya pegangan, dan barang yang menghalangi jalan, sebagai bagian dari pengkajian risiko jatuh (Montero-Odasso et al., 2022). Oleh karena itu, perawat perlu menilai lingkungan fisik rumah sekaligus dukungan sosial keluarga, karena dukungan keluarga dan literasi kesehatan terbukti berperan dalam kepatuhan pengobatan hipertensi dan keberhasilan perawatan di rumah (Guo et al., 2023).

Tempat penyimpanan obat perlu diperhatikan karena cara keluarga menyimpan dan mengatur obat di rumah dapat memengaruhi keamanan obat serta kepatuhan pasien dalam minum obat (Gualtieri et al., 2022; Gualtieri et al., 2024). Obat sebaiknya disimpan di tempat yang mudah dijangkau oleh pasien atau keluarga yang bertanggung jawab, tetapi tetap aman dari jangkauan anak-anak dan hewan peliharaan (Centers for Disease Control and Prevention, 2022; MedlinePlus, 2024). Perawat dapat menanyakan apakah obat sering tertukar, apakah keluarga memahami nama obat dan dosisnya, apakah obat disimpan dalam kemasan asli, serta apakah keluarga mengetahui waktu minum obat yang benar (MedlinePlus, 2024; Gualtieri et al., 2024). Bila pasien mengonsumsi beberapa jenis obat, perawat dapat menyarankan penggunaan kotak obat harian atau jadwal minum obat yang ditempel di tempat terlihat karena alat bantu visual dan rutinitas harian dapat membantu pasien mengingat obat serta mengurangi risiko lupa minum obat (Gualtieri et al., 2024; Guo et al., 2023).

Dukungan sosial juga penting dikaji karena keluarga dan lingkungan sekitar dapat membantu pasien hipertensi menjalankan pengobatan, kontrol rutin, dan perubahan gaya hidup. Dukungan tersebut dapat berasal dari pasangan, anak, saudara, tetangga, kader kesehatan, posbindu, kelompok lansia, atau tokoh masyarakat. Hal ini sesuai dengan kesimpulan Shahin et al. (2021) bahwa dukungan keluarga dan teman sebaya dapat membantu meningkatkan kepatuhan pengobatan pada pasien hipertensi. Guo et al. (2023) juga menyimpulkan bahwa dukungan sosial dan literasi kesehatan berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kepatuhan minum obat pada pasien hipertensi. Sebaliknya, pasien yang tinggal sendiri atau kurang mendapatkan dukungan membutuhkan perhatian lebih karena penelitian pada lansia hipertensi menunjukkan bahwa tinggal sendiri dan gejala depresi berpengaruh terhadap kepatuhan pengobatan, sehingga intervensi perlu disesuaikan dengan kondisi sosial pasien (Kim & Lee, 2022).

J. Data Fokus dalam Pengkajian Hipertensi Keluarga

Agar pengkajian lebih terarah, perawat dapat menyusun data fokus yang berhubungan langsung dengan masalah hipertensi dan faktor pendukung dalam keluarga (American Nurses Association, 2024). Data fokus membantu perawat membedakan data subjektif dan objektif, sehingga informasi yang diperoleh dapat digunakan untuk menentukan masalah keperawatan, menyusun prioritas, merencanakan tindakan, dan melakukan evaluasi asuhan (OpenStax, 2024). Data subjektif dapat berupa keluhan pasien, pemahaman keluarga tentang hipertensi, kebiasaan makan, kepatuhan minum obat, hambatan kontrol, kebiasaan aktivitas fisik, pola tidur, stres, serta dukungan keluarga dalam perawatan sehari-hari (Guo et al., 2023). Data objektif dapat berupa hasil tekanan darah, denyut nadi, berat badan, lingkar perut, kondisi umum, catatan penggunaan obat, hasil pemeriksaan laboratorium, serta kondisi lingkungan rumah yang dapat memengaruhi pengendalian hipertensi (McEvoy et al., 2024). Dengan menyusun data fokus, perawat dapat melihat masalah keluarga secara lebih jelas dan menentukan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan anggota keluarga yang menderita hipertensi (American Nurses Association, 2024; McEvoy et al., 2024).

Tabel 3.1: Komponen Pengkajian Keperawatan Keluarga pada Masalah Hipertensi

Komponen yang Dikaji	Data yang Perlu Digali	Contoh Pertanyaan
Identitas keluarga	Anggota keluarga, usia, pendidikan, pekerjaan, hubungan keluarga	"Siapa saja yang tinggal serumah?"
Riwayat hipertensi	Lama sakit, tekanan darah terakhir, riwayat kontrol	"Sejak kapan tekanan darah Bapak/Ibu tinggi?"
Keluhan	Pusing, sakit kepala, nyeri dada, sesak, penglihatan kabur	"Keluhan apa yang paling sering dirasakan?"
Obat	Jenis obat, dosis, kepatuhan, efek samping	"Apakah obat diminum setiap hari?"
Pola makan	Garam, penyedap, makanan instan, buah, sayur	"Apakah keluarga sering mengonsumsi makanan asin?"
Aktivitas fisik	Kebiasaan olahraga, hambatan bergerak	"Apakah ada aktivitas jalan kaki atau olahraga ringan?"
Kebiasaan merokok	Perokok aktif/pasif, lokasi merokok	"Apakah ada anggota keluarga yang merokok di dalam rumah?"
Pemantauan tekanan darah	Alat tensi, cara mengukur, catatan tekanan darah	"Apakah hasil tekanan darah dicatat?"
Dukungan keluarga	Pengingat obat, pengantar kontrol, pengatur makanan	"Siapa yang paling sering membantu perawatan?"
Pemanfaatan fasilitas kesehatan	Puskesmas, posbindu, klinik, jaminan kesehatan	"Ke mana keluarga biasanya kontrol?"

K. Prinsip Komunikasi Saat Melakukan Pengkajian

Pengkajian keperawatan keluarga tidak hanya membutuhkan daftar pertanyaan, tetapi juga kemampuan perawat membangun hubungan saling percaya dengan pasien dan keluarga (Byrne et al., 2023). Keluarga dapat merasa malu, takut disalahkan, atau tidak nyaman ketika kebiasaan rumah tangga seperti pola makan, kepatuhan minum obat, merokok, atau konflik keluarga ditanyakan oleh perawat (Johnson et al., 2021). Oleh karena itu, perawat perlu menggunakan bahasa yang sopan, sederhana, empatik, dan tidak menghakimi agar keluarga merasa aman untuk menyampaikan kondisi sebenarnya (Byrne et al., 2023; Xu et al., 2025). Pendekatan komunikasi yang berpusat pada pasien dan keluarga penting karena dapat membantu meningkatkan keterlibatan keluarga dalam

pengambilan keputusan dan pengelolaan hipertensi sehari-hari (Johnson et al., 2021; Isnaini et al., 2025).

Perawat sebaiknya menghindari kalimat yang membuat keluarga merasa bersalah, seperti "Ibu salah karena terlalu banyak garam" atau "Keluarga tidak peduli dengan pasien," karena komunikasi yang menyalahkan dapat menghambat keterbukaan keluarga saat pengkajian (Byrne et al., 2023). Kalimat tersebut dapat diganti dengan pendekatan yang lebih mendukung, misalnya "Mari kita lihat bersama kebiasaan makan di rumah yang mungkin dapat membantu tekanan darah lebih terkontrol" atau "Siapa anggota keluarga yang paling memungkinkan membantu mengingatkan obat?" (Xu et al., 2025). Pendekatan seperti ini sejalan dengan prinsip komunikasi motivasional yang menekankan empati, dukungan, dan penguatan kemampuan pasien maupun keluarga dalam melakukan perubahan perilaku kesehatan (Xu et al., 2025). Dengan komunikasi yang terbuka dan tidak menghakimi, perawat lebih mudah memperoleh data yang akurat serta membangun kerja sama keluarga dalam pengendalian hipertensi (Isnaini et al., 2025).

Pengkajian juga perlu melibatkan anggota keluarga yang berperan dalam pengambilan keputusan karena pengelolaan hipertensi sering membutuhkan dukungan orang terdekat, baik dalam menentukan pilihan perawatan, mengatur kontrol, maupun menjaga kepatuhan pengobatan (Johnson et al., 2021; Say et al., 2023). Pada beberapa keluarga, keputusan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh pasien, tetapi juga oleh pasangan, anak, atau anggota keluarga yang membiayai pengobatan, sehingga perawat perlu mengetahui siapa yang paling berpengaruh dalam keputusan tersebut (Isnaini et al., 2025). Jika pengkajian hanya dilakukan kepada pasien, perawat dapat kehilangan informasi penting tentang hambatan, dukungan keluarga, kemampuan ekonomi, serta kebiasaan rumah tangga yang memengaruhi pengendalian hipertensi (Guo et al., 2023). Oleh karena itu, pelibatan keluarga dalam pengkajian penting dilakukan karena pendekatan *family centered care* pada pasien hipertensi berdampak baik bagi pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan (Say et al., 2023).

L. Mengidentifikasi Masalah dari Hasil Pengkajian

Setelah data terkumpul, perawat menyusun gambaran masalah keluarga berdasarkan data subjektif dan objektif yang ditemukan selama pengkajian (American Nurses Association, 2024; OpenStax, 2024). Masalah keluarga dapat terlihat dari kurangnya pemahaman keluarga tentang hipertensi, ketidakteraturan minum obat, kebiasaan mengonsumsi makanan tinggi garam, tidak adanya catatan tekanan darah, kurangnya dukungan keluarga, atau jaranganya keluarga

memanfaatkan fasilitas kesehatan (Guo et al., 2023; World Health Organization, 2020). Data tersebut menjadi dasar bagi perawat untuk menentukan diagnosis keperawatan keluarga, menyusun prioritas masalah, dan merencanakan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan keluarga pada tahap asuhan berikutnya (American Nurses Association, 2024; OpenStax, 2024). Hal ini penting karena literasi kesehatan dan dukungan sosial berpengaruh terhadap kepatuhan pengobatan pasien hipertensi, sehingga masalah keluarga yang ditemukan dari hasil pengkajian perlu dijadikan dasar dalam penyusunan rencana edukasi dan pendampingan keluarga (Guo et al., 2023).

Masalah yang sering ditemukan pada keluarga dengan anggota yang menderita hipertensi antara lain kurangnya pengetahuan keluarga tentang hipertensi, manajemen kesehatan keluarga yang belum efektif, ketidakpatuhan terhadap regimen terapeutik, risiko gangguan perfusi jaringan, risiko komplikasi kardiovaskular, serta kesiapan peningkatan manajemen kesehatan keluarga (Guo et al., 2023; World Health Organization, 2020). Masalah tersebut dapat muncul dari data pengkajian seperti keluarga belum memahami hipertensi, pasien tidak rutin minum obat, makanan keluarga masih tinggi garam, tidak ada catatan tekanan darah, atau keluarga jarang memanfaatkan fasilitas kesehatan (Guo et al., 2023). Namun, diagnosis keperawatan tidak boleh ditetapkan hanya berdasarkan dugaan, karena proses keperawatan menempatkan diagnosis sebagai hasil analisis dari data pengkajian yang telah dikumpulkan secara sistematis (American Nurses Association, 2024; OpenStax, 2024). Oleh karena itu, setiap diagnosis keperawatan keluarga perlu didukung oleh data subjektif dan objektif yang jelas agar rencana intervensi benar-benar sesuai dengan masalah dan kebutuhan keluarga (NANDA International, 2024; American Nurses Association, 2024).

Contohnya, jika keluarga mengatakan obat hanya diminum saat pusing, tidak mengetahui komplikasi hipertensi, dan tekanan darah pasien sering tinggi, maka perawat dapat mencurigai adanya masalah pengetahuan dan manajemen kesehatan keluarga. Kondisi tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut karena literasi kesehatan dan dukungan sosial terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan minum obat pada pasien hipertensi (Guo et al., 2023). Jika keluarga memahami hipertensi tetapi tidak mampu mengantar kontrol karena kendala transportasi dan biaya, maka fokus intervensi dapat diarahkan pada pemanfaatan sumber daya kesehatan dan penguatan dukungan sosial. Hal ini sejalan dengan tinjauan Public Health Reviews yang menyimpulkan bahwa hambatan akses pelayanan hipertensi dan diabetes dapat berupa biaya obat, jarak fasilitas kesehatan, biaya transportasi, serta kebutuhan pendampingan, sehingga intervensi perlu mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi keluarga (Peters et al., 2022). Oleh karena itu, perawat perlu

memastikan bahwa masalah keperawatan benar-benar ditetapkan berdasarkan data pengkajian, bukan hanya dugaan, agar rencana intervensi sesuai dengan hambatan utama yang dialami keluarga.

M. Contoh Narasi Hasil Pengkajian

Berikut contoh narasi singkat hasil pengkajian yang dapat digunakan dalam penulisan asuhan keperawatan keluarga:

Keluarga Tn. A terdiri dari suami, istri, dan dua orang anak. Tn. A berusia 58 tahun dan telah mengetahui dirinya menderita hipertensi sejak tiga tahun terakhir. Keluarga mengatakan Tn. A kadang mengeluh pusing dan rasa berat di tengkuk, terutama setelah bekerja dan kurang tidur. Obat hipertensi diperoleh dari puskesmas, tetapi belum diminum secara teratur karena Tn. A merasa obat tidak perlu diminum ketika tubuh terasa sehat. Keluarga belum memiliki catatan tekanan darah di rumah dan hanya memeriksakan tekanan darah ketika ada kegiatan posbindu atau saat muncul keluhan.

Dari pengkajian pola makan, keluarga masih sering mengonsumsi makanan asin, ikan asin, mi instan, gorengan, serta makanan bersantan. Istri Tn. A mengatakan kesulitan mengurangi garam karena anggota keluarga lain belum terbiasa dengan rasa hambar. Aktivitas fisik Tn. A terbatas pada pekerjaan sehari-hari dan belum ada kebiasaan olahraga teratur. Salah satu anggota keluarga masih merokok di dalam rumah. Keluarga mengetahui bahwa hipertensi adalah tekanan darah tinggi, tetapi belum memahami risiko komplikasi dan pentingnya pengobatan jangka panjang.

Berdasarkan data tersebut, perawat perlu memfokuskan intervensi pada peningkatan pemahaman keluarga, pemantauan tekanan darah, dukungan kepatuhan minum obat, penyesuaian pola makan keluarga, pengurangan paparan asap rokok, dan pemanfaatan fasilitas kesehatan secara rutin.

N. Simpulan

Pengkajian keperawatan keluarga pada masalah hipertensi merupakan langkah awal untuk memahami kondisi kesehatan keluarga secara menyeluruh. Pengkajian tidak hanya berfokus pada angka tekanan darah, tetapi juga mencakup pemahaman keluarga, pola makan, aktivitas fisik, kepatuhan minum obat, kebiasaan merokok, stres, dukungan keluarga, lingkungan rumah, serta pemanfaatan fasilitas kesehatan. Melalui pengkajian yang komprehensif, perawat dapat menemukan masalah nyata yang dihadapi keluarga dan menyusun rencana asuhan yang sesuai dengan kebutuhan.

Keluarga memiliki peran penting dalam pengendalian hipertensi karena sebagian besar perawatan dilakukan di rumah. Keluarga dapat membantu mengingatkan obat, menyediakan makanan yang lebih sehat, mendampingi aktivitas fisik, mencatat tekanan darah, mengurangi paparan asap rokok, serta mengantar anggota keluarga untuk kontrol. Oleh sebab itu, keberhasilan asuhan keperawatan keluarga sangat ditentukan oleh kemampuan perawat dalam menggali data, membangun komunikasi, dan melibatkan keluarga sebagai mitra utama dalam perawatan hipertensi.

O. Referensi

-
- Ahmed, W. A. W., Dixit, P. D. P., & Halli, S. H. (2024). Additive interaction of family medical history of cardiovascular diseases with hypertension and diabetes on the diagnosis of cardiovascular diseases among older adults in India. *Frontiers in Cardiovascular Medicine*, 11, 1386378.
- Aljuraiban, G. S., Gibson, R., Chan, D. S. M., Van Horn, L., & Chan, Q. (2023). The role of diet in the prevention of hypertension and management of blood pressure: An umbrella review of meta-analyses of interventional and observational studies. *Advances in Nutrition*.
- Almaghamisi, S. A., & Alzahrani, K. M. (2024). Exploring the influence of perceived social support on medication adherence among patients with chronic hypertension in 2024: A cross-sectional study from Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. *Cureus*, 16(9), e69522.
- American Heart Association. (2024). *Know your risk factors for high blood pressure*.
- American Heart Association. (2025). *Home blood pressure monitoring*.
- American Heart Association. (2025). *When to call 911 about high blood pressure*.
- American Nurses Association. (2024). *The nursing process*.
- Ashktorab, T., et al. (2024). Facilitators of medication adherence in patients with hypertension: A qualitative study. *Frontiers in Public Health*.
- Balagamwala, M., Kuri, S., Jaramillo Mejia, J. G., & de Pee, S. (2024). The affordability gap for nutritious diets: How big is it and how to close it? *Global Food Security*.
- Barbosa, S. S., Sousa, L. C. M., Silva, D. F. O., Pimentel, J. B., Evangelista, K. C. M. S., Lyra, C. O., Lopes, M. M. G. D., & Lima, S. C. V. C. (2022). A systematic review on processed/ultra-processed foods and arterial hypertension in adults and older people. *Nutrients*, 14(6), 1215.
- Byrne, M., Campos, C., Daly, S., Lok, B., & Miles, A. (2023). The current state of empathy, compassion and person-centred communication training in

- healthcare: An umbrella review. *Patient Education and Counseling*, 119, 108063.
- Centers for Disease Control and Prevention. (2024). *High blood pressure risk factors*.
- Centers for Disease Control and Prevention. (2024). *Managing high blood pressure*.
- Centers for Disease Control and Prevention. (2024). *Measuring your blood pressure*.
- Centers for Disease Control and Prevention. (2026). *About high blood pressure*.
- Charchar, F. J., Prestes, P. R., Mills, C., Ching, S. M., Neupane, D., Marques, F. Z., et al. (2024). Lifestyle management of hypertension: International Society of Hypertension position paper endorsed by the World Hypertension League and European Society of Hypertension. *Journal of Hypertension*, 42(1), 23–49.
- Degtyar, A., Wilder, M. E., Richardson, L., et al. (2025). A scoping review of asymptomatic hypertension: Definitions, diagnosis, and management in the emergency department. *Current Hypertension Reports*, 27, 18.
- Friedman, M. M., Bowden, V. R., & Jones, E. G. (2010). *Family nursing: Research, theory, and practice* (5th ed.). Pearson.
- Gilbert-Ouimet, M., Trudel, X., Talbot, D., Vézina, M., Milot, A., & Brisson, C. (2022). Long working hours associated with elevated ambulatory blood pressure among female and male white-collar workers over a 2.5-year follow-up. *Journal of Human Hypertension*, 36, 207–217.
- Gualtieri, L., Rigby, M., Wang, D., & Mann, E. (2024). Medication management strategies to support medication adherence: Interview study with older adults. *Interactive Journal of Medical Research*, 13, e53513.
- Gualtieri, L., Shaveet, E. S., Estime, B. E., & Patel, A. P. (2022). The role of home medication storage location in increasing medication adherence for middle-aged and older adults. *Frontiers in Digital Health*, 4, 999981.
- Guo, A., Jin, H., Mao, J., Zhu, W., Zhou, Y., Ge, X., & Yu, D. (2023). Impact of health literacy and social support on medication adherence in patients with hypertension: A cross-sectional community-based study. *BMC Cardiovascular Disorders*, 23, 93.
- Hasanah, W. T., Sopiah, P., & Setiadi, D. K. (2022). *Hubungan pelaksanaan tugas kesehatan keluarga dengan tingkat kepatuhan penderita hipertensi dalam mengkonsumsi obat antihipertensi*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Heller, C., Haak, M., Schmidt, S. M., Chiatti, C., Ekstam, L., Nilsson, M. H., & Slaug, B. (2023). The relationship between physical housing characteristics, housing accessibility and different aspects of health among community-dwelling older people: A systematic review. *Journal of Aging and Health*.

- Hlyan, N. P., Arif, T., Jaufar, S. S., Rehman, A., Ayalew, B. D., Batu, B. J., Hundesa, M. I., Hlaing, M. S., Islam, H., Islam, R., Shehryar, A., & Quinn, M. (2024). From sugar spikes to pressure peaks: Navigating the world of diabetes, hypertension, obesity, and kidney health. *Cureus*, *16*(3), e57241.
- Horne, C. E., Stayt, L. C., Schutz, S., Smith, C. M., Haberstroh, A., Bolin, L. P., Taylor, C. L., Moosavi, S. H., & Bibbey, A. (2023). Symptom experiences in hypertension: A mixed methods systematic review. *Journal of Hypertension*, *41*(1), 1–16.
- Hosseini, K., Soleimani, H., Tavakoli, K., Maghsoudi, M., Heydari, N., Farahvash, Y., et al. (2024). Association between sleep duration and hypertension incidence: Systematic review and meta-analysis of cohort studies. *PLOS ONE*, *19*(7), e0307120.
- Ishigami, J., Charleston, J., Miller, E. R., Matsushita, K., Appel, L. J., & Brady, T. M. (2023). Effects of cuff size on the accuracy of blood pressure readings: The Cuff(SZ) randomized crossover trial. *JAMA Internal Medicine*, *183*(10), 1061–1068.
- Isnaini, N., Dewi, F. T., Madyaningrum, E., & Noviana, U. (2025). Family-centered education for older adults with hypertension: A scoping review. *Iranian Journal of Public Health*, *54*(1), 36–47.
- Johnson, R., Turner, K. M., Feder, G., & Cramer, H. (2021). Shared decision making in consultations for hypertension: Qualitative study in general practice. *Health Expectations*, *24*(3), 917–929.
- Kaakinen, J. R., Coehlo, D. P., Steele, R., & Robinson, M. (2018). *Family health care nursing: Theory, practice, and research* (6th ed.). F. A. Davis.
- Kartikasari, D., et al. (2025). Literature review: Knowledge and medication adherence in hypertensive patients. *Acta Pharmaceutica Indonesia*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Hipertensi disebut sebagai silent killer, Menkes Budi imbau rutin cek tekanan darah*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Penanganan hipertensi dengan perilaku CERDIK dan PATUH*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Kenali dan kendalikan hipertensi: Si silent killer*.
- Kim, H., & Lee, E. (2022). A study on types of medication adherence in hypertension among older patients and influencing factors. *Healthcare*, *10*(11), 2322.
- Kim, S., Jeong, H. N., & Choi-Kwon, S. (2024). The blood pressure control effect of the sodium-restricted dietary approaches to stop hypertension diet: A systematic review. *British Journal of Nutrition*, *132*(2), 204–217.

- Kreutz, R., Brunström, M., Burnier, M., Grassi, G., Januszewicz, A., Muiesan, M. L., Tsioufis, K., de Pinho, R. M., Albin, F. L., Boivin, J. M., Doumas, M., Nemcsik, J., Rodilla, E., Agabiti-Rosei, E., & Mancina, G. (2024). 2024 European Society of Hypertension clinical practice guidelines for the management of arterial hypertension. *European Journal of Internal Medicine*, 126, 1–15.
- Lauder, L., Mahfoud, F., Azizi, M., Ewen, S., Kario, K., Parati, G., Rossignol, P., Schlaich, M. P., Teo, K. K., Townsend, R. R., Tsioufis, C., Weber, M. A., Weber, T., & Böhm, M. (2023). Hypertension management in patients with cardiovascular comorbidities. *European Heart Journal*, 44(23), 2066–2077.
- Lee, E. M. (2024). When and how to use ambulatory blood pressure monitoring and home blood pressure monitoring for managing hypertension. *Clinical Hypertension*, 30, 10. <https://doi.org/10.1186/s40885-024-00265-w>
- Li, H., et al. (2024). Secondhand smoking increased the possibility of hypertension with a significant time and frequency dose-response relationship. *Scientific Reports*, 14, 24811.
- Lin, Y., et al. (2025). Passive smoking and the risk of hypertension in nonsmoking adults: A systematic review and meta-analysis. *PeerJ*.
- Liu, H., Rakotz, M. K., Wozniak, G. D., et al. (2024). Arm position and blood pressure readings: The ARMS crossover randomized clinical trial. *JAMA Internal Medicine*, 184(12), 1436–1442.
- Maglaya, A. S. (2009). *Nursing practice in the community* (5th ed.). Argonauta Corporation.
- McEvoy, J. W., McCarthy, C. P., Bruno, R. M., et al. (2024). 2024 ESC guidelines for the management of elevated blood pressure and hypertension. *European Heart Journal*, 45(38), 3912–4018.
- MedlinePlus. (2024). *Storing your medicines*. MedlinePlus Medical Encyclopedia.
- Mizuno, A., et al. (2023). Diagnostic accuracy of office blood pressure measurement and home blood pressure monitoring for hypertension screening among adults: Results from the IDH study. *Journal of the American Heart Association*, 12(24), e030150.
- Mohamed, S. F., et al. (2024). The effect of physical activity intervention on blood pressure in 18 low- and middle-income countries: A systematic review and meta-analysis. *Clinical Hypertension*, 30, 17.
- Montero-Odasso, M., van der Velde, N., Martin, F. C., Petrovic, M., Tan, M. P., Ryg, J., et al. (2022). World guidelines for falls prevention and management for older adults: A global initiative. *Age and Ageing*, 51(9), afac205.
- NANDA International. (2024). *NANDA International nursing diagnoses: Definitions and classification, 2024–2026*. NANDA International.

- Nies, M. A., & McEwen, M. (2019). *Community/Public health nursing: Promoting the health of populations* (7th ed.). Elsevier.
- Odoms-Young, A., Brown, A. G. M., Agurs-Collins, T., & Glanz, K. (2024). Food insecurity, neighborhood food environment, and health disparities: State of the science, research gaps and opportunities. *The American Journal of Clinical Nutrition*.
- OpenStax. (2024). *Collection of assessment data*.
- OpenStax. (2024). *Conducting a family nursing assessment*.
- OpenStax. (2024). *Nursing process*.
- Pan, J., Hu, B., Wu, L., & Li, Y. (2021). The effect of social support on treatment adherence in hypertension in China. *Patient Preference and Adherence*, 15, 1953–1961.
- Peng, X., Wan, L., Yu, B., & Zhang, J. (2025). The link between adherence to antihypertensive medications and mortality rates in patients with hypertension: A systematic review and meta-analysis of cohort studies. *BMC Cardiovascular Disorders*, 25, 145.
- Peters, M. D. J., et al. (2022). Barriers and facilitators in access to diabetes, hypertension, and cardiovascular diseases medicines and care in low- and middle-income countries: A scoping review. *Public Health Reviews*.
- Ramadhani, A. I., Noviana, U., & Subekti, H. (2024). Hubungan antara fungsi keluarga dengan manajemen diri penderita hipertensi. *Jurnal Keperawatan Klinis dan Komunitas*, 8(3), 191–201.
- Rifai, M. R., Permana, G. G. S., & Daniati, E. (2025). Improving family independence in hypertension management through a nursing process approach: A case study on Mrs I's family in Garut Regency. *Nursing Case Insight Journal*, 3(2), 41–43.
- Sakir, N. A. I., Hwang, S. B., Park, H. J., & Lee, B. H. (2024). Associations between food consumption/dietary habits and the risks of obesity, type 2 diabetes, and hypertension: A cross-sectional study in Jakarta, Indonesia. *Nutrition Research and Practice*, 18(1), 132–148.
- Say, Y. D. G. P., Arya, I. F. D., & Amelia, I. (2023). The implementation of family centered care in hypertensive patients at private clinic. *Review of Primary Care Practice and Education*, 6(2), 65–72.
- Shahin, W., Kennedy, G. A., & Stupans, I. (2021). The association between social support and medication adherence in patients with hypertension: A systematic review. *Pharmacy Practice*, 19(2), 2300.
- Shimbo, D., et al. (2025). Home blood pressure monitoring. *American Journal of Hypertension*, 38(4), 193–205.

- Simamora, R. H., Siregar, C. T., & Siregar, F. A. (2024). Relationship between family support with low-salt compliance in elderly with hypertension. *Jurnal Berkala Epidemiologi*.
- Siregar, S. M. F., et al. (2024). Knowledge and acceptance associated with medication adherence among hypertension individuals in Aceh Province, Indonesia. *Heliyon*, 10(19), e38873.
- Suhariyanti, E., Anggita, A. L., Pangestu, M., Oktavia, S. R., & Nuranisa, N. (2024). Pendampingan peran keluarga: Lima tugas kesehatan keluarga dalam meningkatkan kualitas hidup lansia dengan hipertensi. *JPKMU: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Kesehatan Galuh*, 1(1), 121–134.
- Usnaini, H., Setyani, F. A. R., & Aryu, S. F. P. (2025). The relationship between family support and adherence to taking medication in hypertension patients at the internal medicine polyclinic. *Lentera Perawat*, 6(1), 101–108.
- Vaismoradi, M., & Logan, P. A. (2025). Contributions of specialized nurses to medication management for older people in home care: A mixed-method systematic review. *Risk Management and Healthcare Policy*, 18, 445–470.
- Validate BP. (2026). *Validated device listing*. American Medical Association.
- Vargas-Meza, J., Gonzalez-Rocha, A., Campos-Nonato, I., Nilson, E. A. F., Basto-Abreu, A., Barquera, S., & Denova-Gutiérrez, E. (2023). Effective and scalable interventions to reduce sodium intake: A systematic review and meta-analysis. *Current Nutrition Reports*, 12, 486–494.
- Webster, K. E., Halicka, M., Bowater, R. J., Parkhouse, T. L., Stanescu, D., Punniyakotty, A. V., et al. (2025). Effectiveness of stress management and relaxation interventions for management of hypertension and prehypertension: Systematic review and network meta-analysis. *BMJ Medicine*, 4(1), e001098.
- World Health Organization. (2020). *HEARTS: Technical package for cardiovascular disease management in primary health care: Risk-based CVD management*.
- World Health Organization. (2020). *WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour*.
- World Health Organization. (2023). *First WHO report details devastating impact of hypertension and ways to stop it*.
- World Health Organization. (2024). *Nearly 1.8 billion adults at risk of disease from not doing enough physical activity*.
- World Health Organization. (2025). *Hypertension*.
- Xu, J., Gu, X., Gu, J., Zhao, L., Li, M., & Hong, C. (2025). Motivational interviewing intervention for the management of hypertension: A meta-analysis. *Frontiers in Cardiovascular Medicine*.

- Yuan, H., Shao, W., Ren, Y., Jiang, M., Kong, J., & Jing, F. (2025). Non-linear effect of physical activity intervention on blood pressure in children and adolescents: A systematic review and dose-response meta-analysis. *BMC Public Health*, 25, 3366.
- Zhang, X., Zhang, P., Shen, D., Li, Y., He, F. J., Ma, J., Yan, W., Gao, Y., Jin, D., Deng, Y., Guo, F., Yan, S., Song, J., MacGregor, G. A., & Wu, J. (2023). Effect of home cook interventions for salt reduction in China: Cluster randomised controlled trial. *BMJ*, 382, e074258.
- Zieliński, G., et al. (2023). Symptoms in hypertensive patients presented to the emergency medical service: A comprehensive retrospective analysis in clinical settings. *Journal of Clinical Medicine*, 12(17), 5495.

CHAPTER 4

DIAGNOSIS KEPERAWATAN KELUARGA YANG SERING MUNCUL

Syaiful, S.Pd., S.Kep., Ns., M.Pd., M.Kes.

A. Pendahuluan

Hipertensi merupakan salah satu masalah kesehatan kronis yang paling sering ditemukan dalam pelayanan kesehatan keluarga dan komunitas. Penyakit ini tidak hanya berkaitan dengan angka tekanan darah, tetapi juga dengan kebiasaan makan, aktivitas fisik, kepatuhan minum obat, kemampuan keluarga mengenali tanda bahaya, dan keberlanjutan kontrol ke fasilitas kesehatan. Karena itu, asuhan keperawatan keluarga pada hipertensi perlu memandang keluarga sebagai unit perawatan, bukan hanya individu yang mengalami peningkatan tekanan darah. Pedoman nasional maupun pedoman internasional menekankan bahwa pengendalian hipertensi membutuhkan kombinasi perubahan gaya hidup, pemantauan tekanan darah, penggunaan obat sesuai indikasi, dan pengelolaan faktor risiko kardiovaskular secara berkelanjutan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021; Mancia et al., 2023; McEvoy et al., 2024).

Dalam praktik keperawatan, keluarga sering menjadi tempat pertama terbentuknya perilaku kesehatan. Pola konsumsi garam, kebiasaan memasak, dukungan terhadap jadwal minum obat, cara keluarga merespons keluhan pusing atau nyeri tengkuk, serta keputusan untuk membawa anggota keluarga kontrol adalah contoh perilaku yang sangat dipengaruhi oleh dinamika keluarga. Oleh sebab itu, diagnosis keperawatan keluarga harus mampu menggambarkan respons keluarga terhadap masalah hipertensi, hambatan yang dialami, dan kekuatan keluarga yang dapat diberdayakan. Kerangka keperawatan keluarga menempatkan keluarga sebagai sistem yang memiliki fungsi afektif, sosialisasi, ekonomi, reproduksi, dan perawatan kesehatan (Friedman et al., 2003; Kaakinen et al., 2023).

Topik diagnosis keperawatan keluarga menjadi penting karena diagnosis adalah jembatan antara pengkajian dan tindakan keperawatan. Apabila diagnosis tidak tepat, maka edukasi, konseling, kunjungan rumah, atau intervensi pendampingan keluarga dapat menjadi kurang terarah. Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI) membantu perawat menyusun diagnosis berdasarkan respons manusia, sedangkan Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI) dan Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI) mengarahkan hasil

yang ingin dicapai dan tindakan yang sesuai (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017; Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 2018; Tim Pokja SLKI DPP PPNI, 2019). Dalam konteks internasional, NANDA-I, NOC, dan NIC juga menyediakan bahasa standar untuk diagnosis, luaran, dan intervensi keperawatan yang dapat digunakan sebagai pembanding konseptual (Herdman et al., 2024; Moorhead et al., 2023; Wagner et al., 2023).

Bab ini membahas diagnosis keperawatan keluarga yang sering muncul pada keluarga dengan anggota yang menderita hipertensi. Pembahasan diarahkan sebagai sajian umum yang tetap akademik, sehingga dapat dibaca oleh mahasiswa keperawatan, dosen, perawat puskesmas, perawat komunitas, dan keluarga yang ingin memahami peran keluarga dalam pengendalian hipertensi. Fokus utama bab ini adalah cara mengenali masalah keluarga, memilih diagnosis yang paling tepat, menyusun prioritas, dan menghubungkan diagnosis dengan luaran serta intervensi yang relevan.

B. Konsep Dasar Diagnosis Keperawatan Keluarga

Diagnosis keperawatan merupakan penilaian klinis perawat terhadap respons individu, keluarga, kelompok, atau komunitas terhadap kondisi kesehatan atau proses kehidupan. Pada keluarga dengan hipertensi, respons tersebut dapat berupa ketidakmampuan keluarga mengatur pola makan, ketidakteraturan kontrol, salah persepsi tentang obat, kurangnya dukungan emosional, atau kesiapan keluarga meningkatkan perilaku sehat. Dengan demikian, diagnosis keperawatan keluarga tidak sama dengan diagnosis medis hipertensi. Diagnosis medis menjelaskan penyakit, sedangkan diagnosis keperawatan menjelaskan respons keluarga terhadap penyakit tersebut (Herdman et al., 2024; Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017).

Dalam keperawatan keluarga, perawat perlu membedakan apakah masalah utama berada pada individu pasien, keluarga sebagai sistem, atau keduanya. Seorang anggota keluarga dapat memiliki hipertensi tidak terkontrol, tetapi diagnosis keperawatan yang dipilih tidak otomatis selalu “defisit pengetahuan”. Jika keluarga sebenarnya sudah mengetahui bahwa konsumsi garam perlu dikurangi, namun makanan sehari-hari tetap tinggi garam karena kebiasaan memasak, tekanan ekonomi, kurangnya pembagian peran, atau pasien merasa tidak didukung, maka diagnosis yang lebih tepat dapat mengarah pada manajemen kesehatan keluarga yang tidak efektif atau perilaku kesehatan yang cenderung berisiko. Di sinilah ketelitian pengkajian keluarga menjadi kunci.

Maglaya (2009) menekankan bahwa pengkajian dan diagnosis keluarga perlu memperhatikan kemampuan keluarga mengenal masalah kesehatan, mengambil

keputusan, merawat anggota keluarga yang sakit, memodifikasi lingkungan, serta memanfaatkan fasilitas kesehatan. Lima kemampuan tersebut sangat relevan pada hipertensi. Keluarga perlu mengenali bahwa hipertensi dapat berlangsung tanpa gejala, mengambil keputusan untuk kontrol teratur, merawat anggota keluarga melalui dukungan diet dan obat, menata lingkungan rumah agar mendukung aktivitas fisik dan istirahat, serta memanfaatkan puskesmas atau fasilitas kesehatan untuk pemantauan.

Diagnosis keluarga yang baik harus memenuhi tiga prinsip. Pertama, diagnosis disusun berdasarkan data pengkajian yang cukup, bukan berdasarkan asumsi. Kedua, diagnosis harus menggambarkan masalah yang dapat diintervensi oleh perawat bersama keluarga. Ketiga, diagnosis perlu diprioritaskan sesuai tingkat ancaman kesehatan, kemampuan keluarga berubah, dan sumber daya yang tersedia. Prinsip ini membantu perawat menghindari daftar diagnosis yang terlalu banyak, tetapi tidak operasional.

C. Landasan Pengkajian untuk Menegakkan Diagnosis Keluarga

Sebelum menuliskan diagnosis, perawat melakukan pengkajian keluarga secara komprehensif. Pengkajian tidak cukup hanya mencatat tekanan darah, keluhan, dan obat yang dikonsumsi. Perawat perlu memahami struktur keluarga, tahap perkembangan keluarga, pola komunikasi, kebiasaan makan, aktivitas harian, kondisi ekonomi, akses layanan kesehatan, keyakinan keluarga tentang hipertensi, dan pengalaman keluarga sebelumnya dalam merawat penyakit kronis. Perspektif keluarga sebagai sistem menuntut perawat melihat keterkaitan antaranggota keluarga, bukan hanya perilaku pasien (Friedman et al., 2003; Kaakinen et al., 2023).

Pada keluarga dengan hipertensi, data objektif yang perlu dikaji mencakup tekanan darah berulang, indeks massa tubuh bila memungkinkan, riwayat kontrol, obat yang digunakan, efek samping obat, penyakit penyerta, kebiasaan merokok, konsumsi garam, konsumsi makanan tinggi lemak, aktivitas fisik, kualitas tidur, dan tanda komplikasi. Pedoman hipertensi menempatkan pengukuran tekanan darah yang benar, penilaian risiko kardiovaskular, dan modifikasi gaya hidup sebagai bagian penting pengelolaan hipertensi (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021; Mancina et al., 2023; McEvoy et al., 2024).

Data subjektif juga sangat menentukan. Perawat perlu menggali apa yang keluarga pahami tentang hipertensi, bagaimana keluarga memaknai angka tekanan darah, siapa yang mengingatkan minum obat, bagaimana keluarga menyiapkan makanan, apa hambatan kontrol, dan bagaimana keluarga merespons ketika pasien merasa sehat sehingga ingin menghentikan obat. Pada banyak keluarga, hipertensi dianggap hanya perlu diobati saat ada keluhan. Persepsi

seperti ini dapat menjadi dasar munculnya diagnosis defisit pengetahuan, ketidakpatuhan, atau manajemen kesehatan keluarga yang tidak efektif.

Selain data masalah, perawat perlu menggali kekuatan keluarga. Kekuatan tersebut dapat berupa anggota keluarga yang peduli, adanya kader kesehatan di lingkungan sekitar, akses ke puskesmas, kemampuan menggunakan telepon untuk pengingat obat, kebiasaan berjalan pagi, atau pengalaman keluarga merawat penyakit kronis lain. Kekuatan keluarga penting karena diagnosis tidak selalu berupa masalah aktual. Pada keluarga yang sudah menunjukkan kemauan berubah, diagnosis promosi kesehatan seperti kesiapan peningkatan manajemen kesehatan keluarga dapat menjadi pilihan yang lebih tepat (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017; Herdman et al., 2024).

Tabel 4.1: Fokus Pengkajian Keluarga pada Hipertensi

Area pengkajian	Data yang perlu digali	Makna untuk diagnosis keperawatan keluarga
Pemahaman keluarga	Pengertian hipertensi, penyebab, tanda bahaya, manfaat kontrol, alasan obat harus diminum teratur.	Menilai kemungkinan defisit pengetahuan, persepsi keliru, atau kesiapan peningkatan pengetahuan.
Manajemen obat	Jadwal obat, siapa yang mengingatkan, kepatuhan, efek samping, obat tradisional, penghentian obat saat gejala membaik.	Menilai ketidakpatuhan atau manajemen kesehatan keluarga tidak efektif.
Pola makan keluarga	Konsumsi garam, makanan olahan, santan/lemak, kebiasaan makan bersama, cara memasak, kemampuan membeli bahan sehat.	Menilai perilaku kesehatan cenderung berisiko atau hambatan modifikasi gaya hidup.
Aktivitas dan Istirahat	Aktivitas fisik, pekerjaan, kebiasaan duduk lama, tidur, stres, rekreasi, dukungan keluarga untuk bergerak.	Menilai kemampuan keluarga menciptakan lingkungan yang mendukung pengendalian tekanan darah.
Pemanfaatan layanan	Kunjungan puskesmas, posbindu/posyandu lansia, jaminan kesehatan, jarak	Menilai pemeliharaan kesehatan tidak efektif atau

	layanan, pengalaman dengan tenaga kesehatan.	kesiapan meningkatkan manajemen kesehatan.
Dukungan keluarga	Komunikasi, pembagian peran, konflik, beban caregiver, dukungan emosional, keputusan keluarga.	Menilai koping keluarga tidak efektif atau kebutuhan penguatan dukungan keluarga.

Sumber: *Disusun penulis berdasarkan kerangka keperawatan keluarga, standar diagnosis keperawatan, dan pedoman pengelolaan hipertensi (Friedman et al., 2003; Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021; Maglaya, 2009; Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017).*

D. Diagnosis Keperawatan Keluarga yang Sering Muncul

Diagnosis yang sering muncul tidak boleh dipahami sebagai daftar baku yang selalu sama pada setiap keluarga. Setiap keluarga memiliki karakteristik, sumber daya, nilai budaya, dan hambatan yang berbeda. Namun, dalam praktik asuhan keperawatan keluarga pada hipertensi, terdapat beberapa diagnosis yang sering dijumpai karena hipertensi menuntut perubahan perilaku jangka panjang, pemantauan rutin, kepatuhan terapi, dan keterlibatan keluarga. Diagnosis berikut disajikan dengan bahasa yang disesuaikan dengan standar nasional dan pembeda internasional, serta dipadukan dengan contoh data dan fokus intervensi.

1. Manajemen kesehatan keluarga tidak efektif

Diagnosis ini sering menjadi diagnosis utama pada keluarga dengan anggota yang mengalami hipertensi tidak terkontrol. Fokusnya adalah ketidakmampuan keluarga mengintegrasikan program perawatan hipertensi ke dalam kehidupan sehari-hari. Keluarga mungkin mengetahui bahwa hipertensi harus dikontrol, tetapi belum mampu membangun rutinitas minum obat, mengatur diet, memantau tekanan darah, atau mengantar anggota keluarga kontrol. Dalam standar internasional, diagnosis ini memiliki kedekatan konseptual dengan ineffective family health management (Herdman et al., 2024). Dalam standar nasional, perawat dapat merujuk pada SDKI dan menghubungkannya dengan luaran serta intervensi yang sesuai melalui SLKI dan SIKI (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017; Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 2018; Tim Pokja SLKI DPP PPNI, 2019).

Data yang mendukung diagnosis ini dapat berupa tekanan darah anggota keluarga yang sering tinggi, jadwal kontrol tidak teratur, obat sering terlupa,

keluarga tidak memiliki catatan tekanan darah, makanan rumah tetap tinggi garam, dan keluarga belum membagi peran dalam perawatan. Pada keluarga tertentu, pasien sebenarnya ingin patuh tetapi anggota keluarga lain tetap menyediakan makanan tinggi garam atau tidak mendukung aktivitas fisik. Situasi ini menunjukkan bahwa masalah bukan semata-mata pada individu pasien, melainkan pada pola manajemen keluarga.

Akar masalah dapat berhubungan dengan kompleksitas regimen pengobatan, kurangnya dukungan keluarga, persepsi keliru bahwa hipertensi hanya berbahaya saat ada keluhan, keterbatasan ekonomi, atau rendahnya kemampuan keluarga memanfaatkan layanan kesehatan. Pedoman hipertensi menegaskan bahwa pengendalian tekanan darah membutuhkan pemantauan dan perubahan gaya hidup berkelanjutan; hal ini sulit dicapai tanpa dukungan keluarga (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021; Mancia et al., 2023).

Contoh perumusan diagnosis: Manajemen kesehatan keluarga tidak efektif berhubungan dengan kurangnya dukungan keluarga dan ketidakmampuan keluarga mengintegrasikan program perawatan hipertensi ke dalam kebiasaan harian, dibuktikan dengan tekanan darah anggota keluarga belum terkontrol, obat sering tidak diminum sesuai jadwal, keluarga belum melakukan pembatasan garam, dan kontrol ke puskesmas tidak teratur.

2. Pemeliharaan kesehatan tidak efektif

Pemeliharaan kesehatan tidak efektif dapat muncul ketika keluarga belum mampu mempertahankan perilaku kesehatan dasar untuk mencegah perburukan hipertensi. Diagnosis ini sesuai digunakan bila keluarga kurang melakukan tindakan pencegahan dan pemeliharaan kesehatan, misalnya jarang melakukan pemeriksaan tekanan darah, tidak memahami pentingnya pemeriksaan berkala, tidak memanfaatkan posbindu atau puskesmas, serta belum memiliki kebiasaan hidup sehat yang konsisten. Diagnosis ini dapat berkaitan dengan kurangnya akses, rendahnya motivasi, atau kurangnya dukungan sosial (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017).

Berbeda dengan manajemen kesehatan keluarga tidak efektif yang menekankan kegagalan mengelola regimen perawatan yang sudah ada, pemeliharaan kesehatan tidak efektif lebih menekankan kegagalan mempertahankan perilaku promotif dan preventif. Pada keluarga hipertensi, perawat dapat menemukan keluarga yang belum pernah memeriksakan tekanan darah secara rutin, menganggap pemeriksaan hanya diperlukan saat sakit, atau tidak mengetahui keberadaan layanan skrining tekanan darah di

masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan risiko keterlambatan deteksi komplikasi.

Diagnosis ini relevan terutama pada keluarga dengan anggota yang baru diketahui hipertensi, keluarga usia lanjut yang tinggal sendiri, atau keluarga dengan akses layanan yang terbatas. Intervensi yang dapat dikaitkan meliputi edukasi perilaku hidup sehat, peningkatan literasi kesehatan, fasilitasi pemanfaatan layanan, dan penguatan dukungan keluarga. Dalam NIC, intervensi yang sejalan mencakup health education, health screening, self-management assistance, dan family support dalam makna umum yang disesuaikan dengan kondisi keluarga (Wagner et al., 2023).

Contoh perumusan diagnosis: Pemeliharaan kesehatan tidak efektif dibuktikan dengankurangnya pengetahuan tentang pemeriksaan tekanan darah berkala dan kurangnya pemanfaatan fasilitas kesehatan, ditandai dengan keluarga tidak pernah mencatat tekanan darah, kontrol hanya dilakukan saat muncul keluhan, dan keluarga belum mengikuti kegiatan skrining di masyarakat.

3. Defisit pengetahuan tentang hipertensi

Defisit pengetahuan merupakan diagnosis yang sangat sering ditemukan, tetapi perawat perlu menggunakannya secara selektif. Tidak semua ketidakpatuhan disebabkan oleh kurang pengetahuan. Diagnosis ini tepat bila data menunjukkan keluarga belum memahami konsep hipertensi, faktor risiko, tanda bahaya, manfaat obat, cara mengurangi garam, atau alasan kontrol harus dilakukan meskipun tidak ada keluhan. NANDA-I dan SDKI sama-sama menempatkan masalah pengetahuan sebagai respons yang dapat diintervensi melalui edukasi terstruktur (Herdman et al., 2024; Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017).

Pada keluarga dengan hipertensi, defisit pengetahuan sering tampak melalui pernyataan seperti “obat diminum kalau pusing saja”, “kalau tekanan darah sudah turun berarti sembuh”, “garam sedikit tidak masalah”, atau “hipertensi hanya penyakit orang tua biasa”. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya informasi yang belum tepat. Keluarga mungkin belum memahami bahwa hipertensi sering tidak bergejala, tetapi dapat menyebabkan komplikasi seperti stroke, penyakit jantung, dan gangguan ginjal bila tidak dikendalikan dengan baik (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021; McEvoy et al., 2024).

Edukasi pada diagnosis ini sebaiknya tidak hanya berupa penyuluhan satu arah. Keluarga perlu diajak menyebutkan kembali informasi penting, membaca label makanan, mempraktikkan cara mengukur tekanan darah bila tersedia alat,

menyusun jadwal obat, dan membuat rencana kontrol. Pendekatan family-centered lebih efektif karena anggota keluarga lain ikut memahami perannya. Kaakinen et al. (2023) menekankan bahwa edukasi keluarga perlu mempertimbangkan tahap perkembangan keluarga, budaya, pengalaman sakit, dan pola komunikasi.

Contoh perumusan diagnosis: Defisit pengetahuan tentang hipertensi berhubungan dengan kurang terpapar informasi yang benar, dibuktikan dengan keluarga menyatakan obat cukup diminum saat ada keluhan, belum mengetahui batasan konsumsi garam, dan belum memahami pentingnya kontrol tekanan darah secara berkala.

4. Ketidakpatuhan terhadap regimen terapeutik

Ketidakpatuhan dapat muncul ketika anggota keluarga yang mengalami hipertensi atau keluarga sebagai pendukung perawatan tidak mengikuti program pengobatan, diet, aktivitas fisik, atau kontrol sesuai anjuran. Diagnosis ini perlu ditegakkan berdasarkan data perilaku, bukan penilaian moral. Perawat harus menghindari pendekatan menyalahkan pasien. Ketidakpatuhan dapat dipengaruhi oleh efek samping obat, biaya transportasi, lupa, rasa bosan karena terapi jangka panjang, kurang dukungan keluarga, rendahnya kepercayaan terhadap obat, atau pengalaman buruk dengan layanan kesehatan (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017; Wagner et al., 2023).

Dalam keluarga dengan hipertensi, ketidakpatuhan sering berupa obat tidak diminum saat tekanan darah terasa normal, jadwal kontrol terlewat, diet rendah garam tidak dijalankan, dan anjuran aktivitas fisik tidak dilakukan. Pada lansia, ketidakpatuhan juga dapat terkait gangguan penglihatan, penurunan daya ingat, banyaknya obat yang dikonsumsi, atau tidak adanya anggota keluarga yang membantu. Oleh karena itu, perawat perlu mengkaji hambatan konkret sebelum menyusun intervensi.

Strategi mengatasi ketidakpatuhan harus bersifat praktis dan sesuai konteks. Keluarga dapat dilatih membuat kotak obat mingguan, memasang pengingat di telepon, menghubungkan jadwal obat dengan kegiatan rutin, menyiapkan catatan tekanan darah, atau melibatkan anggota keluarga yang paling dekat dengan pasien. Dalam NOC, luaran yang relevan dapat berupa adherence behavior, knowledge: medication, dan health-seeking behavior; sedangkan dalam SLKI dapat dipadankan dengan kepatuhan, tingkat pengetahuan, dan manajemen kesehatan keluarga sesuai rumusan yang tersedia (Moorhead et al., 2023; Tim Pokja SLKI DPP PPNI, 2019).

Contoh perumusan diagnosis: Ketidakpatuhan terhadap regimen terapeutik dibuktikan dengan kurangnya dukungan keluarga dan persepsi keliru tentang kebutuhan obat jangka panjang, ditandai dengan pasien menghentikan obat saat keluhan membaik, keluarga tidak mengingatkan jadwal minum obat, dan kontrol tekanan darah tidak dilakukan sesuai jadwal.

5. Perilaku kesehatan cenderung berisiko

Diagnosis perilaku kesehatan cenderung berisiko dapat digunakan ketika keluarga menunjukkan pola perilaku yang meningkatkan kemungkinan tekanan darah tidak terkontrol atau komplikasi. Contoh perilaku tersebut meliputi kebiasaan mengonsumsi makanan tinggi garam, sering makan makanan olahan, merokok di rumah, kurang aktivitas fisik, mengabaikan istirahat, stres tidak terkelola, atau tetap mempertahankan pola hidup yang berisiko meskipun sudah ada riwayat hipertensi dalam keluarga. Diagnosis ini penting karena hipertensi sangat dipengaruhi oleh gaya hidup sehari-hari (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021; Mancía et al., 2023).

Perawat perlu menilai apakah perilaku berisiko tersebut merupakan pilihan individu atau norma keluarga. Misalnya, pasien hipertensi sulit menjalankan diet rendah garam karena semua makanan keluarga dimasak dengan garam dan penyedap berlebih. Dalam kondisi seperti ini, intervensi yang hanya menasihati pasien sering tidak berhasil. Perubahan harus diarahkan pada dapur keluarga, keputusan belanja, cara memasak, dan dukungan anggota keluarga. Keluarga juga perlu memahami bahwa perubahan pola makan tidak berarti makanan menjadi tidak enak, melainkan perlu penyesuaian bertahap.

Diagnosis ini juga dapat muncul pada keluarga dengan kebiasaan merokok. Asap rokok di rumah bukan hanya masalah individu perokok, tetapi juga faktor lingkungan keluarga yang dapat memperburuk risiko kardiovaskular. Perawat dapat mengajak keluarga membuat aturan rumah bebas asap rokok, memilih aktivitas fisik keluarga, dan mengembangkan menu harian yang lebih sehat. Intervensi promosi kesehatan dalam NIC dan SIKI dapat diarahkan pada edukasi gaya hidup sehat, dukungan perubahan perilaku, konseling nutrisi, dan peningkatan aktivitas fisik (Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 2018; Wagner et al., 2023).

Contoh perumusan diagnosis: Perilaku kesehatan cenderung berisiko dibuktikan dengan kebiasaan keluarga mengonsumsi makanan tinggi garam dan kurang aktivitas fisik, ditandai dengan keluarga sering mengonsumsi makanan asin, pasien jarang berolahraga, dan tidak ada kesepakatan keluarga untuk mengubah pola makan.

6. Koping keluarga tidak efektif

Koping keluarga tidak efektif dapat terjadi ketika keluarga mengalami kesulitan beradaptasi dengan tuntutan perawatan hipertensi, terutama bila hipertensi disertai komplikasi, penyakit penyerta, keterbatasan ekonomi, atau konflik peran. Keluarga mungkin menunjukkan sikap saling menyalahkan, menolak membicarakan penyakit, merasa lelah merawat, atau tidak mampu mengambil keputusan saat tekanan darah meningkat. Diagnosis ini menekankan respons emosional dan pola penyelesaian masalah keluarga (Friedman et al., 2003; Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017).

Hipertensi sering dianggap penyakit ringan karena banyak pasien tidak merasakan gejala. Namun, ketika terjadi komplikasi atau pasien harus minum obat jangka panjang, keluarga dapat mengalami stres. Anggota keluarga yang menjadi caregiver mungkin merasa terbebani, terutama bila harus mengatur obat, mengantar kontrol, mengubah menu, dan tetap menjalankan pekerjaan. Perawat perlu mengkaji perasaan keluarga, sumber dukungan, konflik, dan kemampuan keluarga menyelesaikan masalah.

Intervensi pada diagnosis ini tidak cukup hanya memberikan informasi. Perawat dapat memfasilitasi komunikasi keluarga, membantu keluarga menyusun pembagian peran, mengidentifikasi anggota keluarga yang dapat menjadi pendukung utama, dan menghubungkan keluarga dengan kader atau kelompok dukungan. Family Health Care Nursing menekankan pentingnya kemitraan perawat-keluarga, validasi pengalaman keluarga, dan pendekatan yang menghargai kekuatan keluarga (Kaakinen et al., 2023).

Contoh perumusan diagnosis: Koping keluarga tidak efektif berhubungan dengan beban perawatan jangka panjang dan kurangnya pembagian peran, dibuktikan dengan keluarga menyatakan lelah mengingatkan pasien minum obat, sering terjadi konflik tentang diet, dan keputusan kontrol sering tertunda.

7. Kesiapan peningkatan manajemen kesehatan keluarga

Tidak semua diagnosis keperawatan keluarga harus berfokus pada masalah. Pada keluarga yang sudah menunjukkan motivasi, memiliki dukungan, dan ingin memperbaiki perawatan hipertensi, perawat dapat menggunakan diagnosis promosi kesehatan. Kesiapan peningkatan manajemen kesehatan keluarga sesuai bila keluarga telah memiliki perilaku dasar yang baik, tetapi ingin meningkatkan kemampuan mengelola hipertensi secara lebih mandiri. Diagnosis ini sejalan dengan prinsip pemberdayaan keluarga dalam keperawatan komunitas (Maglaya, 2009; Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017).

Contoh keluarga yang sesuai dengan diagnosis ini adalah keluarga yang sudah mengantar pasien kontrol, tetapi ingin belajar mencatat tekanan darah; keluarga yang sudah mulai mengurangi garam, tetapi ingin menyusun menu mingguan; atau keluarga yang sudah patuh obat, tetapi ingin menambah aktivitas fisik bersama. Diagnosis ini penting karena perawat tidak hanya hadir saat keluarga bermasalah, tetapi juga saat keluarga siap meningkatkan kualitas perawatan.

Luaran yang dapat diarahkan antara lain meningkatnya manajemen kesehatan keluarga, peningkatan pengetahuan, peningkatan perilaku kesehatan, dan peningkatan dukungan keluarga. Intervensi dapat berupa edukasi lanjutan, pelatihan pemantauan tekanan darah, penyusunan rencana perawatan keluarga, penguatan motivasi, dan pemanfaatan sumber daya masyarakat seperti posbindu, posyandu lansia, atau layanan puskesmas. Dalam NOC dan NIC, konsep ini sejalan dengan peningkatan self-management, family health status, health behavior, dan family support (Moorhead et al., 2023; Wagner et al., 2023).

Contoh perumusan diagnosis: Kesiapan peningkatan manajemen kesehatan keluarga dibuktikan dengan keluarga menyatakan ingin belajar memantau tekanan darah di rumah, sudah mendukung pasien kontrol ke puskesmas, dan bersedia menyusun jadwal obat serta menu rendah garam.

8. Risiko penurunan curah jantung atau risiko perfusi jaringan tidak efektif sebagai diagnosis pendukung

Pada beberapa kasus, hipertensi yang tidak terkontrol dapat meningkatkan risiko komplikasi kardiovaskular, serebrovaskular, dan ginjal. Dalam asuhan keluarga, diagnosis yang berkaitan dengan risiko fisiologis dapat muncul sebagai diagnosis pendukung, terutama bila pasien memiliki tekanan darah sangat tinggi, keluhan nyeri dada, sesak, gangguan penglihatan, kelemahan anggota gerak, riwayat stroke, diabetes, atau penyakit ginjal. Namun, diagnosis keluarga tetap perlu diarahkan pada respons keluarga terhadap risiko tersebut, misalnya kemampuan mengenali tanda bahaya dan mengambil keputusan untuk mencari pertolongan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021; McEvoy et al., 2024).

Perawat keluarga perlu berhati-hati membedakan diagnosis prioritas yang memerlukan rujukan segera dengan diagnosis yang dapat ditangani melalui edukasi dan pendampingan. Jika ditemukan tanda bahaya seperti nyeri dada berat, sesak, penurunan kesadaran, kelemahan mendadak pada satu sisi tubuh, atau tekanan darah sangat tinggi disertai gejala berat, tindakan utama adalah

rujukan atau kolaborasi medis sesuai kewenangan. Setelah kondisi akut tertangani, diagnosis keluarga seperti manajemen kesehatan keluarga tidak efektif atau defisit pengetahuan dapat menjadi fokus lanjutan.

Dengan demikian, diagnosis risiko fisiologis tidak menggantikan diagnosis keluarga, tetapi dapat memperkuat urgensi intervensi. Keluarga perlu dibekali kemampuan mengenali gejala yang tidak boleh ditunda dan memahami kapan harus segera ke fasilitas kesehatan. Pendidikan tanda bahaya merupakan bagian penting dari asuhan keperawatan keluarga pada hipertensi.

Tabel 4.2. *Diagnosis Keperawatan Keluarga yang Sering Muncul pada Hipertensi*

Diagnosis keperawatan	Petunjuk data keluarga	Fokus luaran dan intervensi
Manajemen kesehatan keluarga tidak efektif	Tekanan darah tidak terkontrol, obat tidak teratur, kontrol tidak konsisten, tidak ada pembagian peran, pola makan keluarga belum berubah.	Manajemen kesehatan keluarga meningkat; edukasi, dukungan kepatuhan, rencana perawatan keluarga, pemantauan tekanan darah.
Pemeliharaan kesehatan tidak efektif	Keluarga tidak melakukan pemeriksaan berkala, belum memanfaatkan layanan, tindakan pencegahan rendah.	Perilaku pemeliharaan kesehatan meningkat; fasilitasi akses layanan, skrining, promosi kesehatan.
Defisit pengetahuan	Keluarga memiliki persepsi keliru tentang hipertensi, obat, diet, tanda bahaya, atau kontrol rutin.	Pengetahuan meningkat; edukasi hipertensi, teach back, media sederhana, demonstrasi.
Ketidakpatuhan	Obat dihentikan, diet tidak dijalankan, kontrol terlewat, aktivitas fisik tidak dilakukan sesuai anjuran.	Kepatuhan meningkat; identifikasi hambatan, pengingat obat, dukungan keluarga, kontrak perilaku.
Perilaku kesehatan	Konsumsi garam tinggi, merokok, kurang aktivitas, stres tidak terkelola,	Perilaku kesehatan membaik; konseling gaya hidup, dukungan

Diagnosis keperawatan	Petunjuk data keluarga	Fokus luaran dan intervensi
cenderung berisiko	kebiasaan keluarga tidak sehat.	perubahan perilaku, modifikasi lingkungan rumah.
Koping keluarga tidak efektif	Keluarga lelah, konflik, menolak masalah, tidak mampu mengambil keputusan, caregiver merasa terbebani.	Koping keluarga membaik; dukungan emosional, fasilitasi komunikasi, pembagian peran, rujukan dukungan.
Kesiapan peningkatan manajemen kesehatan keluarga	Keluarga sudah memiliki perilaku dasar baik dan ingin meningkatkan kemampuan merawat hipertensi.	Manajemen kesehatan keluarga semakin baik; edukasi lanjutan, penguatan motivasi, perencanaan mandiri.

Sumber: Disusun penulis berdasarkan SDKI-SLKI-SIKI, NANDA-I, NOC, NIC, dan kerangka keperawatan keluarga (Herdman et al., 2024; Moorhead et al., 2023; Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017; Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 2018; Tim Pokja SLKI DPP PPNI, 2019; Wagner et al., 2023).

E. Menentukan Prioritas Diagnosis Keluarga

Setelah beberapa diagnosis teridentifikasi, perawat perlu menentukan prioritas. Prioritas tidak selalu berarti diagnosis yang paling banyak datanya, tetapi diagnosis yang paling mengancam kesehatan, paling mungkin diubah, dan paling penting bagi keluarga. Pada hipertensi, prioritas dapat berubah sesuai kondisi. Jika pasien menunjukkan tanda bahaya, prioritas awal adalah keselamatan dan rujukan. Jika tidak ada kondisi akut, prioritas dapat diarahkan pada manajemen keluarga, kepatuhan, pengetahuan, atau perilaku risiko.

Maglaya (2009) mengajarkan pentingnya mempertimbangkan sifat masalah, kemungkinan masalah dapat diubah, potensi pencegahan, dan penonjolan masalah bagi keluarga. Dalam praktik, perawat dapat bertanya: apakah masalah ini mengancam keselamatan? apakah keluarga menyadari masalah? apakah keluarga memiliki sumber daya untuk berubah? apakah perubahan dapat dilakukan bertahap? Pertanyaan-pertanyaan tersebut membantu perawat memilih diagnosis yang realistis dan bermakna.

Pada keluarga dengan hipertensi tidak terkontrol, diagnosis manajemen kesehatan keluarga tidak efektif sering menjadi prioritas karena mencakup banyak perilaku inti: obat, diet, kontrol, pemantauan, dan dukungan keluarga. Namun, jika akar masalahnya jelas berupa ketidaktahuan, defisit pengetahuan dapat didahulukan. Jika keluarga sudah tahu tetapi tidak menjalankan perawatan karena hambatan konkret, ketidakpatuhan atau perilaku kesehatan cenderung berisiko dapat lebih tepat. Jika keluarga mengalami konflik dan kelelahan, koping keluarga tidak efektif perlu diperhatikan agar intervensi lain dapat berjalan.

Prioritas diagnosis juga perlu dinegosiasikan dengan keluarga. Perawat dapat menyampaikan hasil pengkajian dalam bahasa yang mudah dipahami, kemudian meminta keluarga memilih perubahan yang paling siap dilakukan. Misalnya, keluarga belum siap mengubah semua menu, tetapi bersedia mengurangi garam sedikit demi sedikit dan mencatat tekanan darah. Kesepakatan kecil yang realistis sering lebih berhasil daripada target besar yang tidak dijalankan.

Tabel 4.3: Pertimbangan Prioritas Diagnosis pada Keluarga dengan Hipertensi

Pertanyaan prioritas	Contoh pada keluarga hipertensi	Implikasi bagi perawat
Apakah ada ancaman segera?	Tekanan darah sangat tinggi disertai nyeri dada, sesak, kelemahan mendadak, atau penurunan kesadaran.	Utamakan rujukan/kolaborasi, kemudian lanjutkan edukasi keluarga setelah kondisi stabil.
Apakah keluarga menyadari masalah?	Keluarga menganggap hipertensi tidak berbahaya karena pasien tidak merasa sakit.	Mulai dari edukasi risiko, tanda bahaya, dan makna tekanan darah.
Apakah masalah dapat diubah?	Keluarga bersedia mengurangi garam, tetapi belum mampu membeli alat ukur tekanan darah.	Pilih intervensi yang realistis, misalnya kontrol di puskesmas/posbindu dan perubahan menu bertahap.
Apakah keluarga memiliki dukungan?	Ada anak yang dapat mengingatkan obat dan mengantar kontrol.	Libatkan anggota keluarga tersebut sebagai pendukung utama.

Apakah keluarga memiliki hambatan besar?	Biaya transportasi, konflik keluarga, pasien menolak obat, caregiver kelelahan.	Gabungkan edukasi dengan pemecahan masalah, konseling, dan fasilitasi sumber daya.
--	---	--

Sumber: Disusun penulis berdasarkan prinsip penentuan prioritas masalah keluarga dan asuhan keperawatan keluarga (Friedman et al., 2003; Maglaya, 2009).

F. Contoh Perumusan Diagnosis pada Kasus Keluarga

Agar lebih aplikatif, bagian ini menyajikan contoh singkat perumusan diagnosis. Contoh tidak dimaksudkan sebagai satu-satunya jawaban, melainkan sebagai latihan berpikir klinis. Perawat tetap harus menyesuaikan diagnosis dengan data pengkajian nyata di lapangan.

Kasus 1: Keluarga dengan hipertensi tidak terkontrol dan obat tidak teratur

Seorang ibu berusia 58 tahun memiliki riwayat hipertensi selama lima tahun. Tekanan darah terakhir di puskesmas 170/100 mmHg. Ibu mengatakan obat diminum jika kepala terasa berat. Anak yang tinggal serumah bekerja hingga sore dan tidak mengetahui jadwal obat. Keluarga masih memasak makanan asin karena semua anggota keluarga menyukai rasa tersebut. Kontrol ke puskesmas dilakukan bila obat habis atau ada keluhan.

Diagnosis utama yang dapat dipilih adalah manajemen kesehatan keluarga tidak efektif. Data pendukungnya meliputi tekanan darah belum terkontrol, obat tidak diminum teratur, tidak ada pengingat obat, diet keluarga belum berubah, dan kontrol tidak rutin. Defisit pengetahuan juga mungkin ada, tetapi diagnosis utama lebih luas karena masalah mencakup pola manajemen keluarga. Luaran yang dapat dipilih adalah meningkatnya manajemen kesehatan keluarga, kepatuhan, dan pengetahuan. Intervensi meliputi edukasi hipertensi, penyusunan jadwal obat, pembagian peran keluarga, pengurangan garam bertahap, dan rencana kontrol teratur (Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 2018; Tim Pokja SLKI DPP PPNI, 2019).

Kasus 2: Keluarga memahami hipertensi tetapi sulit mengubah kebiasaan makan

Seorang bapak berusia 62 tahun sudah mengetahui bahwa hipertensi perlu diet rendah garam. Keluarga pernah mendapatkan penyuluhan di puskesmas. Namun, keluarga tetap sering mengonsumsi ikan asin, makanan bersantan, dan makanan kemasan. Istri pasien mengatakan sulit memasak menu berbeda karena semua anggota keluarga makan bersama. Pasien juga jarang beraktivitas fisik karena merasa cepat lelah.

Diagnosis yang lebih tepat dapat berupa perilaku kesehatan cenderung berisiko atau manajemen kesehatan keluarga tidak efektif, tergantung data

dominan. Jika keluarga sebenarnya tahu tetapi norma makan keluarga tetap berisiko, perilaku kesehatan cenderung berisiko dapat menjadi fokus. Intervensi diarahkan pada perubahan lingkungan rumah, demonstrasi menu rendah garam, kesepakatan belanja bahan makanan, dan aktivitas fisik ringan bersama. Perawat perlu menghindari instruksi yang terlalu ideal, misalnya langsung melarang semua makanan favorit, karena perubahan bertahap lebih mungkin diterima keluarga.

Kasus 3: Keluarga siap meningkatkan pemantauan tekanan darah

Seorang lansia dengan hipertensi tinggal bersama anaknya. Keluarga rutin mengantar kontrol dan obat diminum sesuai jadwal. Keluarga mulai mengurangi garam, tetapi belum mencatat tekanan darah. Anak pasien meminta diajari cara memantau tekanan darah dan ingin membuat catatan untuk dibawa saat kontrol.

Diagnosis yang sesuai adalah kesiapan peningkatan manajemen kesehatan keluarga. Diagnosis ini menghargai kekuatan keluarga dan mendorong kemandirian. Intervensi dapat berupa pelatihan pengukuran tekanan darah, pembuatan buku catatan tekanan darah, edukasi tanda bahaya, dan penguatan rencana kontrol. Luaran diarahkan pada peningkatan manajemen kesehatan keluarga, perilaku kesehatan, dan pemanfaatan layanan kesehatan.

G. Integrasi SDKI-SLKI-SIKI dengan NANDA-I, NOC, dan NIC

Dalam penulisan akademik dan praktik keperawatan di Indonesia, SDKI-SLKI-SIKI merupakan rujukan utama karena menyediakan bahasa standar nasional. Namun, NANDA-I, NOC, dan NIC tetap bermanfaat sebagai pembanding internasional, terutama ketika penulis atau perawat ingin memperluas kajian teori, menyusun materi ajar, atau membandingkan istilah dengan literatur global. Integrasi kedua sistem harus dilakukan secara hati-hati. Istilah tidak selalu sama persis, sehingga perawat perlu menggunakan padanan konseptual, bukan sekadar menerjemahkan kata demi kata.

SDKI membantu perawat menetapkan diagnosis, SLKI membantu menentukan indikator keberhasilan, dan SIKI membantu memilih tindakan. NANDA-I menyediakan klasifikasi diagnosis internasional, NOC menyediakan label luaran dan indikator hasil, sedangkan NIC menyediakan klasifikasi intervensi. Ketiganya dapat memperkaya naskah bookchapter karena pembaca dapat melihat bahwa diagnosis keperawatan keluarga pada hipertensi memiliki landasan nasional dan internasional (Herdman et al., 2024; Moorhead et al., 2023; Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017; Wagner et al., 2023).

Dalam praktik, perawat dapat menulis diagnosis menggunakan istilah SDKI, kemudian menjelaskan padanan konseptual dengan NANDA-I bila diperlukan. Luaran dapat ditulis menggunakan SLKI, lalu diperkuat dengan konsep NOC seperti

kepatuhan, perilaku kesehatan, atau status kesehatan keluarga. Intervensi dapat menggunakan SIKI, lalu diperkuat dengan NIC seperti edukasi kesehatan, dukungan keluarga, konseling nutrisi, bantuan manajemen diri, dan peningkatan kepatuhan. Pendekatan ini membuat naskah tetap sesuai konteks Indonesia sekaligus terbuka terhadap literatur internasional.

Tabel 4.4: Contoh Pemetaan Diagnosis, Luaran, dan Intervensi

Diagnosis berbasis SDKI	Padanan konseptual internasional	Contoh luaran	Contoh intervensi
Manajemen kesehatan keluarga tidak efektif	Ineffective family health management	Manajemen kesehatan keluarga meningkat; kepatuhan meningkat; perilaku kesehatan membaik.	Edukasi hipertensi; dukungan kepatuhan; pelibatan keluarga; penyusunan rencana kontrol.
Defisit pengetahuan	Deficient knowledge	Pengetahuan tentang hipertensi meningkat; kemampuan menjelaskan obat dan diet meningkat.	Edukasi kesehatan; penggunaan media sederhana; teach back; demonstrasi pengukuran tekanan darah.
Ketidakpatuhan	Nonadherence	Kepatuhan minum obat dan kontrol meningkat; perilaku mengikuti anjuran membaik.	Identifikasi hambatan; pengingat obat; dukungan keluarga; kontrak perilaku; kolaborasi bila ada efek samping.

Perilaku kesehatan cenderung berisiko	Risk-prone health behavior	Perilaku kesehatan membaik; konsumsi garam menurun; aktivitas fisik meningkat.	Konseling gaya hidup; modifikasi lingkungan; perencanaan menu; dukungan aktivitas fisik.
Koping keluarga tidak efektif	Ineffective family coping	Koping keluarga membaik; dukungan keluarga meningkat; komunikasi keluarga membaik.	Dukungan emosional; fasilitasi komunikasi; pembagian peran; rujukan dukungan sosial.
Kesiapan peningkatan manajemen kesehatan keluarga	Readiness for enhanced family health management	Kemandirian keluarga meningkat; pemantauan tekanan darah membaik.	Edukasi lanjutan; pelatihan pemantauan; penguatan motivasi; pemanfaatan posbindu/puskesmas.

Sumber: Disusun penulis berdasarkan SDKI-SLKI-SIKI dan NANDA-I-NOC-NIC (Herdman et al., 2024; Moorhead et al., 2023; Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017; Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 2018; Tim Pokja SLKI DPP PPNI, 2019; Wagner et al., 2023).

H. Kesalahan yang Sering Terjadi dalam Menetapkan Diagnosis

Kesalahan pertama adalah menyamakan diagnosis medis dengan diagnosis keperawatan. Menulis “hipertensi” sebagai diagnosis keperawatan keluarga tidak menggambarkan respons keluarga yang perlu diintervensi. Perawat perlu menuliskan masalah keperawatan seperti manajemen kesehatan keluarga tidak efektif, defisit pengetahuan, ketidakpatuhan, atau perilaku kesehatan cenderung berisiko sesuai data.

Kesalahan kedua adalah terlalu cepat menetapkan defisit pengetahuan. Pada banyak kasus, keluarga sudah mengetahui informasi dasar, tetapi belum mampu

menerapkannya karena hambatan kebiasaan, ekonomi, dukungan, atau motivasi. Jika perawat hanya memberi penyuluhan berulang tanpa memahami hambatan perilaku, perubahan tidak akan terjadi. Oleh karena itu, pengkajian harus membedakan antara tidak tahu, tidak mampu, tidak mau, dan tidak didukung.

Kesalahan ketiga adalah menulis terlalu banyak diagnosis tanpa prioritas. Daftar diagnosis yang panjang dapat membingungkan keluarga dan membuat intervensi tidak fokus. Perawat sebaiknya memilih satu sampai tiga diagnosis prioritas sesuai kebutuhan keluarga. Diagnosis lain dapat dicatat sebagai masalah pendukung dan dievaluasi pada kunjungan berikutnya.

Kesalahan keempat adalah tidak melibatkan keluarga dalam validasi diagnosis. Diagnosis keluarga sebaiknya dikomunikasikan kembali kepada keluarga dengan bahasa sederhana. Misalnya, perawat dapat mengatakan, "Dari cerita Bapak/Ibu, tampaknya keluarga masih kesulitan membuat jadwal obat dan mengurangi garam. Apakah keluarga setuju bila kita mulai dari dua hal itu?" Validasi seperti ini meningkatkan rasa memiliki keluarga terhadap rencana perawatan.

I. Peran Perawat dalam Menindaklanjuti Diagnosis

Diagnosis keperawatan keluarga tidak berhenti pada penulisan format asuhan. Setelah diagnosis ditetapkan, perawat perlu merancang luaran yang terukur dan intervensi yang sesuai kemampuan keluarga. Luaran harus realistis, misalnya keluarga mampu menyebutkan kembali tiga tanda bahaya hipertensi, keluarga membuat jadwal minum obat, keluarga mencatat tekanan darah minimal sekali seminggu, atau keluarga mengurangi penggunaan garam secara bertahap. Luaran seperti ini lebih mudah dievaluasi dibandingkan pernyataan umum seperti "keluarga memahami hipertensi".

Intervensi harus memadukan edukasi, konseling, dukungan perilaku, dan fasilitasi akses layanan. Pada hipertensi, intervensi yang sering diperlukan adalah edukasi tentang hipertensi, pengaturan diet rendah garam, dukungan kepatuhan obat, latihan aktivitas fisik aman, manajemen stres, pemantauan tekanan darah, pengenalan tanda bahaya, dan pemanfaatan layanan puskesmas atau posbindu. SIKI dan NIC dapat menjadi rujukan untuk memilih intervensi yang sesuai, sedangkan SLKI dan NOC membantu menentukan indikator hasil (Moorhead et al., 2023; Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 2018; Tim Pokja SLKI DPP PPNI, 2019; Wagner et al., 2023).

Perawat juga berperan sebagai fasilitator perubahan keluarga. Perubahan perilaku pada hipertensi tidak dapat terjadi hanya melalui instruksi. Keluarga membutuhkan pendampingan, penguatan, dan solusi yang sesuai kehidupan

sehari-hari. Misalnya, mengurangi garam dapat dimulai dari mengurangi penyedap, membatasi makanan asin tertentu, atau mengganti teknik memasak. Aktivitas fisik dapat dimulai dari berjalan kaki ringan sesuai kemampuan. Pemantauan tekanan darah dapat dilakukan di puskesmas, posbindu, atau rumah bila ada alat.

Evaluasi diagnosis perlu dilakukan secara berkala. Jika keluarga sudah mampu mengelola obat dan kontrol, diagnosis manajemen kesehatan keluarga tidak efektif dapat dinyatakan membaik atau berubah menjadi kesiapan peningkatan manajemen kesehatan keluarga. Jika masih ada hambatan, perawat perlu mengkaji ulang penyebabnya. Evaluasi yang baik menunjukkan bahwa diagnosis keperawatan bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan keluarga.

J. Penutup

Diagnosis keperawatan keluarga pada keluarga dengan anggota yang menderita hipertensi merupakan dasar penting untuk menyusun asuhan yang tepat, terarah, dan berpusat pada keluarga. Diagnosis yang sering muncul meliputi manajemen kesehatan keluarga tidak efektif, pemeliharaan kesehatan tidak efektif, defisit pengetahuan, ketidakpatuhan, perilaku kesehatan cenderung berisiko, koping keluarga tidak efektif, dan kesiapan peningkatan manajemen kesehatan keluarga. Diagnosis tersebut perlu dipilih berdasarkan data pengkajian, bukan berdasarkan kebiasaan atau asumsi.

Keluarga memegang peran besar dalam pengendalian hipertensi karena pengobatan dan perubahan gaya hidup berlangsung di lingkungan rumah. Perawat perlu mengkaji pemahaman keluarga, kebiasaan makan, kepatuhan obat, dukungan anggota keluarga, pemanfaatan layanan kesehatan, serta kemampuan keluarga mengambil keputusan. Pengkajian yang komprehensif akan menghasilkan diagnosis yang lebih tepat dan intervensi yang lebih realistis.

Penggunaan SDKI-SLKI-SIKI sebagai rujukan nasional, dipadukan dengan NANDA-I, NOC, dan NIC sebagai pembanding internasional, dapat memperkuat kualitas naskah dan praktik keperawatan. Sementara itu, teori keperawatan keluarga dari Maglaya, Friedman, dan Kaakinen membantu perawat memahami bahwa keluarga adalah sistem yang memiliki kekuatan, masalah, nilai, dan sumber daya. Dengan diagnosis yang tepat, perawat dapat membantu keluarga mengubah hipertensi dari masalah yang diabaikan menjadi kondisi yang dikelola bersama secara sadar, terencana, dan berkelanjutan.

K. Glosarium

Glosarium berikut memuat istilah-istilah penting yang digunakan dalam pembahasan diagnosis keperawatan keluarga pada keluarga dengan anggota yang menderita hipertensi.

Tabel 4.5: Glosarium Diagnosis Keperawatan Keluarga pada Hipertensi

No	Istilah	Pengertian
1	Hipertensi	Kondisi peningkatan tekanan darah yang berlangsung menetap dan memerlukan pengendalian jangka panjang melalui terapi, pemantauan, serta perubahan gaya hidup.
2	Diagnosis keperawatan keluarga	Penilaian klinis perawat terhadap respons keluarga sebagai unit perawatan terhadap masalah kesehatan aktual, risiko, atau kesiapan peningkatan kesehatan.
3	Manajemen kesehatan keluarga tidak efektif	Ketidakmampuan keluarga mengatur, menjalankan, atau mempertahankan program perawatan kesehatan anggota keluarga secara konsisten dan tepat.
4	Pemeliharaan kesehatan tidak efektif	Ketidakmampuan individu atau keluarga mengenali, mengelola, dan mencari bantuan kesehatan yang diperlukan untuk mempertahankan status kesehatan.
5	Defisit pengetahuan	Keterbatasan informasi atau pemahaman keluarga tentang hipertensi, pengobatan, diet, kontrol tekanan darah, atau pencegahan komplikasi.
6	Ketidakpatuhan	Perilaku tidak mengikuti anjuran terapi atau rencana perawatan, seperti tidak teratur minum obat, tidak kontrol, atau tidak menjalankan diet rendah garam.
7	Perilaku kesehatan cenderung berisiko	Pola perilaku keluarga yang meningkatkan peluang terjadinya masalah kesehatan, misalnya konsumsi tinggi garam, merokok, kurang aktivitas fisik, atau kontrol tekanan darah yang tidak teratur.

8	Koping keluarga tidak efektif	Ketidakmampuan keluarga beradaptasi secara konstruktif terhadap tuntutan perawatan penyakit kronis, konflik peran, stres, atau beban perawatan.
9	Kesiapan peningkatan manajemen kesehatan keluarga	Kondisi ketika keluarga telah menunjukkan motivasi dan kemampuan dasar untuk meningkatkan pengelolaan kesehatan secara lebih mandiri dan terencana.
10	Luaran dan intervensi keperawatan	Luaran adalah hasil yang diharapkan setelah asuhan keperawatan, sedangkan intervensi adalah tindakan yang dirancang untuk mencapai luaran tersebut.

Sumber: Disusun penulis berdasarkan kerangka SDKI-SLKI-SIKI, NANDA-I, NOC, NIC, dan konsep keperawatan keluarga.

L. Referensi

- Friedman, M. M., Bowden, V. R., & Jones, E. G. (2003). *Family nursing: Research, theory, and practice* (5th ed.). Prentice Hall.
- Herdman, T. H., Kamitsuru, S., & Lopes, C. T. (Eds.). (2024). *NANDA International nursing diagnoses: Definitions and classification, 2024-2026* (13th ed.). Thieme.
- Kaakinen, J. R., Coehlo, D. P., Steele, R., Tabacco, A., & Hanson, S. M. H. (Eds.). (2023). *Family health care nursing: Theory, practice, and research* (7th ed.). F. A. Davis.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4634/2021 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Hipertensi Dewasa. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. <https://kemkes.go.id/id/pnpk-2021---tata-laksana-hipertensi-dewasa>
- Maglaya, A. S. (Ed.). (2009). *Nursing practice in the community* (4th ed.). Argonauta Corporation.
- Mancia, G., Kreutz, R., Brunström, M., Burnier, M., Grassi, G., Januszewicz, A., Muiesan, M. L., Tsioufis, K., Agabiti-Rosei, E., Algharably, E. A. E., Azizi, M., Benetos, A., Borghi, C., Coca, A., Cifkova, R., Cruickshank, J. K., Cunha, P. G., Danser, A. H. J., Dominiczak, A. F., ... Kjeldsen, S. E. (2023). 2023 ESH guidelines for the management of arterial hypertension: The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of

Hypertension. *Journal of Hypertension*, 41(12), 1874-2071.
<https://doi.org/10.1097/HJH.0000000000003480>

- McEvoy, J. W., McCarthy, C. P., Bruno, R. M., Brouwers, S., Canavan, M. D., Ceconi, C., Christodorescu, R. M., Daskalopoulou, S. S., Ferro, C. J., Gerdts, E., Hanssen, H., Harris, J., Lauder, L., McManus, R. J., Molloy, G. J., Rahimi, K., Regitz-Zagrosek, V., Rossi, G. P., Sandset, E. C., ... Touyz, R. M. (2024). 2024 ESC guidelines for the management of elevated blood pressure and hypertension. *European Heart Journal*, 45(38), 3912-4018.
<https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehae178>
- Moorhead, S., Swanson, E., & Johnson, M. (Eds.). (2023). *Nursing outcomes classification (NOC): Measurement of health outcomes* (7th ed.). Elsevier.
- Tim Pokja SDKI DPP PPNI. (2017). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan indikator diagnostik* (Edisi 1). Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- Tim Pokja SIKI DPP PPNI. (2018). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia: Definisi dan tindakan keperawatan* (Edisi 1). Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- Tim Pokja SLKI DPP PPNI. (2019). *Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan kriteria hasil keperawatan* (Edisi 1). Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- Wagner, C. M., Butcher, H. K., & Clarke, M. F. (Eds.). (2023). *Nursing interventions classification (NIC)* (8th ed.). Elsevier.

CHAPTER 5

INTERVENSI EDUKASI DIET, AKTIVITAS FISIK, KEPATUHAN OBAT DAN PEMANTAUAN TEKANAN DARAH

Ns. Prima Trisna Aji, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.MB.

A. Pendahuluan

Hipertensi merupakan salah satu penyakit tidak menular yang menjadi masalah kesehatan global dengan prevalensi yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan bahwa lebih dari 1,28 miliar orang dewasa di dunia menderita hipertensi, dan sebagian besar di antaranya tidak terdiagnosis maupun tidak terkontrol dengan baik (World Health Organization, 2021). Hipertensi dikenal sebagai silent killer karena seringkali tidak menimbulkan gejala yang jelas, namun memiliki konsekuensi serius berupa peningkatan risiko penyakit kardiovaskular, stroke, gagal ginjal, dan kematian dini (Williams et al., 2023). Di Indonesia sendiri, prevalensi hipertensi masih tinggi dan menjadi salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas, yang menunjukkan bahwa pengelolaan hipertensi belum optimal, terutama dalam aspek perubahan perilaku dan kepatuhan terapi jangka panjang (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

Pengelolaan hipertensi tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan farmakologis semata, melainkan harus diintegrasikan dengan intervensi non-farmakologis yang berfokus pada perubahan gaya hidup, termasuk diet sehat, aktivitas fisik teratur, kepatuhan dalam penggunaan obat, serta pemantauan tekanan darah secara rutin (McEvoy et al., 2024). Bukti ilmiah terkini menunjukkan bahwa kombinasi intervensi gaya hidup dan kepatuhan terapi mampu menurunkan tekanan darah secara signifikan serta mengurangi risiko komplikasi kardiovaskular jangka panjang (Monfared et al., 2024). Namun demikian, implementasi intervensi tersebut seringkali mengalami hambatan, terutama karena kurangnya pemahaman pasien dan keterbatasan dukungan lingkungan terdekat, khususnya keluarga.

Dalam perspektif keperawatan keluarga, hipertensi tidak hanya dipandang sebagai masalah individu, tetapi sebagai masalah yang melibatkan sistem keluarga secara keseluruhan. Keluarga memiliki peran penting dalam menentukan pola makan sehari-hari, kebiasaan aktivitas fisik, kepatuhan minum obat, serta pemantauan kondisi kesehatan anggota keluarga yang menderita hipertensi (Kebebew et al., 2026). Oleh karena itu, pendekatan berbasis keluarga (family-centered care) menjadi strategi yang sangat relevan dalam meningkatkan

keberhasilan pengelolaan hipertensi. Intervensi yang melibatkan keluarga terbukti lebih efektif dalam meningkatkan self-management pasien, dibandingkan intervensi yang hanya berfokus pada individu (Yuan et al., 2025).

Peran keluarga dalam pengelolaan hipertensi mencakup berbagai aspek, mulai dari dukungan emosional, pengawasan perilaku kesehatan, hingga pengambilan keputusan terkait perawatan. Dukungan keluarga yang baik dapat meningkatkan motivasi pasien dalam menjalankan terapi, memperbaiki kepatuhan terhadap pengobatan, serta mendorong perubahan gaya hidup yang lebih sehat (Desta et al., 2022). Sebaliknya, kurangnya dukungan keluarga dapat menjadi faktor penghambat utama dalam pengendalian hipertensi, yang berdampak pada buruknya kontrol tekanan darah dan meningkatnya risiko komplikasi (Stephen et al., 2022).

Salah satu aspek penting dalam pengelolaan hipertensi adalah edukasi diet. Pola makan yang tinggi natrium, lemak jenuh, dan makanan olahan telah terbukti berkontribusi terhadap peningkatan tekanan darah (Kim et al., 2024). Sebaliknya, penerapan pola makan sehat seperti DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) yang kaya akan buah, sayur, serat, dan rendah garam terbukti efektif dalam menurunkan tekanan darah secara signifikan (Bensaaud et al., 2025). Namun, perubahan pola makan tidak mudah dilakukan apabila tidak didukung oleh seluruh anggota keluarga, mengingat kebiasaan makan biasanya merupakan hasil dari pola konsumsi bersama dalam rumah tangga.

Selain diet, aktivitas fisik juga merupakan komponen penting dalam pengendalian hipertensi. Aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur dapat meningkatkan elastisitas pembuluh darah, menurunkan resistensi perifer, serta membantu mengontrol berat badan (Hejazi et al., 2025). Meskipun demikian, tingkat kepatuhan pasien terhadap aktivitas fisik masih rendah, terutama karena kurangnya motivasi, keterbatasan waktu, serta minimnya dukungan lingkungan keluarga (Monfared et al., 2024). Oleh karena itu, keterlibatan keluarga dalam mendorong dan mendampingi aktivitas fisik menjadi faktor kunci dalam keberhasilan intervensi ini.

Kepatuhan terhadap pengobatan merupakan aspek lain yang sangat menentukan dalam pengelolaan hipertensi. Banyak pasien menghentikan atau tidak rutin mengonsumsi obat karena merasa tidak bergejala, khawatir terhadap efek samping, atau kurang memahami pentingnya terapi jangka panjang (Hong et al., 2022). Penelitian menunjukkan bahwa intervensi berbasis edukasi yang melibatkan keluarga dapat meningkatkan kepatuhan minum obat secara signifikan, terutama melalui penggunaan strategi pengingat, pengawasan bersama, dan dukungan emosional (Hoppe et al., 2023). Hal ini menunjukkan

bahwa keluarga memiliki peran strategis dalam memastikan keberlanjutan terapi pasien hipertensi.

Pemantauan tekanan darah secara mandiri (home blood pressure monitoring) juga menjadi komponen penting dalam pengelolaan hipertensi modern. Pemantauan ini memungkinkan pasien dan keluarga untuk mengetahui kondisi tekanan darah secara real-time, mengevaluasi efektivitas terapi, serta mendeteksi dini kemungkinan komplikasi (Stergiou et al., 2021). Studi terbaru menunjukkan bahwa penggunaan pemantauan tekanan darah di rumah yang dikombinasikan dengan edukasi kesehatan dapat meningkatkan kontrol tekanan darah secara signifikan dibandingkan pemantauan di fasilitas kesehatan saja (Liu et al., 2025). Oleh karena itu, edukasi mengenai teknik pengukuran tekanan darah yang benar serta interpretasi hasil menjadi sangat penting untuk diberikan kepada keluarga.

Seiring dengan perkembangan teknologi, intervensi berbasis digital (digital health atau mHealth) juga mulai banyak digunakan dalam pengelolaan hipertensi. Penggunaan aplikasi kesehatan, pengingat obat berbasis digital, serta pemantauan tekanan darah secara daring terbukti dapat meningkatkan kepatuhan pasien dan efektivitas pengelolaan hipertensi (Yuting et al., 2023). Integrasi teknologi ini dengan pendekatan keperawatan keluarga memberikan peluang besar dalam meningkatkan kualitas asuhan keperawatan, khususnya dalam konteks manajemen penyakit kronis seperti hipertensi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan hipertensi memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, yang tidak hanya berfokus pada pasien, tetapi juga melibatkan keluarga sebagai sistem pendukung utama. Intervensi edukasi yang meliputi diet, aktivitas fisik, kepatuhan obat, dan pemantauan tekanan darah merupakan pilar utama dalam pengendalian hipertensi yang efektif. Oleh karena itu, perawat memiliki peran strategis sebagai edukator, fasilitator, dan motivator dalam memberdayakan keluarga agar mampu berpartisipasi aktif dalam pengelolaan hipertensi secara mandiri dan berkelanjutan.

Bab ini akan membahas secara mendalam mengenai intervensi edukasi berbasis keluarga dalam pengelolaan hipertensi, yang meliputi edukasi diet, aktivitas fisik, kepatuhan obat, dan pemantauan tekanan darah, serta strategi implementasinya dalam praktik keperawatan keluarga.

B. Peran Keluarga dalam Pengelolaan Hipertensi

Hipertensi sebagai penyakit kronis memerlukan pengelolaan jangka panjang yang tidak hanya bergantung pada intervensi medis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor perilaku dan lingkungan sosial, terutama keluarga. Dalam konteks ini, keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran strategis dalam menjaga, mempertahankan, dan meningkatkan status kesehatan anggotanya. Pendekatan keperawatan keluarga menempatkan keluarga sebagai sistem yang saling berinteraksi, di mana perubahan pada satu anggota akan memengaruhi anggota lainnya, sehingga intervensi kesehatan perlu diarahkan pada keseluruhan sistem keluarga, bukan hanya individu pasien (Kaakinen et al., 2021).

Keluarga berfungsi sebagai primary support system yang memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku kesehatan pasien hipertensi. Dukungan keluarga mencakup aspek emosional, instrumental, informasional, dan penghargaan, yang secara bersama-sama dapat meningkatkan motivasi pasien dalam menjalankan terapi dan perubahan gaya hidup (Desta et al., 2022). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pasien hipertensi yang mendapatkan dukungan keluarga yang baik memiliki tingkat kepatuhan pengobatan yang lebih tinggi dan kontrol tekanan darah yang lebih baik dibandingkan dengan pasien yang kurang mendapatkan dukungan (Kebebew et al., 2026). Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan hipertensi tidak hanya ditentukan oleh intervensi klinis, tetapi juga oleh kualitas interaksi dan dukungan dalam keluarga.

Secara teoritis, peran keluarga dalam pengelolaan hipertensi dapat dijelaskan melalui beberapa model, salah satunya adalah Health Belief Model (HBM). Model ini menjelaskan bahwa perilaku kesehatan seseorang dipengaruhi oleh persepsi terhadap kerentanan penyakit, tingkat keparahan, manfaat tindakan, serta hambatan yang dirasakan. Dalam konteks keluarga, anggota keluarga berperan dalam membentuk persepsi tersebut melalui komunikasi, pengalaman bersama, serta pemberian dukungan yang dapat memperkuat keyakinan pasien untuk menjalankan perilaku sehat (Rosenstock et al., 1988; Glanz et al., 2021). Dengan demikian, keluarga tidak hanya sebagai pendamping, tetapi juga sebagai agen perubahan perilaku yang aktif.

Selain itu, Family Systems Theory juga memberikan pemahaman bahwa keluarga merupakan sistem terbuka yang saling bergantung, di mana setiap perubahan perilaku pada satu anggota akan berdampak pada keseluruhan sistem keluarga (Kaakinen et al., 2021). Dalam pengelolaan hipertensi, perubahan pola makan, aktivitas fisik, dan kepatuhan obat tidak dapat dilakukan secara individual tanpa dukungan lingkungan keluarga. Misalnya, pasien akan sulit menjalankan diet

rendah garam apabila anggota keluarga lainnya tetap mengonsumsi makanan tinggi natrium dalam satu rumah. Oleh karena itu, intervensi harus diarahkan pada perubahan perilaku kolektif dalam keluarga.

Peran keluarga dalam pengelolaan hipertensi dapat diidentifikasi melalui lima tugas kesehatan keluarga, yaitu mengenal masalah kesehatan, mengambil keputusan, merawat anggota keluarga yang sakit, memodifikasi lingkungan, dan memanfaatkan fasilitas kesehatan (Friedman et al., 2021). Dalam tahap mengenal masalah, keluarga perlu memiliki pengetahuan yang cukup tentang hipertensi, termasuk faktor risiko, tanda bahaya, serta komplikasi yang mungkin terjadi. Pengetahuan ini menjadi dasar dalam menentukan sikap dan tindakan keluarga dalam menghadapi kondisi hipertensi.

Dalam aspek pengambilan keputusan, keluarga berperan dalam menentukan pilihan terapi, kepatuhan terhadap pengobatan, serta keputusan untuk mencari pelayanan kesehatan. Keputusan ini seringkali dipengaruhi oleh nilai, budaya, pengalaman, serta tingkat pendidikan keluarga. Oleh karena itu, perawat perlu melibatkan keluarga secara aktif dalam proses edukasi dan pengambilan keputusan agar intervensi yang diberikan dapat diterima dan dijalankan secara optimal (Stephen et al., 2022).

Peran keluarga dalam merawat anggota yang sakit mencakup berbagai aktivitas, seperti menyiapkan makanan sehat, mengingatkan jadwal minum obat, mendampingi aktivitas fisik, serta memantau kondisi kesehatan pasien. Dukungan instrumental ini sangat penting dalam memastikan bahwa pasien mampu menjalankan terapi secara konsisten. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan keluarga dalam perawatan sehari-hari dapat meningkatkan self-management pasien hipertensi secara signifikan (Yuan et al., 2025).

Selain itu, keluarga juga berperan dalam memodifikasi lingkungan yang mendukung perilaku sehat. Lingkungan rumah yang kondusif, seperti tersedianya makanan sehat, suasana yang mendukung aktivitas fisik, serta pengurangan stres, dapat membantu pasien dalam mengontrol tekanan darah. Lingkungan yang tidak mendukung, seperti kebiasaan konsumsi makanan tinggi garam atau gaya hidup sedentari dalam keluarga, dapat menjadi hambatan dalam pengelolaan hipertensi (Monfared et al., 2024).

Dalam aspek pemanfaatan fasilitas kesehatan, keluarga berperan dalam mendorong pasien untuk melakukan pemeriksaan rutin, mengikuti kontrol ke fasilitas kesehatan, serta memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia. Keterlibatan keluarga dalam proses ini terbukti dapat meningkatkan kepatuhan pasien dalam melakukan kontrol dan monitoring tekanan darah (Hoppe et al.,

2023). Hal ini menunjukkan bahwa keluarga memiliki peran penting dalam menjembatani antara pasien dan sistem pelayanan kesehatan.

Namun demikian, tidak semua keluarga mampu menjalankan peran tersebut secara optimal. Berbagai hambatan dapat memengaruhi peran keluarga, seperti rendahnya pengetahuan, keterbatasan ekonomi, budaya, serta kurangnya akses terhadap informasi kesehatan. Selain itu, dinamika keluarga seperti konflik, kurangnya komunikasi, serta beban peran juga dapat memengaruhi efektivitas dukungan yang diberikan kepada pasien (Glanz et al., 2021). Oleh karena itu, intervensi keperawatan perlu mempertimbangkan kondisi dan karakteristik masing-masing keluarga.

Dalam perkembangan terbaru, pendekatan family empowerment menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan peran keluarga dalam pengelolaan penyakit kronis. Pendekatan ini menekankan pada peningkatan kapasitas keluarga melalui edukasi, pelatihan, dan pendampingan, sehingga keluarga mampu mengambil peran aktif dalam perawatan anggota yang sakit (Kebebew et al., 2026). Intervensi berbasis keluarga yang terstruktur terbukti dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan keluarga dalam mengelola hipertensi.

Selain itu, integrasi teknologi dalam keperawatan keluarga juga memberikan peluang baru dalam meningkatkan peran keluarga. Penggunaan aplikasi kesehatan, pengingat obat berbasis digital, serta pemantauan tekanan darah secara daring memungkinkan keluarga untuk lebih terlibat dalam proses monitoring dan pengambilan keputusan (Yuting et al., 2023). Pendekatan ini sangat relevan di era digital, di mana akses terhadap informasi dan teknologi semakin mudah.

Perawat memiliki peran strategis dalam mengoptimalkan fungsi keluarga melalui pendekatan edukatif, suportif, dan kolaboratif. Perawat tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga membantu keluarga dalam memahami kondisi pasien, mengidentifikasi hambatan, serta mengembangkan strategi yang sesuai dengan kondisi keluarga. Pendekatan komunikasi terapeutik dan pemberdayaan keluarga menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas intervensi keperawatan keluarga (Kaakinen et al., 2021).

Dengan demikian, peran keluarga dalam pengelolaan hipertensi sangat kompleks dan multidimensional, mencakup aspek pengetahuan, sikap, perilaku, serta dukungan sosial. Keluarga bukan hanya sebagai pendamping, tetapi sebagai mitra utama dalam proses perawatan. Oleh karena itu, intervensi keperawatan yang berfokus pada keluarga memiliki potensi besar dalam meningkatkan keberhasilan pengelolaan hipertensi dan kualitas hidup pasien secara keseluruhan (Yuan et al., 2025).

C. Intervensi Edukasi Diet pada Hipertensi

Pernikahan usia remaja menyebabkan masa reproduksi seorang perempuan menjadi lebih panjang. Apabila tidak di kontrol maka akan berdampak pada

Diet merupakan salah satu pilar utama dalam pengelolaan hipertensi yang terbukti efektif menurunkan tekanan darah baik secara mandiri maupun sebagai terapi kombinasi dengan obat antihipertensi. Intervensi diet menjadi sangat penting karena sebagian besar faktor risiko hipertensi berkaitan erat dengan pola konsumsi makanan sehari-hari, terutama asupan natrium yang berlebihan, konsumsi lemak jenuh, rendahnya asupan serat, serta tingginya konsumsi makanan olahan (ultra-processed food) (Kim et al., 2024). Pedoman global terbaru menegaskan bahwa modifikasi diet merupakan intervensi lini pertama dalam pencegahan dan pengendalian hipertensi, bahkan sebelum atau bersamaan dengan terapi farmakologis (World Health Organization, 2021; McEvoy et al., 2024).

Dalam konteks keperawatan keluarga, edukasi diet tidak hanya ditujukan kepada pasien, tetapi harus melibatkan seluruh anggota keluarga sebagai satu kesatuan sistem. Hal ini disebabkan karena pola makan individu sangat dipengaruhi oleh kebiasaan makan dalam keluarga. Perubahan diet akan sulit dipertahankan apabila hanya dilakukan oleh satu anggota keluarga, sementara anggota lainnya tetap mempertahankan pola makan yang tidak sehat. Oleh karena itu, pendekatan edukasi diet berbasis keluarga menjadi strategi yang lebih efektif dalam menciptakan perubahan perilaku yang berkelanjutan (Kebebew et al., 2026).

1. Prinsip Dasar Diet pada Hipertensi

Edukasi diet pada pasien hipertensi harus berfokus pada beberapa prinsip utama, yaitu:

a. Pembatasan asupan natrium

WHO merekomendasikan konsumsi natrium tidak lebih dari 2 gram per hari atau setara dengan 5 gram garam dapur (World Health Organization, 2021). Asupan natrium yang tinggi terbukti meningkatkan tekanan darah melalui mekanisme retensi cairan dan peningkatan resistensi vaskular.

b. Peningkatan konsumsi buah dan sayur

Buah dan sayur kaya akan kalium, magnesium, dan serat yang berperan dalam menurunkan tekanan darah serta meningkatkan kesehatan kardiovaskular (Bensaoud et al., 2025).

c. Pengurangan lemak jenuh dan kolesterol

Lemak jenuh dapat meningkatkan risiko aterosklerosis yang memperburuk kondisi hipertensi (McEvoy et al., 2024).

d. Pembatasan makanan olahan

Makanan instan, makanan kaleng, dan makanan cepat saji mengandung natrium tinggi yang sering tidak disadari oleh pasien (Kim et al., 2024).

e. Pengaturan berat badan

Diet yang sehat juga berperan dalam menjaga indeks massa tubuh (IMT) yang optimal, yang berhubungan langsung dengan penurunan tekanan darah (Monfared et al., 2024).

2. Diet DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension)

Salah satu pendekatan diet yang paling direkomendasikan dalam pengelolaan hipertensi adalah Diet DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension). Diet ini menekankan konsumsi makanan rendah natrium, tinggi serat, serta kaya mineral penting seperti kalium, kalsium, dan magnesium.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penerapan diet DASH secara konsisten dapat menurunkan tekanan darah sistolik hingga 8–14 mmHg, terutama bila dikombinasikan dengan pembatasan natrium (Bensaud et al., 2025). Diet ini juga terbukti efektif dalam menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke.

Tabel 5.1: Prinsip Diet DASH pada Pasien Hipertensi

Komponen Diet	Rekomendasi	Contoh
Buah	4–5 porsi/hari	Pisang, apel, jeruk
Sayur	4–5 porsi/hari	Bayam, brokoli, wortel
Protein	2–3 porsi/hari	Ikan, ayam tanpa kulit
Produk Susu	Rendah lemak	Susu skim, yogurt
Natrium	≤ 5 gram garam/hari	Hindari makanan asin
Lemak	Rendah lemak jenuh	Minyak zaitun
Karbohidrat	Kompleks	Nasi merah, gandum

3. Strategi Edukasi Diet Berbasis Keluarga

Edukasi diet akan lebih efektif apabila dilakukan secara praktis dan kontekstual dalam kehidupan keluarga. Perawat perlu menggunakan pendekatan yang tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga aplikatif dan partisipatif.

a. Edukasi Membaca Label Makanan

Keluarga diajarkan untuk membaca kandungan natrium pada kemasan makanan. Banyak produk makanan mengandung natrium tersembunyi yang

tidak disadari, sehingga edukasi ini penting untuk meningkatkan kesadaran konsumsi garam (Kim et al., 2024).

b. Modifikasi Cara Memasak

- 1) Perawat dapat mengajarkan keluarga untuk: Mengurangi penggunaan garam dan penyedap
- 2) Mengganti dengan bumbu alami (bawang, jahe, kunyit) Menghindari metode menggoreng berulang

c. Penyusunan Menu Keluarga

Menu harus dibuat untuk seluruh keluarga, bukan hanya pasien. Hal ini bertujuan menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan perilaku.

Tabel 5.2: Contoh Menu Harian Diet Hipertensi (Keluarga)

Waktu	Menu
Pagi	Oatmeal + pisang + susu rendah lemak
Siang	Nasi merah + ikan panggang + sayur bayam
Sore	Buah potong (pepaya/apel)
Malam	Sup ayam tanpa kulit + sayur + tahu
Snack	Kacang tanpa garam

4. Peran Perawat dalam Edukasi Diet

Perawat memiliki peran penting dalam memastikan keberhasilan intervensi diet, antara lain:

- a. Sebagai edukator: memberikan informasi yang benar dan mudah dipahami
- b. Sebagai fasilitator: membantu keluarga menyusun pola makan sehat
- c. Sebagai motivator: mendorong perubahan perilaku
- d. Sebagai evaluator: menilai keberhasilan intervensi

Pendekatan edukasi yang bersifat interaktif, seperti demonstrasi memasak sehat atau diskusi keluarga, terbukti lebih efektif dibandingkan edukasi satu arah (Yuan et al., 2025).

5. Hambatan dan Solusi dalam Edukasi Diet

Beberapa hambatan yang sering ditemui:

- a. Kebiasaan makan tinggi garam
- b. Faktor budaya
- c. Keterbatasan ekonomi

d. Kurangnya pengetahuan

Solusi:

- a. Edukasi bertahap
- b. Pendekatan budaya
- c. Alternatif makanan murah dan sehat
- d. Pelibatan seluruh keluarga

6. Inovasi Edukasi Diet

Dalam perkembangan terbaru, edukasi diet dapat dikombinasikan dengan teknologi seperti:

- a. Aplikasi diet hipertensi
- b. Reminder konsumsi makanan sehat
- c. Monitoring pola makan berbasis digital

Pendekatan ini terbukti meningkatkan kepatuhan diet dan self-management pasien hipertensi (Yuting et al., 2023).

D. Intervensi Edukasi Aktivitas Fisik pada Hipertensi

Aktivitas fisik merupakan salah satu komponen utama dalam intervensi non-farmakologis untuk pengelolaan hipertensi yang telah terbukti efektif dalam menurunkan tekanan darah serta meningkatkan kesehatan kardiovaskular secara keseluruhan. Pedoman internasional terbaru menegaskan bahwa aktivitas fisik teratur memiliki efek signifikan terhadap penurunan tekanan darah sistolik dan diastolik, bahkan dapat memberikan efek yang sebanding dengan terapi farmakologis pada beberapa individu dengan hipertensi ringan hingga sedang (McEvoy et al., 2024). Aktivitas fisik bekerja melalui berbagai mekanisme, antara lain meningkatkan elastisitas pembuluh darah, menurunkan resistensi perifer, meningkatkan fungsi endotel, serta membantu pengendalian berat badan (Hejazi et al., 2025).

Meskipun manfaat aktivitas fisik telah diketahui secara luas, tingkat kepatuhan pasien hipertensi terhadap aktivitas fisik masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya motivasi, keterbatasan waktu, rasa lelah, ketakutan akan cedera, serta minimnya dukungan dari lingkungan keluarga (Monfared et al., 2024). Oleh karena itu, pendekatan edukasi aktivitas fisik dalam keperawatan keluarga harus dirancang secara sistematis, realistis, dan melibatkan keluarga sebagai sistem pendukung utama.

1. Prinsip Dasar Aktivitas Fisik pada Hipertensi

Dalam memberikan edukasi aktivitas fisik, perawat perlu menjelaskan prinsip dasar yang aman dan efektif bagi pasien hipertensi, yaitu:

- a. Frekuensi: minimal 3–5 kali per minggu

- b. Durasi: 30–45 menit per sesi
- c. Intensitas: sedang (tidak terlalu berat)
- d. Jenis aktivitas: aerobik seperti jalan kaki, bersepeda, atau senam
- e. Konsistensi: dilakukan secara rutin dan berkelanjutan

Aktivitas fisik intensitas sedang seperti berjalan cepat terbukti dapat menurunkan tekanan darah secara signifikan apabila dilakukan secara teratur (Hejazi et al., 2025). Selain itu, kombinasi aktivitas aerobik dan latihan kekuatan ringan juga memberikan manfaat tambahan dalam meningkatkan kebugaran dan kualitas hidup pasien hipertensi (Monfared et al., 2024).

2. Jenis Aktivitas Fisik yang Direkomendasikan

a. Aktivitas Aerobik

Aktivitas aerobik merupakan jenis latihan yang paling direkomendasikan karena memiliki efek langsung terhadap sistem kardiovaskular.

Contoh:

- 1) Jalan cepat
- 2) Bersepeda santai
- 3) Senam hipertensi
- 4) Jogging ringan

b. Latihan Kekuatan (Resistance Training)

Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan otot dan metabolisme tubuh.

Contoh:

- 1) Angkat beban ringan
- 2) Latihan menggunakan resistance band

c. Latihan Fleksibilitas dan Relaksasi

Latihan ini membantu mengurangi stres dan meningkatkan keseimbangan tubuh.

Contoh:

- 1) Yoga
- 2) Stretching
- 3) Tai chi

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kombinasi berbagai jenis latihan memberikan efek yang lebih optimal dibandingkan hanya satu jenis latihan saja (Monfared et al., 2024).

3. Peran Keluarga dalam Aktivitas Fisik

Dalam keperawatan keluarga, keberhasilan aktivitas fisik sangat dipengaruhi oleh keterlibatan keluarga. Keluarga dapat berperan sebagai:

- a. Motivator: mendorong pasien untuk tetap aktif
- b. Pendamping: menemani aktivitas fisik
- c. Peningkat: membantu menjaga konsistensi
- d. Pengontrol: memastikan aktivitas dilakukan dengan aman

Penelitian menunjukkan bahwa intervensi berbasis keluarga dapat meningkatkan kepatuhan aktivitas fisik dan memperbaiki kontrol tekanan darah secara signifikan (Kebebew et al., 2026). Aktivitas fisik yang dilakukan bersama keluarga juga meningkatkan aspek psikologis seperti rasa nyaman dan kebersamaan, yang berdampak positif terhadap keberlanjutan perilaku sehat.

4. Program Aktivitas Fisik Mingguan (Aplikatif)

Berikut contoh program aktivitas fisik yang dapat diterapkan dalam keluarga:

Tabel 5.3: Program Aktivitas Fisik 7 Hari untuk Pasien Hipertensi

Hari	Jenis Aktivitas	Durasi	Intensitas
Senin	Jalan cepat	30 menit	Sedang
Selasa	Senam hipertensi	30 menit	Sedang
Rabu	Jalan santai + stretching	30 menit	Ringan
Kamis	Bersepeda santai	30-45 menit	Sedang
Jumat	Istirahat aktif (aktivitas rumah ringan)	20-30 menit	Ringan
Sabtu	Jalan cepat + latihan ringan	30 menit	Sedang
Minggu	Rekreasi aktif (jalan keluarga)	30-45 menit	Sedang

5. Edukasi Step-by-Step Aktivitas Fisik

Perawat perlu memberikan edukasi secara bertahap agar pasien dan keluarga dapat memahami dan menerapkan aktivitas fisik dengan benar.

Langkah-langkah:

- a. Assessment awal
 - 1) Kondisi fisik pasien

- 2) Riwayat penyakit
- b. Kemampuan aktivitas
 - 1) Penentuan jenis aktivitas
 - 2) Disesuaikan dengan usia dan kondisi pasien
- c. Latihan bertahap
 - 1) Dimulai dari ringan: meningkat secara bertahap
- d. Monitoring respon tubuh
 - 1) Perhatikan tanda bahaya: pusing, nyeri dada, sesak
- e. Evaluasi berkala
 - 1) Perubahan tekanan darah
 - 2) Tingkat kebugaran

Pendekatan bertahap ini penting untuk mencegah cedera dan meningkatkan kepatuhan jangka panjang (Hejazi et al., 2025).

6. Hambatan dalam Aktivitas Fisik dan Solusinya

Hambatan:

- a. Malas / kurang motivasi
- b. Tidak ada waktu
- c. Takut kelelahan
- d. Lingkungan tidak mendukung

Solusi:

- a. Aktivitas bersama keluarga
- b. Jadwal rutin harian
- c. Mulai dari aktivitas ringan
- d. Edukasi manfaat jangka panjang

Pendekatan keluarga terbukti efektif dalam mengatasi hambatan tersebut karena adanya dukungan sosial yang kuat (Yuan et al., 2025).

7. Inovasi Aktivitas Fisik

Dalam era digital, aktivitas fisik dapat dikombinasikan dengan teknologi:

- a. Aplikasi penghitung langkah (step counter)
- b. Smartwatch monitoring aktivitas
- c. Video senam online
- d. Tele-coaching aktivitas fisik

Intervensi berbasis digital terbukti meningkatkan kepatuhan aktivitas fisik dan kontrol tekanan darah (Yuting et al., 2023).

E. Intervensi Edukasi Kepatuhan Obat pada Hipertensi

Kepatuhan terhadap pengobatan (*medication adherence*) merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pengelolaan hipertensi. Terapi antihipertensi dirancang untuk digunakan dalam jangka panjang, bahkan seumur hidup pada sebagian besar pasien. Namun demikian, berbagai studi menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pasien hipertensi terhadap pengobatan masih rendah, dengan sekitar 30–50% pasien tidak mengonsumsi obat sesuai anjuran (World Health Organization, 2021). Kondisi ini menjadi penyebab utama kegagalan kontrol tekanan darah serta meningkatnya risiko komplikasi seperti stroke, gagal jantung, dan penyakit ginjal kronis (McEvoy et al., 2024).

Kepatuhan obat tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga oleh faktor keluarga, lingkungan sosial, serta sistem pelayanan kesehatan. Dalam konteks keperawatan keluarga, kepatuhan obat merupakan hasil dari interaksi antara pasien dan keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Keluarga berperan dalam mengingatkan, mengawasi, serta memberikan dukungan emosional agar pasien tetap menjalankan terapi secara konsisten (Desta et al., 2022). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa intervensi berbasis keluarga secara signifikan meningkatkan kepatuhan obat dan kontrol tekanan darah dibandingkan intervensi individual (Kebebew et al., 2026).

1. Konsep Kepatuhan Obat dalam Hipertensi

Kepatuhan obat didefinisikan sebagai sejauh mana perilaku pasien dalam mengonsumsi obat sesuai dengan rekomendasi tenaga kesehatan, termasuk dosis, waktu, dan durasi pengobatan. Dalam hipertensi, kepatuhan memiliki karakteristik khusus karena pasien seringkali tidak merasakan gejala, sehingga merasa tidak perlu minum obat secara rutin (Hong et al., 2022).

Secara teoritis, kepatuhan obat dapat dijelaskan melalui Health Belief Model (HBM) dan Self-Efficacy Theory. HBM menjelaskan bahwa pasien akan patuh apabila mereka merasa berisiko terhadap penyakit dan memahami manfaat pengobatan, sedangkan self-efficacy berkaitan dengan keyakinan pasien dalam kemampuannya menjalankan terapi secara konsisten (Glanz et al., 2021). Dalam konteks keluarga, kedua konsep ini diperkuat melalui dukungan keluarga yang memberikan keyakinan dan motivasi kepada pasien.

2. Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Obat

Kepatuhan obat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks, antara lain:

a. Faktor Pasien

- 1) Kurangnya pengetahuan tentang hipertensi

- 2) Tidak merasakan gejala
- 3) Takut efek samping obat
- 4) Lupa minum obat
- b. Faktor Keluarga
 - 1) Kurangnya dukungan keluarga
 - 2) Tidak ada pengingat atau pengawasan
 - 3) Kurangnya keterlibatan keluarga dalam perawatan
- c. Faktor Terapi
 - 1) Regimen obat yang kompleks
 - 2) Efek samping
 - 3) Biaya obat
- d. Faktor Sistem Kesehatan
 - 1) Akses pelayanan terbatas
 - 2) Kurangnya edukasi dari tenaga kesehatan

Penelitian menunjukkan bahwa kombinasi faktor tersebut dapat menyebabkan ketidakpatuhan yang signifikan, sehingga diperlukan pendekatan multidimensional dalam intervensi (Stephen et al., 2022).

3. Peran Keluarga dalam Meningkatkan Kepatuhan Obat

Dalam keperawatan keluarga, keluarga memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kepatuhan obat, antara lain:

- a. Sebagai pengingat: mengingatkan waktu minum obat
- b. Sebagai pengawas: memastikan obat diminum sesuai dosis
- c. Sebagai motivator: memberikan dukungan emosional
- d. Sebagai fasilitator: membantu akses pelayanan kesehatan

Dukungan keluarga yang kuat terbukti meningkatkan kepatuhan terapi dan menurunkan angka ketidakpatuhan pada pasien hipertensi (Yuan et al., 2025). Selain itu, keterlibatan keluarga juga membantu mengurangi kecemasan pasien terkait efek samping obat.

4. Strategi Edukasi Kepatuhan Obat

Perawat perlu memberikan edukasi yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis dan mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Langkah 1: Edukasi Pemahaman Obat

- a. Jelaskan fungsi obat antihipertensi
- b. Tekankan bahwa obat harus diminum meskipun tidak ada gejala
- c. Jelaskan risiko jika tidak patuh

Langkah 2: Penyederhanaan Regimen

- a. Diskusikan dengan dokter jika regimen terlalu kompleks
- b. Gunakan obat kombinasi bila memungkinkan

Langkah 3: Penggunaan Alat Bantu

Strategi	Penjelasan
Pill box	Membantu mengorganisasi obat harian
Alarm HP	Pengingat waktu minum obat
Catatan harian	Monitoring kepatuhan
Aplikasi kesehatan	Tracking penggunaan obat
Kartu kontrol	Monitoring oleh tenaga kesehatan

Tabel 5.4: Strategi Praktis Meningkatkan Kepatuhan Obat

Langkah 4: Keterlibatan Keluarga

- a. Tentukan anggota keluarga sebagai pengingat
- b. Buat jadwal bersama
- c. Libatkan keluarga dalam kontrol rutin

Langkah 5: Monitoring dan Evaluasi

- a. Evaluasi kepatuhan secara berkala
- b. Identifikasi hambatan
- c. Berikan reinforcement positif

Pendekatan ini terbukti meningkatkan kepatuhan secara signifikan, terutama bila dilakukan secara berkelanjutan (Hoppe et al., 2023).

5. Hambatan Kepatuhan Obat dan Solusinya

Hambatan:

- a. Lupa minum obat
- b. Takut efek samping
- c. Bosan terapi jangka panjang
- d. Kurangnya dukungan keluarga

Solusi:

- a. Edukasi berulang
- b. Penggunaan teknologi
- c. Pendampingan keluarga

d. Konseling individu

Pendekatan berbasis keluarga dan teknologi (*mHealth*) terbukti efektif dalam mengatasi hambatan tersebut (Yuting et al., 2023).

6. Inovasi Kepatuhan Obat

Inovasi terbaru dalam meningkatkan kepatuhan obat meliputi:

a. mHealth (mobile health): aplikasi pengingat obat

b. Telemonitoring: kontrol jarak jauh

c. Digital pillbox: pengingat otomatis

d. Telecoaching: edukasi berkelanjutan.

Penelitian menunjukkan bahwa intervensi digital dapat meningkatkan kepatuhan hingga signifikan, terutama pada pasien dengan penyakit kronis (Yuting et al., 2023).

7. Peran Perawat sebagai Edukator dan Motivator

Perawat memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan obat melalui:

a. Edukasi berkelanjutan

b. Komunikasi terapeutik

c. Pendekatan empatik

d. Pemberdayaan keluarga

Perawat juga berperan dalam membangun hubungan terapeutik yang dapat meningkatkan kepercayaan pasien terhadap terapi yang diberikan (Kaakinen et al., 2021).

F. Intervensi Edukasi Pemantauan Tekanan Darah

Pemantauan tekanan darah merupakan komponen krusial dalam pengelolaan hipertensi karena memberikan informasi objektif mengenai kondisi hemodinamik pasien secara real-time. Dalam praktik modern, pemantauan tidak hanya dilakukan di fasilitas kesehatan, tetapi juga di rumah melalui home blood pressure monitoring (HBPM). Pendekatan ini direkomendasikan oleh berbagai pedoman internasional karena terbukti meningkatkan akurasi diagnosis, efektivitas terapi, serta keterlibatan pasien dan keluarga dalam pengelolaan hipertensi (Stergiou et al., 2021; McEvoy et al., 2024).

HBPM memungkinkan pasien dan keluarga untuk memantau tekanan darah secara rutin, mendeteksi variasi harian, serta mengevaluasi respons terhadap terapi. Studi terbaru menunjukkan bahwa pasien yang melakukan pemantauan tekanan darah di rumah memiliki kontrol tekanan darah yang lebih baik dibandingkan yang hanya mengandalkan pengukuran di fasilitas kesehatan (Liu et

al., 2025). Selain itu, keterlibatan keluarga dalam pemantauan tekanan darah terbukti meningkatkan kepatuhan pasien terhadap terapi dan perubahan gaya hidup (Yuan et al., 2025).

1. Tujuan Pemantauan Tekanan Darah

Edukasi pemantauan tekanan darah bertujuan untuk:

- a. Menilai efektivitas terapi antihipertensi
- b. Mendeteksi dini kenaikan tekanan darah
- c. Mengidentifikasi pola tekanan darah harian
- d. Meningkatkan kesadaran dan self-management pasien
- e. Mencegah komplikasi hipertensi

Pemantauan yang dilakukan secara rutin dan sistematis dapat membantu tenaga kesehatan dalam menentukan keputusan klinis yang lebih tepat (World Health Organization, 2021).

2. Jenis Pemantauan Tekanan Darah

- a. Pengukuran di Fasilitas Kesehatan: dilakukan oleh tenaga kesehatan menggunakan alat standar.
- b. Home Blood Pressure Monitoring (HBPM) Dilakukan secara mandiri oleh pasien/keluarga di rumah menggunakan tensimeter digital.
- c. Ambulatory Blood Pressure Monitoring (ABPM) Pengukuran otomatis selama 24 jam (biasanya di fasilitas khusus). HBPM menjadi pilihan utama dalam edukasi keluarga karena lebih praktis, ekonomis, dan meningkatkan keterlibatan pasien (Stergiou et al., 2021).

3. Teknik Pengukuran Tekanan Darah yang Benar

Perawat perlu memberikan edukasi yang tepat agar hasil pengukuran akurat.

Langkah-langkah:

- a. Istirahat minimal 5 menit sebelum pengukuran
- b. Posisi duduk, punggung bersandar
- c. Kaki tidak menyilang
- d. Lengan sejajar dengan jantung
- e. Tidak berbicara saat pengukuran
- f. Gunakan manset sesuai ukuran lengan
- g. Hindari kafein/rokok sebelum pengukuran

Kesalahan teknik pengukuran dapat menyebabkan hasil yang tidak akurat dan berdampak pada pengambilan keputusan terapi (Stergiou et al., 2021).

4. Jadwal Pemantauan Tekanan Darah

Edukasi kepada keluarga meliputi:

- a. 2 kali sehari (pagi & malam)
- b. Dilakukan selama 3–7 hari berturut-turut
- c. Dicatat secara sistematis

Pendekatan ini membantu mendapatkan gambaran tekanan darah yang lebih representatif (Liu et al., 2025).

5. Tabel Interpretasi Tekanan Darah

Tabel 5.5: Klasifikasi Tekanan Darah (Dewasa)

Kategori	Sistolik (mmHg)	Diastolik (mmHg)
Normal	<120	<80
Pre Hipertensi	120–129	<80
Hipertensi Stage 1	130–139	80–89
Hipertensi Stage 2	≥140	≥90
Krisis Hipertensi	≥180	≥120

(Sumber: McEvoy et al., 2024; WHO, 2021)

6. Pencatatan dan Monitoring Tekanan Darah

Tabel 5.6: Format Catatan Tekanan Darah Harian

Hari	Waktu	Sistolik	Diastolik	Keterangan
Senin	Pagi	85	85	Normal
Senin	Malam	88	88	Stabil
Selasa	Pa gi	90	90	Perlu dimonitor

Pencatatan ini membantu tenaga kesehatan dalam mengevaluasi terapi secara lebih akurat.

7. Peran Keluarga dalam Pemantauan Tekanan Darah

Keluarga memiliki peran penting dalam:

- a. Mengingat jadwal pengukuran

- b. Membantu penggunaan alat
- c. Mencatat hasil
- d. Menginterpretasikan hasil sederhana
- e. Mendorong kontrol ke fasilitas kesehatan

Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan keluarga dalam pemantauan tekanan darah meningkatkan kontrol tekanan darah dan kepatuhan pasien (Kebebew et al., 2026).

8. Hambatan dan Solusi Pemantauan Tekanan Darah

Hambatan:

- a. Tidak memiliki alat tensi
- b. Tidak tahu cara penggunaan
- c. Tidak rutin melakukan pengukuran

Solusi:

- a. Edukasi penggunaan alat
- b. Pelatihan langsung oleh perawat
- c. Penggunaan alat digital otomatis
- d. Pendampingan keluarga

9. Inovasi Pemantauan Tekanan Darah (NOVELTY 🔥)

Perkembangan teknologi memungkinkan pemantauan tekanan darah lebih efektif melalui:

- a. Smart tensimeter (Bluetooth)
- b. Aplikasi kesehatan
- c. Telemonitoring
- d. Sistem pelaporan digital

Intervensi berbasis digital terbukti meningkatkan self-management dan kontrol tekanan darah secara signifikan (Yuting et al., 2023).

10. Peran Perawat dalam Edukasi Pemantauan

Perawat berperan sebagai:

- a. Edukator: mengajarkan teknik pengukuran
- b. Trainer: melatih penggunaan alat
- c. Evaluator: menilai hasil monitoring
- d. Motivator: meningkatkan kepatuhan

Pendekatan edukasi yang berkelanjutan terbukti meningkatkan kemampuan keluarga dalam melakukan pemantauan mandiri (Kaakinen et al., 2021).

G. Implementasi Asuhan Keperawatan Keluarga pada Hipertensi

Implementasi asuhan keperawatan keluarga pada hipertensi merupakan proses sistematis yang melibatkan pengkajian, diagnosis keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi yang berfokus pada keluarga sebagai unit perawatan. Pendekatan ini menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan hipertensi tidak hanya ditentukan oleh intervensi klinis, tetapi juga oleh kemampuan keluarga dalam menjalankan fungsi perawatan secara mandiri dan berkelanjutan (Kaakinen et al., 2021).

Dalam praktik keperawatan modern, pendekatan family-centered care dan self-management support menjadi landasan utama dalam implementasi asuhan keperawatan keluarga. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas keluarga dalam mengenali masalah kesehatan, mengambil keputusan, serta melakukan tindakan perawatan yang tepat bagi anggota keluarga dengan hipertensi (Yuan et al., 2025). Penelitian menunjukkan bahwa intervensi keperawatan berbasis keluarga yang terstruktur dapat meningkatkan kontrol tekanan darah, kepatuhan terapi, serta kualitas hidup pasien hipertensi (Kebebew et al., 2026).

1. Tahap Pengkajian Keperawatan Keluarga

Pengkajian merupakan tahap awal yang sangat penting dalam menentukan arah intervensi. Pengkajian dilakukan secara komprehensif terhadap pasien dan keluarga.

a. Pengkajian Data Pasien

- 1) Riwayat hipertensi
- 2) Nilai tekanan darah
- 3) Kepatuhan obat
- 4) Pola makan
- 5) Aktivitas fisik

b. Pengkajian Keluarga

- 1) Pengetahuan keluarga tentang hipertensi
- 2) Dukungan keluarga
- 3) Pola komunikasi
- 4) Kebiasaan makan keluarga
- 5) Lingkungan rumah

c. Pengkajian Fungsi Keluarga

Mengacu pada tugas kesehatan keluarga:

- 1) Mengenal masalah
- 2) Mengambil keputusan

- 3) Merawat anggota keluarga
- 4) Memodifikasi lingkungan
- 5) Memanfaatkan fasilitas kesehatan (Friedman et al., 2021)

Pengkajian yang komprehensif memungkinkan perawat untuk mengidentifikasi masalah utama dan menentukan intervensi yang tepat.

2. Diagnosis Keperawatan

Berdasarkan hasil pengkajian, diagnosis keperawatan yang sering muncul pada keluarga dengan hipertensi antara lain:

- a. Ketidakefektifan manajemen kesehatan keluarga
- b. Ketidakpatuhan terhadap regimen terapi
- c. Defisit pengetahuan tentang hipertensi
- d. Risiko komplikasi hipertensi
- e. Pola hidup tidak sehat

Diagnosis ini menjadi dasar dalam penyusunan rencana intervensi keperawatan (Herdman & Kamitsuru, 2021).

3. Perencanaan Keperawatan

Perencanaan dilakukan dengan menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dan realistis.

Contoh tujuan:

- a. Keluarga mampu menjelaskan diet hipertensi
- b. Pasien melakukan aktivitas fisik minimal 3x/minggu
- c. Pasien patuh minum obat
- d. Keluarga mampu mengukur tekanan darah secara mandiri

Perencanaan harus melibatkan keluarga agar meningkatkan komitmen dan keberhasilan intervensi (Stephen et al., 2022).

4. Implementasi Keperawatan (INTERVENSI UTAMA)

Implementasi merupakan tahap pelaksanaan intervensi yang telah direncanakan.

- a. Edukasi Diet
 - 1) Memberikan penyuluhan diet DASH
 - 2) Demonstrasi pengolahan makanan sehat
 - 3) Penyusunan menu keluarga
- b. Edukasi Aktivitas Fisik
 - 1) Latihan jalan kaki teratur
 - 2) Senam hipertensi

- 3) Aktivitas fisik bersama keluarga
- c. Edukasi Kepatuhan Obat
 - 1) Penggunaan pill box
 - 2) Pengingat minum obat
 - 3) Edukasi efek samping
- d. Edukasi Pemantauan Tekanan Darah
 - 1) Pelatihan penggunaan tensimeter
 - 2) Pencatatan tekanan darah
 - 3) Evaluasi hasil monitoring

Implementasi harus dilakukan secara berkelanjutan dan disesuaikan dengan kondisi keluarga (McEvoy et al., 2024).

5. Evaluasi Keperawatan

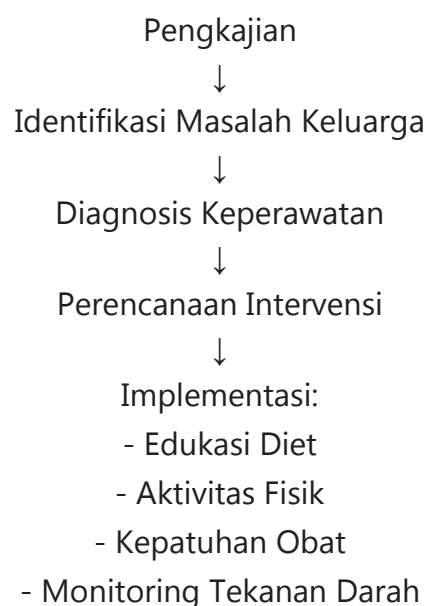
Evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan intervensi.

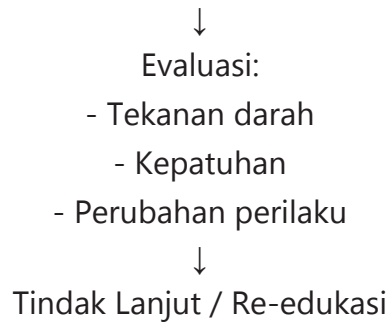
Indikator keberhasilan:

- a. Tekanan darah menurun/stabil
- b. Kepatuhan obat meningkat
- c. Perubahan pola makan
- d. Aktivitas fisik meningkat
- e. Keluarga mandiri dalam perawatan

Evaluasi harus dilakukan secara berkala untuk memastikan keberlanjutan hasil (Yuan et al., 2025).

FLOWCHART IMPLEMENTASI ASUHAN KEPERAWATAN KELUARGA





6. Pendekatan Strategis dalam Implementasi

Agar implementasi efektif, perawat perlu menggunakan pendekatan:

a. Edukasi Partisipatif

Melibatkan keluarga secara aktif dalam proses pembelajaran.

b. Pendekatan Individualisasi

Menyesuaikan intervensi dengan kondisi keluarga.

c. Penguatan Positif

Memberikan motivasi dan apresiasi.

d. Follow-up Berkelanjutan Melakukan monitoring secara berkala.

Pendekatan ini terbukti meningkatkan keberhasilan intervensi keperawatan keluarga (Kebebew et al., 2026).

7. Integrasi Digital Health

Implementasi modern dapat dikombinasikan dengan teknologi:

a. Aplikasi monitoring tekanan darah

b. Reminder obat digital

c. Telehealth

d. Edukasi berbasis video

Pendekatan ini terbukti meningkatkan efektivitas intervensi keperawatan keluarga (Yuting et al., 2023).

H. Simpulan

Hipertensi merupakan masalah kesehatan kronis yang memerlukan pengelolaan jangka panjang dan berkelanjutan, tidak hanya melalui terapi farmakologis, tetapi juga melalui perubahan perilaku kesehatan yang komprehensif. Dalam konteks ini, keluarga memiliki peran yang sangat strategis sebagai sistem pendukung utama dalam menjaga stabilitas kondisi pasien hipertensi. Pendekatan keperawatan keluarga menempatkan keluarga sebagai mitra aktif dalam proses perawatan, sehingga keberhasilan pengelolaan hipertensi

sangat ditentukan oleh kemampuan keluarga dalam menjalankan fungsi perawatan secara mandiri dan konsisten (Kaakinen et al., 2021).

Intervensi edukasi yang meliputi diet, aktivitas fisik, kepatuhan obat, dan pemantauan tekanan darah terbukti menjadi pilar utama dalam pengendalian hipertensi. Edukasi diet yang menekankan pembatasan natrium dan penerapan pola makan sehat seperti DASH dapat membantu menurunkan tekanan darah secara signifikan (Bensaaud et al., 2025). Aktivitas fisik teratur berkontribusi dalam meningkatkan fungsi kardiovaskular dan mengontrol berat badan, sementara kepatuhan terhadap terapi obat menjadi kunci dalam mencegah komplikasi jangka panjang (McEvoy et al., 2024). Selain itu, pemantauan tekanan darah secara mandiri memberikan peluang bagi pasien dan keluarga untuk melakukan deteksi dini serta evaluasi terhadap efektivitas terapi (Liu et al., 2025).

Keberhasilan implementasi intervensi tersebut tidak dapat dilepaskan dari peran keluarga dalam memberikan dukungan emosional, instrumental, dan informasional kepada pasien. Keterlibatan aktif keluarga dalam perawatan sehari-hari terbukti meningkatkan kepatuhan pasien, memperbaiki self-management, serta meningkatkan kontrol tekanan darah secara signifikan (Kebebew et al., 2026). Oleh karena itu, pendekatan berbasis keluarga (family-centered care) menjadi strategi yang sangat relevan dan efektif dalam pengelolaan hipertensi di era modern.

Perawat memiliki peran penting sebagai edukator, fasilitator, motivator, dan evaluator dalam proses asuhan keperawatan keluarga. Perawat tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga memberdayakan keluarga agar mampu mengenali masalah kesehatan, mengambil keputusan yang tepat, serta melakukan tindakan perawatan secara mandiri. Pendekatan edukatif yang bersifat partisipatif, individual, dan berkelanjutan menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas intervensi keperawatan (Stephen et al., 2022).

Seiring dengan perkembangan teknologi, integrasi digital health dalam asuhan keperawatan keluarga memberikan peluang baru dalam meningkatkan kualitas pengelolaan hipertensi. Penggunaan aplikasi kesehatan, pemantauan tekanan darah berbasis digital, serta sistem pengingat obat terbukti dapat meningkatkan kepatuhan dan efektivitas terapi (Yuting et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi antara pendekatan tradisional keperawatan keluarga dan inovasi teknologi dapat menjadi solusi yang optimal dalam menghadapi tantangan pengelolaan hipertensi di masa depan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa asuhan keperawatan keluarga pada pasien hipertensi harus dilakukan secara komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan, dengan melibatkan keluarga sebagai aktor utama dalam proses

perawatan. Intervensi edukasi yang tepat, didukung oleh pendekatan berbasis keluarga dan teknologi, memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas hidup pasien, mencegah komplikasi, serta menurunkan angka morbiditas dan mortalitas akibat hipertensi. Oleh karena itu, penguatan peran perawat dan keluarga dalam pengelolaan hipertensi menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat diabaikan dalam sistem pelayanan kesehatan modern.

I. Referensi

- Ardianti, I. (2019). Pemberian Edukasi Tentang Kesehatan Reproduksi Pada Wanita Usia Subur Di Desa Sumberagung Kecamatan Bensaaud, A., Badaoui, G., Boukhari, S., & El Midaoui, A. (2025). Dietary approaches to stop hypertension (DASH) for the management of blood pressure and cardiovascular health. *Nutrients*, 17(4), 1023.
- Cepeda, M., Gualtero, S., & Hidalgo, J. (2023). Status of ambulatory blood pressure monitoring and home blood pressure monitoring in hypertension management. *Hypertension Research*, 46(2), 145–153.
- Desta, R., Wondmieneh, A., & Alemu, A. (2022). Medication adherence and associated factors among patients with hypertension: A systematic review. *Patient Preference and Adherence*, 16, 215–226.
- Friedman, M. M., Bowden, V. R., & Jones, E. G. (2021). *Family nursing: Research, theory, and practice* (7th ed.). Pearson.
- Glanz, K., Rimer, B. K., & Viswanath, K. (2021). *Health behavior: Theory, research, and practice* (6th ed.). Jossey-Bass.
- Hejazi, K., Mohammadi, M., & Rahimi, A. (2025). Effects of different exercise training protocols on blood pressure: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Hypertension*, 43(1), 12–25.
- Herdman, T. H., & Kamitsuru, S. (2021). *NANDA International nursing diagnoses: Definitions and classification 2021–2023*. Thieme.
- Hong, J., Kang, H., & Lee, Y. (2022). Interventions to improve adherence to antihypertensive medications: A systematic review. *Journal of Clinical Hypertension*, 24(5), 567–576.
- Hoppe, K. K., Williams, M. A., & Thomas, N. (2023). Effect of a telephone health coaching intervention on hypertension control. *Journal of Human Hypertension*, 37(2), 123–131.
- Kaakinen, J. R., Coehlo, D. P., Steele, R., & Robinson, M. (2021). *Family health care nursing: Theory, practice, and research* (6th ed.). F.A. Davis Company.
- Kebebew, G. M., Ayalew, M. B., & Zeleke, B. M. (2026). Family-based interventions on self-management behaviours and blood pressure control in individuals

- with hypertension: A systematic review and meta-analysis. *BMC Public Health*, 26, 112.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Profil kesehatan Indonesia 2022*. Kemenkes RI.
- Kim, S., Lee, H., & Park, J. (2024). Sodium-restricted DASH diet and blood pressure control: A systematic review. *Nutrients*, 16(7), 1582.
- Liu, J., Chen, X., & Wang, Y. (2025). Home blood pressure monitoring and its effectiveness in hypertension management. *American Journal of Hypertension*, 38(4), 193–202.
- McEvoy, J. W., Daya, N., Rahman, F., & Hoogeveen, R. (2024). 2024 ESC guidelines for the management of elevated blood pressure and hypertension. *European Heart Journal*, 45(12), 1024–1110.
- Monfared, V., Kazemi, T., & Rezaei, S. (2024). Physical activity interventions and blood pressure control: A systematic review and meta-analysis. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 21(1), 45.
- Rech, J. S., Oliveira, L., & Santos, R. (2025). User engagement with home blood pressure monitoring in hypertensive patients. *Journal of Clinical Hypertension*, 27(3), 211–220.
- Stephen, C., Smith, L., & Brown, K. (2022). Nurse-led interventions to manage hypertension in primary care: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Advanced Nursing*, 78(5), 1281–1293.
- Stergiou, G. S., Palatini, P., & Asmar, R. (2021). 2021 European Society of Hypertension practice guidelines for office and out-of-office blood pressure measurement. *Journal of Hypertension*, 39(7), 1293–1302.
- Williams, B., Mancia, G., Spiering, W., & Agabiti Rosei, E. (2023). 2023 ESH guidelines for the management of arterial hypertension. *Journal of Hypertension*, 41(6), 873–984.
- World Health Organization. (2021). *Guideline for the pharmacological treatment of hypertension in adults*. WHO Press.
- World Health Organization. (2023). *Hypertension fact sheet*. World Health Organization.
- Yuan, Y. M., Liu, X., & Zhang, L. (2025). Effect of family-based interventions on hypertension self-management: A meta-analysis. *Research in Community and Public Health Nursing*, 36(2), 89–101.
- Yuting, Z., Chen, L., & Wang, H. (2023). Effectiveness of mHealth interventions on hypertension self-management: A systematic review. *Journal of Medical Internet Research*, 25, e45678.
- Zhou, Y., Li, X., & Wu, J. (2024). Lifestyle modification and hypertension control:

J. Glosarium

Aktivitas fisik

Setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang memerlukan pengeluaran energi, seperti berjalan, bersepeda, dan senam, yang bertujuan meningkatkan kebugaran dan kesehatan kardiovaskular.

Ambulatory Blood Pressure Monitoring (ABPM)

Metode pengukuran tekanan darah secara otomatis selama 24 jam menggunakan alat khusus yang dikenakan pasien untuk memantau variasi tekanan darah sepanjang hari.

Diet DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension)

Pola makan yang dirancang untuk menurunkan tekanan darah dengan menekankan konsumsi buah, sayur, produk rendah lemak, serta pembatasan natrium dan lemak jenuh.

Diastolik

Tekanan darah yang terjadi saat jantung dalam fase relaksasi (di antara dua denyutan), yang menunjukkan tekanan minimum dalam pembuluh darah.

Digital health (Kesehatan digital)

Pemanfaatan teknologi digital seperti aplikasi kesehatan, telemedicine, dan perangkat wearable untuk mendukung pelayanan kesehatan dan pengelolaan penyakit.

Family-centered care

Pendekatan pelayanan kesehatan yang menempatkan keluarga sebagai bagian penting dalam perawatan pasien, dengan melibatkan keluarga dalam pengambilan keputusan dan intervensi.

Health Belief Model (HBM)

Model teori perilaku kesehatan yang menjelaskan bahwa tindakan seseorang dipengaruhi oleh persepsi terhadap risiko penyakit, manfaat tindakan, dan hambatan yang dirasakan.

Hipertensi

Kondisi medis kronis yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah secara persisten $\geq 140/90$ mmHg, yang dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular.

Home Blood Pressure Monitoring (HBPM)

Pengukuran tekanan darah secara mandiri di rumah menggunakan alat tensimeter, yang bertujuan untuk memantau kondisi tekanan darah secara rutin.

Kepatuhan obat (Medication adherence)

Tingkat kesesuaian perilaku pasien dalam mengonsumsi obat sesuai dengan dosis, waktu, dan anjuran tenaga kesehatan.

Krisis hipertensi

Kondisi peningkatan tekanan darah secara drastis ($\geq 180/120$ mmHg) yang memerlukan penanganan segera untuk mencegah komplikasi serius.

mHealth (Mobile Health)

Penggunaan perangkat mobile seperti smartphone dan aplikasi kesehatan untuk mendukung pemantauan dan manajemen kesehatan pasien.

Natrium

Mineral yang terdapat dalam garam yang berfungsi mengatur keseimbangan cairan tubuh, namun konsumsi berlebihan dapat meningkatkan tekanan darah.

Non-farmakologis

Pendekatan pengobatan tanpa menggunakan obat-obatan, seperti perubahan gaya hidup, diet, aktivitas fisik, dan manajemen stres.

Pill box

Kotak obat yang digunakan untuk membantu pasien mengatur jadwal konsumsi obat harian agar lebih teratur.

Prehipertensi

Kondisi tekanan darah yang berada di atas normal namun belum mencapai kategori hipertensi, yaitu sekitar $120\text{--}129/<80$ mmHg.

Self-management

Kemampuan individu dalam mengelola kondisi kesehatannya secara mandiri, termasuk pengaturan diet, aktivitas, pengobatan, dan monitoring.

Self-efficacy

Keyakinan seseorang terhadap kemampuannya dalam melakukan tindakan tertentu untuk mencapai tujuan kesehatan.

Sistolik

Tekanan darah yang terjadi saat jantung berkontraksi dan memompa darah ke seluruh tubuh.

Stroke

Gangguan aliran darah ke otak yang dapat menyebabkan kerusakan jaringan otak dan gangguan fungsi tubuh.

Telemonitoring

Pemantauan kondisi kesehatan pasien secara jarak jauh menggunakan teknologi komunikasi dan perangkat digital.

Tekanan darah

Gaya yang diberikan oleh darah terhadap dinding pembuluh darah, yang diukur dalam satuan mmHg dan terdiri dari tekanan sistolik dan diastolik.

Tensimeter digital

Alat elektronik yang digunakan untuk mengukur tekanan darah secara otomatis dan mudah digunakan oleh pasien di rumah.

Ultra-processed food

Makanan olahan yang telah mengalami proses industri tinggi dan umumnya mengandung natrium, gula, dan lemak dalam jumlah tinggi.

CHAPTER 6

PEMBERDAYAAN KELUARGA DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PENCEGAHAN KOMPLIKASI

Antonius Yogi Pratama, S.Kep., Ns., MSN.

A. Pendahuluan

Hipertensi merupakan salah satu penyakit tidak menular (PTM) yang paling banyak diderita masyarakat Indonesia dan menjadi penyebab utama morbiditas, mortalitas, serta disabilitas. Secara global, diperkirakan 1,4 miliar orang dewasa berusia 30–79 tahun di seluruh dunia menderita hipertensi pada tahun 2024, merepresentasikan 33% dari populasi kelompok usia tersebut, dan dua pertiga di antaranya tinggal di negara berpenghasilan rendah hingga menengah (WHO, 2025). Sekitar 600 juta orang dengan hipertensi (44%) bahkan tidak menyadari bahwa mereka mengidap kondisi ini, dan hanya 23% yang berhasil mengendalikannya (WHO, 2025). Di tingkat nasional, Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 mencatat prevalensi hipertensi pada penduduk usia di atas 18 tahun sebesar 30,8%, mengalami penurunan dibandingkan Risesdas 2018 yang mencapai 34,1% (Kementerian Kesehatan RI, 2023). Meski demikian, penurunan angka prevalensi ini belum diikuti oleh peningkatan kepatuhan pengobatan yang memadai. Pada kelompok usia produktif (18–59 tahun), hanya 2,5% yang mengonsumsi obat secara teratur dan hanya 2,3% yang melakukan kunjungan ulang ke fasilitas pelayanan kesehatan, dari 5,9% yang telah terdiagnosis hipertensi. Pada kelompok usia lanjut (≥ 60 tahun), dari 22,9% yang terdiagnosis, hanya 11,9% yang mengonsumsi obat teratur dan 11,0% yang melakukan kunjungan ulang (Kementerian Kesehatan RI, 2023). Berdasarkan SKI 2023 dan studi kohor PTM 2011–2021, hipertensi merupakan faktor risiko tertinggi penyebab kematian keempat di Indonesia dengan persentase 10,2%, sekaligus menjadi penyebab utama disabilitas pada 22,2% penduduk berusia 15 tahun ke atas (Kementerian Kesehatan RI, 2023). Kondisi ini menempatkan hipertensi sebagai tantangan kesehatan yang mendesak untuk ditangani secara komprehensif dan berbasis keluarga.

Keluarga memegang peranan sentral dalam pengelolaan hipertensi. Dalam perspektif keperawatan keluarga, keluarga dipandang bukan sekadar latar belakang individu, melainkan sebagai unit pelayanan kesehatan itu sendiri.

Rendahnya angka kepatuhan pengobatan dan kunjungan ulang yang ditunjukkan data SKI 2023 mencerminkan adanya kesenjangan serius dalam sistem dukungan keluarga dan pemberdayaan pasien di komunitas, yang tidak dapat diatasi hanya melalui pendekatan klinis individual. Oleh karena itu, pemberdayaan keluarga menjadi strategi kunci dalam menekan angka komplikasi hipertensi seperti stroke, penyakit jantung koroner, gagal ginjal, dan retinopati hipertensif. WHO memproyeksikan bahwa apabila negara-negara dapat meningkatkan cakupan penatalaksanaan hipertensi secara efektif, sebanyak 76 juta kematian, 120 juta kejadian stroke, 79 juta serangan jantung, dan 17 juta kasus gagal jantung dapat dicegah antara tahun 2023 hingga 2050 (WHO, 2023). Pendekatan berbasis keluarga ini menuntut peran aktif perawat sebagai fasilitator, educator, advokat, dan konsultan bagi keluarga.

Bab ini membahas secara mendalam tentang konsep pemberdayaan keluarga dalam konteks pengambilan keputusan kesehatan dan pencegahan komplikasi hipertensi. Pembahasan meliputi landasan teori, peran perawat keluarga, proses keperawatan keluarga yang terstruktur, serta strategi intervensi berbasis bukti yang dapat diterapkan di tatanan pelayanan kesehatan primer maupun komunitas.

B. Konsep Pemberdayaan Keluarga

Pemberdayaan keluarga (family empowerment) dalam konteks keperawatan merupakan konsep multidimensional yang merujuk pada proses memungkinkan keluarga untuk memperoleh kendali lebih besar atas keputusan dan tindakan yang memengaruhi kesehatan anggotanya. World Health Organization (WHO) mendefinisikan pemberdayaan sebagai suatu proses di mana individu dan keluarga memperoleh kendali yang lebih besar atas keputusan dan tindakan yang memengaruhi kesehatan mereka. Definisi ini diperkuat oleh StatPearls-NIH yang menegaskan bahwa pemberdayaan merupakan konsep multidimensional yang memungkinkan pasien dan keluarga mengambil peran aktif, terinformasi, dan kolaboratif dalam perawatan mereka; proses ini mencakup tidak hanya penerimaan informasi dan dukungan dari tenaga kesehatan, tetapi juga pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan kepercayaan diri untuk membuat pilihan yang tepat, mengungkapkan preferensi, dan mengelola kondisi kesehatan secara mandiri—menandai pergeseran dari model hierarkis paternalistik menuju kemitraan yang setara.

Dalam konteks penyakit kronis seperti hipertensi, Alhani et al. mengembangkan Family-Centered Empowerment Model (FCEM) sebagai model yang secara simultan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan keyakinan pasien beserta anggota keluarganya, dengan tujuan utama

memberdayakan unit pasien-keluarga untuk meningkatkan kualitas hidup melalui empat tahap: penentuan persepsi ancaman, peningkatan efikasi diri, peningkatan harga diri, serta evaluasi proses dan hasil (Alhani et al., 2022). WHO secara lebih spesifik mengidentifikasi empat komponen fundamental dalam proses pemberdayaan, yaitu: partisipasi aktif pasien/keluarga, penguasaan pengetahuan yang cukup, pengembangan keterampilan praktis, dan penciptaan lingkungan yang mendukung (facilitating environment)

C. Teori-Teori yang Mendasari Pemberdayaan Keluarga

Beberapa teori keperawatan menjadi fondasi dalam pemberdayaan keluarga untuk pengelolaan hipertensi, antara lain:

Tabel 6.1: Teori-Teori yang Mendasari Pemberdayaan Keluarga

Teori/Model	Tokoh	Relevansi dengan Hipertensi
Family Systems Theory	Bowen (1978)	Keluarga sebagai sistem yang saling memengaruhi; perubahan satu anggota berdampak pada seluruh sistem keluarga
Health Belief Model	Rosenstock (1966)	Persepsi keluarga terhadap kerentanan dan keparahan hipertensi memengaruhi perilaku pencegahan
Friedman Family Model	Friedman (1998)	Fungsi keluarga sebagai struktur sosial yang menentukan respons terhadap penyakit kronis
Self-Efficacy Theory	Bandura (1977&2004)	Keyakinan keluarga terhadap kemampuan mengelola hipertensi mendorong tindakan preventif. Selain itu menekankan peran self-efficacy, pembelajaran observasional, dan penguatan dalam perubahan perilaku kesehatan

D. Lima Tugas Keluarga

Friedman, Bowden & Jones (2010) mengidentifikasi lima tugas kesehatan keluarga yang menjadi kerangka kerja fundamental dalam asuhan keperawatan keluarga dengan hipertensi, sebagaimana disajikan pada Tabel 6.2 berikut.

Tabel 6.2: Lima Tugas Keluarga

Tugas Kesehatan Keluarga	Implementasi pada Kasus Hipertensi
1. Mengenal masalah kesehatan	Keluarga mampu mendefinisikan hipertensi, menyebutkan nilai normal tekanan darah, mengenali faktor risiko, dan memahami konsekuensi jika tidak dikelola dengan baik.
2. Mengambil keputusan tindakan	Keluarga memutuskan kapan harus membawa penderita ke fasilitas kesehatan, memilih terapi yang tepat, dan menetapkan prioritas perubahan gaya hidup secara bersama.
3. Merawat anggota yang sakit	Keluarga melaksanakan perawatan harian: penyiapan diet rendah garam (DASH), pendampingan minum obat, pemantauan tekanan darah mandiri, dan pengelolaan stres penderita.
4. Memodifikasi lingkungan	Keluarga menciptakan lingkungan kondusif: mengurangi paparan stres, menjauhkan makanan tinggi natrium, menyediakan ruang untuk aktivitas fisik, dan menerapkan rumah bebas asap rokok.
5. Memanfaatkan fasilitas kesehatan	Keluarga rutin mengantarkan penderita kontrol, mengikuti program Prolanis di Puskesmas, memanfaatkan layanan telemedicine, dan mengakses informasi kesehatan terpercaya.

E. Peran Keluarga Dalam Manajemen Hipertensi

1. Dukungan Sosial Keluarga

Dukungan sosial keluarga merupakan salah satu faktor protektif terpenting dalam manajemen hipertensi. House (1981) dalam Glanz et al. (2015) mengklasifikasikan dukungan sosial ke dalam empat dimensi: (1) dukungan emosional berupa rasa kasih sayang, empati, dan kepedulian; (2) dukungan instrumental berupa bantuan nyata dalam bentuk materi, tenaga, dan waktu; (3) dukungan informasional berupa pemberian informasi, saran, dan panduan; dan (4) dukungan penilaian berupa umpan balik dan penghargaan terhadap upaya yang dilakukan.

Meta-analisis yang dilakukan oleh Uchino (2006) yang masih relevan hingga kini menunjukkan bahwa dukungan sosial berpengaruh signifikan terhadap fungsi kardiovaskular, termasuk regulasi tekanan darah. Studi terbaru

oleh Kulkarni et al. (2022) menemukan bahwa pasien hipertensi yang mendapat dukungan keluarga tinggi memiliki kepatuhan pengobatan 2,3 kali lebih tinggi dibandingkan pasien dengan dukungan keluarga rendah. Dukungan keluarga juga berhubungan dengan penurunan kadar kortisol dan aktivitas sistem saraf simpatis, yang secara langsung berkontribusi pada penurunan tekanan darah.

2. Peran Keluarga dalam Kepatuhan Pengobatan

Kepatuhan terhadap terapi antihipertensi merupakan tantangan utama dalam manajemen hipertensi jangka panjang. WHO (2023) melaporkan bahwa kurang dari 50% pasien hipertensi mematuhi rejimen pengobatan mereka secara konsisten. Faktor-faktor yang berkontribusi pada ketidakpatuhan meliputi efek samping obat, biaya pengobatan, keyakinan terhadap terapi, dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya pengobatan berkelanjutan (Burnier & Egan, 2019).

Keluarga memainkan peran krusial dalam meningkatkan kepatuhan pengobatan melalui berbagai mekanisme: mengingatkan jadwal minum obat, memastikan ketersediaan obat, menemani pasien saat kontrol ke fasilitas kesehatan, serta memberikan dukungan emosional ketika pasien mengalami frustrasi dengan terapi jangka panjang. Penelitian oleh Hu et al. (2021) di China menunjukkan bahwa intervensi yang melibatkan anggota keluarga sebagai "medication manager" secara signifikan meningkatkan kepatuhan pengobatan dari 51,3% menjadi 78,9% pada kelompok intervensi.

3. Peran Keluarga dalam Modifikasi Gaya Hidup

Modifikasi gaya hidup merupakan komponen esensial dalam penatalaksanaan hipertensi, baik sebagai monoterapi maupun sebagai adjuvan terapi farmakologis. Pendekatan DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) yang meliputi diet tinggi buah, sayur, dan produk susu rendah lemak dengan pembatasan natrium, terbukti dapat menurunkan tekanan darah sistolik rata-rata 8–14 mmHg (Saneei et al., 2014). Implementasi diet DASH sangat dipengaruhi oleh pola makan keluarga, sehingga keterlibatan seluruh anggota keluarga dalam adopsi pola makan sehat menjadi sangat penting.

Aktivitas fisik secara teratur merupakan komponen lain dari modifikasi gaya hidup yang krusial. Pedoman ACC/AHA merekomendasikan aktivitas fisik aerobik intensitas sedang setidaknya 150 menit per minggu untuk menurunkan tekanan darah (Whelton et al., 2018). Dukungan keluarga dalam bentuk berolahraga bersama, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk aktivitas fisik, serta memberikan motivasi konsisten terbukti meningkatkan tingkat partisipasi pasien hipertensi dalam program latihan fisik (Umpierre et al., 2015).

F. Pengambilan Keputusan Keluarga

1. Konsep dan Model Pengambilan Keputusan Bersama

Shared Decision Making (SDM) atau pengambilan keputusan bersama merupakan pendekatan di mana pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan bekerja sama dalam membuat keputusan medis yang mempertimbangkan bukti terbaik yang tersedia sekaligus nilai-nilai dan preferensi pasien serta keluarga (Barry & Edgman-Levitan, 2012). Model SDM telah berkembang dari paradigma lama yang bersifat paternalistik menuju model kemitraan yang lebih setara antara penyedia layanan kesehatan dan penerima layanan.

Dalam konteks hipertensi, keputusan yang perlu diambil keluarga mencakup berbagai aspek: pilihan antara monoterapi dan kombinasi terapi, preferensi jenis obat, target tekanan darah yang akan dicapai, modifikasi gaya hidup yang akan diimplementasikan, dan kapan harus mencari pertolongan medis darurat. Model pengambilan keputusan keluarga yang efektif memerlukan keseimbangan antara pengetahuan medis yang diberikan tenaga kesehatan dengan konteks kehidupan nyata keluarga, termasuk kemampuan finansial, akses terhadap layanan kesehatan, dan nilai-nilai budaya yang dianut.

2. Hambatan dalam Pengambilan Keputusan Keluarga

Berbagai hambatan dapat menghalangi keluarga dalam mengambil keputusan kesehatan yang tepat terkait hipertensi. Hambatan kognitif meliputi kurangnya pengetahuan tentang hipertensi, kesalahpahaman tentang penyakit, dan kesulitan memahami informasi medis. Hambatan struktural mencakup keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan, biaya yang tidak terjangkau, dan keterbatasan waktu. Hambatan budaya meliputi kepercayaan tentang penyebab dan pengobatan hipertensi yang berbasis tradisi, serta peran gender dalam pengambilan keputusan keluarga (Khatib et al., 2014).

Di Indonesia, faktor budaya sangat memengaruhi pengambilan keputusan kesehatan. Nilai-nilai kolektivisme yang kuat dalam masyarakat Indonesia menempatkan keputusan kesehatan sebagai urusan keluarga besar, bukan individu semata. Penelitian oleh Suhadi et al. (2019) di Jawa Tengah menunjukkan bahwa keputusan untuk mengikuti pengobatan hipertensi seringkali dipengaruhi oleh pandangan kepala keluarga dan anggota keluarga yang lebih tua. Pemahaman terhadap dinamika budaya ini penting untuk merancang intervensi pemberdayaan yang kontekstual dan efektif.

3. Health Literacy Keluarga

Health literacy atau literasi kesehatan keluarga merupakan prediktor penting dalam kualitas pengambilan keputusan kesehatan. Nutbeam (2008) mengklasifikasikan health literacy ke dalam tiga tingkatan: functional literacy

(kemampuan membaca dan menulis informasi kesehatan dasar), communicative literacy (kemampuan mengekstrak dan mengaplikasikan informasi dalam situasi yang berubah), dan critical literacy (kemampuan menganalisis dan menggunakan informasi secara kritis untuk kendali lebih besar atas situasi kehidupan). Tingkat health literacy yang lebih tinggi berhubungan dengan pengambilan keputusan kesehatan yang lebih baik dan hasil kesehatan yang lebih optimal.

Studi sistematis oleh Berkman et al. (2011) dan konfirmasi lebih lanjut oleh Lam & Marsden (2022) menunjukkan bahwa health literacy rendah berhubungan dengan kepatuhan pengobatan yang buruk, kualitas hidup yang lebih rendah, dan peningkatan risiko komplikasi pada penyakit kronis termasuk hipertensi. Program peningkatan health literacy yang dirancang untuk keluarga, bukan hanya pasien, terbukti lebih efektif dalam meningkatkan kualitas manajemen hipertensi jangka panjang.

G. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan

1. Faktor Internal Keluarga

- a. Tingkat pengetahuan tentang hipertensi, faktor risiko, dan komplikasinya
- b. Kepercayaan dan mitos budaya tentang penyakit tekanan darah tinggi
- c. Kemampuan ekonomi dan akses terhadap layanan kesehatan setempat
- d. Pola koping keluarga dan pengalaman menghadapi penyakit kronis sebelumnya
- e. Pola komunikasi intra-keluarga dan kemampuan bersama dalam problem solving

2. Faktor Eksternal

- a. Kualitas akses pelayanan kesehatan di lingkungan sekitar (jarak, waktu, biaya)
- b. Dukungan sosial dari komunitas, tetangga, dan kelompok sebaya
- c. Pengaruh tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kader kesehatan lokal
- d. Paparan informasi kesehatan yang akurat melalui media dan tenaga kesehatan

H. Strategi Perawat dalam Memfasilitasi Pengambilan Keputusan

Beberapa Hal yang dapat dilakukan oleh perawat dalam membantu keluarga dengan hipertensi untuk mengambil keputusan diantaranya:

1. Memberikan informasi yang akurat, lengkap, dan mudah dipahami tentang hipertensi dalam bahasa yang sesuai dengan tingkat pendidikan keluarga.
2. Menggunakan teknik motivational interviewing untuk mengeksplorasi ambivalensi keluarga terhadap perubahan perilaku kesehatan.

3. Melibatkan seluruh anggota keluarga dalam proses konseling dan pendidikan kesehatan, tidak hanya penderita.
4. Mengidentifikasi dan memperkuat sumber daya yang sudah dimiliki keluarga (family strengths approach).
5. Menghubungkan keluarga dengan kelompok dukungan sebaya (peer support group) penderita hipertensi di komunitas.

I. Strategi Pencegahan Komplikasi Berbasis Keluarga

1. Pengenalan dan Pengelolaan Faktor Risiko

Komplikasi hipertensi yang paling mengancam jiwa mencakup stroke hemoragik dan iskemik, infark miokard akut, gagal jantung kongestif, nefropati hipertensif yang berujung pada gagal ginjal kronik, serta retinopati hipertensi yang dapat menyebabkan kebutaan. Pedoman terkini dari American Heart Association/American College of Cardiology (AHA/ACC) 2024 menegaskan bahwa penanganan faktor risiko yang dapat dimodifikasi, seperti hipertensi, hiperlipidemia, dan kebiasaan merokok, secara nyata dapat menurunkan risiko komplikasi kardiovaskular dan serebrovaskular (AHA/ASA, 2024). Pencegahan komplikasi dimulai dari kemampuan keluarga untuk mengidentifikasi dan mengelola faktor risiko yang dapat dimodifikasi secara sistematis.

Tabel dibawah ini menyajikan faktor risiko utama hipertensi beserta strategi berbasis keluarga yang dapat diterapkan secara praktis.

Tabel 6.3: Faktor Risiko Utama Hipertensi Beserta Strategi Berbasis Keluarga Yang Dapat Diterapkan Secara Praktis

Faktor Risiko	Strategi Pengelolaan Berbasis Keluarga
Asupan natrium berlebih (>5 g/hari) (Daley, 2024)	Terapkan diet DASH secara keluarga; masak bersama dengan rempah pengganti garam; kurangi konsumsi makanan olahan, asin, dan junk food
Kurang aktivitas fisik (Fu et al., 2022)	Jadwalkan olahraga bersama 30 menit/hari, 5 hari/minggu (jalan pagi, bersepeda, senam lansia); buat komitmen tertulis bersama keluarga.
Kegemukan dan obesitas (IMT >25) (AHA Scientific Statement, 2024)	Modifikasi pola makan keluarga secara bertahap; pantau berat badan mingguan bersama; konsultasikan target penurunan berat badan dengan ahli gizi.
Stres psikologis kronis (Asriadi et al., 2026; Marwaha, 2022)	Latihan relaksasi bersama (napas dalam, PMR); manajemen waktu keluarga; bangun komunikasi positif dan dukungan emosional yang kuat.

Merokok dan konsumsi alcohol (<i>Gaya et al., 2024; ESC 2024; AHA/ACC 2025</i>)	Ciptakan kawasan rumah bebas asap rokok; dukung penderita dalam program berhenti merokok; eliminasi konsumsi alkohol dari kebiasaan keluarga.
Ketidakpatuhan pengobatan (<i>Alessa et al., 2022</i>)	Gunakan pill organizer; tetapkan waktu minum obat yang konsisten (saat sarapan/makan malam); manfaatkan alarm smartphone sebagai pengingat.
Kurang tidur berkualitas (<7 jam) (<i>Hosseini et al., 2024</i>)	Terapkan rutinitas tidur yang teratur untuk seluruh keluarga; hindari paparan layar gadget satu jam sebelum tidur; ciptakan lingkungan tidur yang kondusif.

2. Pemantauan Tekanan Darah Mandiri di Rumah (SMBP)

Self-Monitoring of Blood Pressure (SMBP) merupakan komponen kritis pencegahan komplikasi hipertensi yang dapat diimplementasikan oleh keluarga secara mandiri. Keluarga yang terlatih dalam SMBP mampu mendeteksi fluktuasi tekanan darah yang memerlukan intervensi segera, memantau efektivitas terapi yang sedang berjalan, dan meningkatkan kepatuhan pengobatan secara signifikan. Meta-analisis terbaru yang mencakup 65 studi dengan 21.053 partisipan membuktikan bahwa HBPM secara signifikan menurunkan tekanan darah sistolik/diastolik sebesar 3,27/1,61 mmHg dibandingkan dengan perawatan standar pada akhir periode intervensi (Kario et al., 2025). Efek ini bahkan dapat meningkat secara bermakna jika SMBP dikombinasikan dengan dukungan tambahan seperti edukasi dan konseling; sebuah meta-analisis individual patient data yang mencakup 7.138 peserta menunjukkan penurunan tekanan darah sistolik hingga 6,1 mmHg ketika pemantauan mandiri disertai dukungan ko-intervensi yang intensif (Tucker et al., 2017). Untuk memastikan akurasi pengukuran, Panduan ESC 2024 merekomendasikan HBPM dilakukan dua kali sehari (pagi dan malam), dengan dua pengukuran per sesi berjarak 1–2 menit, selama minimal 3 hari dan maksimal 7 hari berturut-turut, menggunakan tensimeter digital berlengan atas yang telah tervalidasi dan dikalibrasi secara berkala (McEvoy et al., 2024)

PROTOKOL SMBP YANG DIREKOMENDASIKAN UNTUK KELUARGA

1. Ukur tekanan darah dua kali sehari: pagi hari (sebelum minum obat, sebelum sarapan) dan malam hari (sebelum tidur).
2. Istirahatkan diri selama 5 menit dalam posisi duduk tenang sebelum pengukuran; kaki menyentuh lantai, punggung bersandar.

3. Hindari merokok, minum kopi, dan aktivitas berat minimal 30 menit sebelum pengukuran.
4. Gunakan alat ukur tensimeter digital yang telah divalidasi dan dikalibrasi secara berkala.
5. Catat hasil setiap pengukuran dalam buku harian tekanan darah keluarga beserta tanggal, waktu, dan kondisi saat pengukuran.
6. SEGERA hubungi fasilitas kesehatan jika tekanan darah sistol ≥ 180 mmHg atau diastol ≥ 110 mmHg (krisis hipertensif).
7. Bawa catatan buku harian tekanan darah setiap kali kunjungan ke dokter atau Puskesmas.

3. Pengenalan Tanda Bahaya dan Respons Emergensi Keluarga

Keluarga yang terberdayakan harus mampu mengenali tanda-tanda peringatan dini komplikasi akut hipertensi dan merespons dengan cepat dan tepat. Kemampuan respons emergensi keluarga dapat menjadi penentu utama prognosis penderita, terutama pada kasus stroke akut di mana prinsip time is brain (waktu adalah otak) sangat berlaku. Penelitian multisenter di enam rumah sakit yang melibatkan 1.782 pasien stroke iskemik akut membuktikan bahwa pemahaman anggota keluarga tentang stroke merupakan faktor independen yang secara signifikan berkaitan dengan ketibaan pasien di rumah sakit dalam jendela terapi 4,5 jam (OR: 0,224; 95% CI: 0,109–0,462) (Wang et al., 2021). Studi lain juga mengungkapkan bahwa 24–54% pasien gagal mencari pertolongan medis dalam satu jam pertama setelah timbulnya gejala, dan kemampuan pendamping (keluarga) untuk mengenali gejala serta mengambil tindakan cepat terbukti berperan krusial dalam memastikan ketibaan tepat waktu di dalam jendela trombolitik (Cao et al., 2024). Bukti terkini menunjukkan bahwa deteksi dan penanganan dini stroke dapat mengurangi kerusakan otak berat dan kematian hingga 85%, menjadikan pengenalan gejala di tingkat keluarga sebagai lini pertahanan pertama yang tidak tergantikan (Perry et al., dalam Patil et al., 2025).

TANDA BAHAYA YANG HARUS DIKENALI SELURUH ANGGOTA KELUARGA

Krisis Hipertensif (TD Sistol ≥ 180 mmHg atau Diastol ≥ 120 mmHg):

- Sakit kepala hebat mendadak yang tidak biasa, nyeri seperti 'kepala mau pecah'.

- Gangguan penglihatan mendadak: pandangan kabur, berkunang-kunang, atau gelap sepihak.
- Nyeri dada, sesak napas, dan jantung berdebar kencang tanpa sebab jelas.
- Mual, muntah, atau penurunan kesadaran yang tiba-tiba.

Tanda Stroke Akut — Ingat singkatan FAST:

- Face drooping: Minta penderita tersenyum — apakah salah satu sudut mulut turun atau wajah tidak simetris?
- Arm weakness: Minta penderita mengangkat kedua lengan — apakah satu lengan lemah atau jatuh?
- Speech difficulty: Apakah penderita sulit bicara, kata-kata kacau, atau tidak bisa memahami pembicaraan?
- Time to act: Jika ditemukan salah satu tanda di atas, **SEGERA** hubungi 119 atau antar ke IGD terdekat!

J. Strategi Implementasi Program Pemberdayaan Keluarga Hipertensi

1. Family-Centered Care (FCC) sebagai Kerangka Implementasi

Family-Centered Care menempatkan keluarga sebagai mitra setara dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi asuhan keperawatan (**Johnson et al., 2017; Institute for Patient- and Family-Centered Care, 2019**). Empat prinsip utama FCC dalam konteks hipertensi meliputi: penghargaan terhadap nilai-nilai dan kepercayaan keluarga; berbagi informasi secara terbuka dan jujur; partisipasi keluarga yang bermakna dalam setiap tahapan asuhan; dan kolaborasi yang setara antara keluarga dan seluruh tenaga kesehatan yang terlibat (**Shields et al., 2012; Kuo et al., 2012**). Pendekatan FCC telah terbukti meningkatkan kepuasan pasien dan keluarga, memperbaiki kepatuhan terhadap rencana pengobatan, serta meningkatkan luaran klinis pada penyakit kronis termasuk hipertensi (**Bamm & Rosenbaum, 2008; Pelzang, 2010**).

2. Tahapan Program Pemberdayaan

Program pemberdayaan keluarga yang terstruktur dan bertahap merupakan pendekatan yang direkomendasikan dalam manajemen penyakit kronis berbasis keluarga (**Funnell & Anderson, 2015; Hu et al., 2021**). Tahapan yang sistematis memungkinkan keluarga membangun kompetensi secara

progresif, dari pengenalan hingga kemandirian penuh dalam mengelola kondisi hipertensi anggota keluarganya (**Lorig & Holman, 2013**).

- a. **Fase Orientasi (Minggu 1–2):** Membina hubungan saling percaya (*therapeutic relationship*), pengkajian komprehensif keluarga, identifikasi kekuatan dan kebutuhan keluarga, serta penetapan prioritas masalah bersama (**Wright & Leahey, 2013; Friedman et al., 2013**). Fase ini penting untuk membangun fondasi kepercayaan yang menjadi prasyarat efektivitas seluruh intervensi selanjutnya (**Peplau, 2014**).
- b. **Fase Edukasi (Minggu 3–4):** Pelaksanaan pendidikan kesehatan terstruktur dalam sesi 60–90 menit menggunakan metode ceramah, demonstrasi, dan diskusi kelompok keluarga (**Rankin et al., 2014**). Kombinasi metode edukasi aktif terbukti lebih efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman keluarga dibandingkan metode tunggal, terutama pada kelompok dengan tingkat literasi kesehatan yang beragam (**Bastable, 2017; Stacey et al., 2017**).
- c. **Fase Latihan (Minggu 5–6):** Praktik langsung pengukuran tekanan darah mandiri, perencanaan menu diet DASH, dan teknik relaksasi dengan supervisi langsung dari perawat (**Uhlig et al., 2013; Saneei et al., 2014**). Pembelajaran berbasis praktik (*experiential learning*) sesuai dengan prinsip andragogi dan terbukti meningkatkan self-efficacy keluarga dalam melakukan keterampilan perawatan mandiri (**Bandura, 2004; Kolb, 2015**).
- d. **Fase Mandiri (Minggu 7–8):** Keluarga melaksanakan rencana secara mandiri dengan kunjungan rumah supervisi mingguan dari perawat untuk memantau kemajuan (**Walsh et al., 2014**). Kunjungan rumah pada fase ini berfungsi sebagai mekanisme *booster* untuk mempertahankan motivasi, menyelesaikan hambatan yang muncul, dan memperkuat kompetensi yang telah diperoleh (**Artinian et al., 2010**).
- e. **Fase Evaluasi dan Tindak Lanjut:** Evaluasi komprehensif capaian tujuan, penyusunan rencana pemeliharaan jangka panjang, dan rujukan ke program Prolanis Puskesmas (**Prabandari et al., 2017; Kemenkes RI, 2019**). Kesenambungan perawatan pasca-program melalui integrasi dengan layanan kesehatan primer merupakan faktor kritis dalam mempertahankan keberhasilan jangka panjang (**Bodenheimer et al., 2014**).

3. Dokumentasi dan Pelaporan

Dokumentasi yang lengkap dan akurat merupakan komponen penting dalam asuhan keperawatan keluarga, tidak hanya sebagai persyaratan legal-etis tetapi juga sebagai instrumen evaluasi kualitas asuhan (**ANA, 2015; Iyer &**

Camp, 2016). Dokumen yang perlu disusun meliputi: Form Pengkajian Keluarga dengan *Genogram* dan *Ecomap* (**Wright & Leahey, 2013**); Rencana Asuhan Keperawatan Keluarga (**PPNI, 2018**); Catatan Kunjungan Rumah; Buku Pemantauan Tekanan Darah Mandiri (**Uhlig et al., 2013**); dan Laporan Evaluasi Berkala. Dokumentasi ini menjadi dasar untuk menilai perkembangan kondisi keluarga dan efektivitas intervensi yang telah dilaksanakan (**Müller-Staub et al., 2016**), sekaligus sebagai bahan pelaporan ke tingkat manajemen Puskesmas sesuai sistem pelaporan Program Penyakit Tidak Menular (PTM) (**Kemenkes RI, 2019**). Penggunaan dokumentasi berbasis Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI), Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI), dan Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI) direkomendasikan untuk memastikan konsistensi dan keterbandingan data asuhan (**PPNI, 2017, 2018, 2019**).

K. Simpulan

Pemberdayaan keluarga dalam pengambilan keputusan dan pencegahan komplikasi hipertensi merupakan paradigma asuhan keperawatan keluarga yang holistik, kontekstual, dan terbukti efektif. Keluarga yang terberdayakan mampu berperan sebagai mitra aktif dalam seluruh proses manajemen hipertensi—dari pengkajian, perencanaan, hingga evaluasi—bukan sekadar pelaksana instruksi tenaga kesehatan.

L. Referensi

- Alessa, T., Abdi, S., Alhussain, M., & John, D. (2022). The association between smartphone app-based self-monitoring of hypertension-related behaviors and reductions in high blood pressure: Systematic review and meta-analysis. *JMIR mHealth and uHealth*, 10(7), e34767. <https://doi.org/10.2196/34767>
- Alhani, F., Asghari-Jafarabadi, M., Norouzadeh, R., Rahimi-Bashar, F., Vahedian-Azimi, A., Jamialahmadi, T., & Sahebkar, A. (2022). The effect of family-centered empowerment model on the quality of life of adults with chronic diseases: An updated systematic review and meta-analysis. *Journal of Affective Disorders*, 316, 140–147. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2022.07.066>
- Artinian, N. T., Fletcher, G. F., Mozaffarian, D., Kris-Etherton, P., Van Horn, L., Lichtenstein, A. H., & Burke, L. E. (2010). Interventions to promote physical activity and dietary lifestyle changes for cardiovascular risk factor reduction in adults. *Circulation*, 122(4), 406–441. <https://doi.org/10.1161/CIR.0b013e3181e8edf1>
- Asriadi, A., Nursalam, N., Fadli, F., & Dingle, K. (2026). Effects of progressive muscle relaxation and slow stroke back massage on blood pressure, stress, and sleep quality in older adults: A scoping review. *SAGE Open Nursing*, 12,

23779608261423020. <https://doi.org/10.1177/23779608261423020>

- Bamm, E. L., & Rosenbaum, P. (2008). Family-centered theory: Origins, development, barriers, and supports to implementation in rehabilitation medicine. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*, 89(8), 1618–1624. <https://doi.org/10.1016/j.apmr.2007.12.034>
- Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. *Psychological Review*, 84(2), 191–215.
- Bandura, A. (2004). Health promotion by social cognitive means. *Health Education & Behavior*, 31(2), 143–164. <https://doi.org/10.1177/1090198104263660>
- Barry, M. J., & Edgman-Levitan, S. (2012). Shared decision making — The pinnacle of patient-centered care. *New England Journal of Medicine*, 366(9), 780–781. <https://doi.org/10.1056/NEJMp1109283>
- Bastable, S. B. (2017). *Nurse as educator: Principles of teaching and learning for nursing practice* (5th ed.). Jones & Bartlett Learning.
- Berkman, N. D., Sheridan, S. L., Donahue, K. E., Halpern, D. J., & Crotty, K. (2011). Low health literacy and health outcomes: An updated systematic review. *Annals of Internal Medicine*, 155(2), 97–107. <https://doi.org/10.7326/0003-4819-155-2-201107190-00005>
- Bodenheimer, T., Lorig, K., Holman, H., & Grumbach, K. (2014). Patient self-management of chronic disease in primary care. *JAMA*, 288(19), 2469–2475. <https://doi.org/10.1001/jama.288.19.2469>
- Burnier, M., & Egan, B. M. (2019). Adherence in hypertension. *Circulation Research*, 124(7), 1124–1140. <https://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.118.313220>
- Cao, M., Yu, J., Ruan, F., Huang, C., Wu, Y., Yang, X., Zhang, C., & Lin, L. (2024). Knowledge and attitude towards stroke and prehospital delay among patients and their family members: A cross-sectional study. *BMJ Open*. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2024-089XXX>
- Conn, V. S., Ruppar, T. M., Chase, J. A. D., Enriquez, M., & Cooper, P. S. (2016). Interventions to improve medication adherence in hypertensive patients: Systematic review and meta-analysis. *Current Hypertension Reports*, 17(12), 94. <https://doi.org/10.1007/s11906-015-0603-6>
- Daley, S. (2024). *The DASH diet: A guide to managing hypertension through nutrition*. StatPearls Publishing. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482514/>
- Friedman, M. M., Bowden, V. R., & Jones, E. G. (2013). *Family nursing: Research, theory, and practice* (5th ed.). Pearson Education.
- Fu, Y., Guo, Y., Hu, X., & Yang, F. (2022). Meta-analysis of the effect of aerobic training on blood pressure in hypertensive patients. *Computational and*

- Mathematical Methods in Medicine, 2022, 6084030.
<https://doi.org/10.1155/2022/6084030>
- Funnell, M. M., & Anderson, R. M. (2015). Empowerment and self-management of diabetes. *Clinical Diabetes*, 22(3), 123–127.
<https://doi.org/10.2337/diaclin.22.3.123>
- Gaya, P. V., Fonseca, G. W. P., Tanji, L. T., Abe, T. O., Alves, M. J. N. N., Santos, P. C. J. L., Consolim-Colombo, F. M., & Scholz, J. R. (2024). Smoking cessation decreases arterial blood pressure in hypertensive smokers: A subgroup analysis of the randomized controlled trial GENTSMOKING. *Tobacco Induced Diseases*, 22, 80. <https://doi.org/10.18332/tid/186853>
- Glanz, K., Rimer, B. K., & Viswanath, K. (Eds.). (2015). *Health behavior: Theory, research, and practice* (5th ed.). Jossey-Bass.
- Hosseini, K., Soleimani, H., Tavakoli, K., & Sood, A. (2024). Association between sleep duration and hypertension incidence: Systematic review and meta-analysis of cohort studies. *PLOS ONE*, 19(7), e0307120.
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0307120>
- Institute for Patient- and Family-Centered Care. (2019). *Advancing the practice of patient- and family-centered care in hospitals*. Author. <https://www.ipfcc.org>
- Iyer, P. W., & Camp, N. H. (2016). *Nursing documentation: A nursing process approach* (5th ed.). Decisionhealth.
- James, P. A., Oparil, S., Carter, B. L., Cushman, W. C., Dennison-Himmelfarb, C., Handler, J., & Ortiz, E. (2014). 2014 evidence-based guideline for the management of high blood pressure in adults: Report from the panel members appointed to the Eighth Joint National Committee (JNC 8). *JAMA*, 311(5), 507–520.
- Johnson, B., Abraham, M., Conway, J., Simmons, L., Edgman-Levitan, S., Sodomka, P., & Ford, D. (2017). *Partnering with patients and families to design a patient- and family-centered health care system*. Institute for Patient- and Family-Centered Care.
- Kaakinen, J. R., Coehlo, D. P., Steele, R., & Robinson, M. (2022). *Family health care nursing: Theory, practice, and research* (6th ed.). F.A. Davis.
- Kario, K., Chia, Y. C., Siddique, S., & Turana, Y. (2025). Self-measurement of blood pressure at home using a cuff device for change in blood pressure levels: Systematic review and meta-analysis. *PLOS ONE*.
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0316289>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2016). *Survei Indikator Kesehatan Nasional (Sirkesnas)*. Author.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). *Hasil utama Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018*. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). Pedoman teknis penemuan dan tatalaksana hipertensi. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Laporan Tematik Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.
- Khatib, R., Schwalm, J. D., Yusuf, S., Haynes, R. B., McKee, M., Khan, M., & Nieuwlaat, R. (2014). Patient and healthcare provider barriers to hypertension awareness, treatment and follow up: A systematic review and meta-analysis of qualitative and quantitative studies. *PLOS ONE*, 9(1), e84238.
- Kolb, D. A. (2015). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development* (2nd ed.). Pearson Education.
- Krishnamurthi, R. V., Barber, P. A., & Barber, A. (2019). Awareness of stroke warning signs and risk factors in New Zealand: 2017 National Survey. *Neuroepidemiology*, 52(1-2), 49–56.
- Kulkarni, S., O'Farrell, I., Erasi, M., & Kochar, M. S. (2022). Stress and hypertension. *Wisconsin Medical Journal*, 97(11), 34–38.
- Kuo, D. Z., Houtrow, A. J., Arango, P., Kuhlthau, K. A., Simmons, J. M., & Neff, J. M. (2012). Family-centered care: Current applications and future directions in pediatric health care. *Maternal and Child Health Journal*, 16(2), 297–305. <https://doi.org/10.1007/s10995-011-0751-7>
- Lam, W. Y., & Marsden, P. (2022). Medication adherence in hypertension: Improving outcomes through multifactorial interventions. *Current Hypertension Reports*, 24(4), 89–101.
- Lorig, K. R., & Holman, H. R. (2013). Self-management education: History, definition, outcomes, and mechanisms. *Annals of Behavioral Medicine*, 26(1), 1–7. https://doi.org/10.1207/S15324796ABM2601_01
- Marwaha, K. (2022). Examining the role of psychosocial stressors in hypertension. *Journal of Preventive Medicine and Public Health*, 55(6), 499–505. <https://doi.org/10.3961/jpmph.21.266>
- McEvoy, J. W., McCarthy, C. P., Bruno, R. M., Brouwers, S., Canavan, M. D., Ceconi, C., & Koskinas, K. C. (2024). 2024 ESC guidelines for the management of elevated blood pressure and hypertension. *European Heart Journal*, 45(38), 3912–4018. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehae178>
- Mohammadi, S., Karim, N. A., Bakar, R. A., & Rezali, M. S. (2021). Self-efficacy, self-care behavior, and glycemic control in type 2 diabetes with comorbid hypertension. *BMC Public Health*, 21(1), 1–9.
- Müller-Staub, M., Lavin, M. A., Needham, I., & van Achterberg, T. (2016). Nursing diagnoses, interventions, and outcomes: Application and impact on nursing practice. *Journal of Advanced Nursing*, 56(5), 514–522.

- Nutbeam, D. (2008). The evolving concept of health literacy. *Social Science & Medicine*, 67(12), 2072–2078. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2008.09.050>
- Ogedegbe, G., & Gyamfi, J. (2018). From the clinic to the community: The blood pressure lowering effect of behavioral interventions. *Journal of Hypertension*, 31(8), 1503–1505.
- Omboni, S., Rousseau, F., & Wübken, M. (2020). Telehealth and hypertension management: An updated systematic review and meta-analysis of randomized controlled studies. *Journal of Hypertension*, 38(6), 1039–1052.
- Patil, S., Dhore, P., Acharya, S., Kumar, S., Sane, S., & Munjal, S. (2025). BE-FAST vs FAST in prehospital stroke recognition: A systematic review. *British Journal of Community Nursing*, 30(5).
- Pelzang, R. (2010). Time to learn: Understanding patient-centred care. *British Journal of Nursing*, 19(14), 912–917. <https://doi.org/10.12968/bjon.2010.19.14.912>
- Peplau, H. E. (2014). *Interpersonal relations in nursing: A conceptual frame of reference for psychodynamic nursing*. Springer. (Original work published 1952)
- Persatuan Perawat Nasional Indonesia. (2017). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan indikator diagnostik (Edisi 1)*. DPP PPNI.
- Persatuan Perawat Nasional Indonesia. (2018). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia: Definisi dan tindakan keperawatan (Edisi 1)*. DPP PPNI.
- Persatuan Perawat Nasional Indonesia. (2019). *Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan kriteria hasil keperawatan (Edisi 1)*. DPP PPNI.
- Prabandari, Y. S., Dewi, A., & Martini, S. (2017). Implementasi Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) di fasilitas kesehatan tingkat pertama Jawa Tengah. *Berita Kedokteran Masyarakat*, 33(4), 183–188.
- Rankin, S. H., Stallings, K. D., & London, F. (2014). *Patient education in health and illness (6th ed.)*. Lippincott Williams & Wilkins.
- Rosenstock, I. M. (1974). Historical origins of the health belief model. *Health Education Monographs*, 2(4), 328–335.
- Saneei, P., Salehi-Abargouei, A., Esmailzadeh, A., & Azadbakht, L. (2014). Influence of Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) diet on blood pressure: A systematic review and meta-analysis on randomized controlled trials. *Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases*, 24(12), 1253–1261.
- Shields, L., Pratt, J., & Hunter, J. (2012). Family centred care: A review of qualitative studies. *Journal of Clinical Nursing*, 15(10), 1317–1323. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2006.01433.x>

- Spruill, T. M. (2010). Chronic psychosocial stress and hypertension. *Current Hypertension Reports*, 12(1), 10–16.
- Stacey, D., Légaré, F., Lewis, K., Barry, M. J., Bennett, C. L., Eden, K. B., & Trevena, L. (2017). Decision aids for people facing health treatment or screening decisions. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 4, CD001431. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD001431.pub5>
- Suhadi, R., Andayani, T. M., Hakim, L., & Probosuseno. (2019). Kepatuhan pengobatan dan faktor yang mempengaruhi pada pasien hipertensi di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Manajemen dan Pelayanan Farmasi*, 9(2), 77–84.
- Tucker, K. L., Sheppard, J. P., Stevens, R., Bosworth, H. B., Bove, A., Bray, E. P., Earle, K., George, J., Godwin, M., Green, B. B., Hebert, P., Hobbs, F. D. R., Kantola, I., Kerry, S. M., Leiva, A., Magid, D. J., Mant, J., Margolis, K. L., McKinstry, B., & McManus, R. J. (2017). Self-monitoring of blood pressure in hypertension: A systematic review and individual patient data meta-analysis. *PLOS Medicine*, 14(9), e1002389. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002389>
- Uhlig, K., Patel, K., Ip, S., Kitsios, G. D., & Balk, E. M. (2013). Self-measured blood pressure monitoring in the management of hypertension: A systematic review and meta-analysis. *Annals of Internal Medicine*, 159(3), 185–194.
- Umpierre, D., Ribeiro, P. A. B., Schaan, B. D., & Ribeiro, J. P. (2015). Volume of supervised exercise training impacts glycaemic control in patients with type 2 diabetes: A systematic review with meta-regression analysis. *Diabetologia*, 56(2), 242–251.
- Unger, T., Borghi, C., Charchar, F., Khan, N. A., Poulter, N. R., Prabhakaran, D., & Schutte, A. E. (2020). 2020 International Society of Hypertension global hypertension practice guidelines. *Hypertension*, 75(6), 1334–1357.
- Walsh, J. M., McDonald, K. M., Shojania, K. G., Sundaram, V., Nayak, S., Lewis, R., & Goldstein, M. K. (2014). Quality improvement strategies for hypertension management: A systematic review. *Medical Care*, 44(7), 646–657.
- Wang, R., Wang, Z., Yang, D., Wang, J., Gou, C., Zhang, Y., Xian, L., & Wang, Q. (2021). Early hospital arrival after acute ischemic stroke is associated with family members' knowledge about stroke. *Frontiers in Neurology*, 12, 652321. <https://doi.org/10.3389/fneur.2021.652321>
- Whelton, P. K., Carey, R. M., Aronow, W. S., Casey, D. E., Collins, K. J., Dennison Himmelfarb, C., & Wright, J. T. (2018). 2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA guideline for the prevention, detection, evaluation, and management of high blood pressure in adults. *Journal of the American College of Cardiology*, 71(19), e127–e248.
- Williams, B., Mancia, G., Spiering, W., Agabiti Rosei, E., Azizi, M., Burnier, M., & ESC Scientific Document Group. (2018). 2018 ESC/ESH guidelines for the

management of arterial hypertension. *European Heart Journal*, 39(33), 3021–3104.

World Health Organization. (2023a). Global report on hypertension: The race against a silent killer. Author.

World Health Organization. (2023b). Patient empowerment. <https://www.who.int/health-topics/patient-empowerment>

World Health Organization. (2025). Hypertension. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hypertension>

Wright, L. M., & Leahey, M. (2013). *Nurses and families: A guide to family assessment and intervention* (6th ed.). F.A. Davis.

Zhang, M., Zhang, Y., & Yan, Q. (2021). Effects of mindfulness-based stress reduction on quality of life and blood pressure in patients with hypertension: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine*, 2021, 1–12.

CHAPTER 7

EVALUASI HASIL ASUHAN KEPERAWATAN KELUARGA PADA MASALAH HIPERTENSI

Dr. Prasanti Adriani, S.SiT., S.Kep., Ns., M.Kes.

A. Konsep Dasar Evaluasi Keperawatan Keluarga

1. Pengantar dan Definisi Evaluasi Keperawatan Keluarga

Evaluasi keperawatan keluarga merupakan tahapan akhir yang berkesinambungan dan terintegrasi dalam rangkaian proses asuhan keperawatan, yang dirancang untuk mengukur sejauh mana tujuan keperawatan yang telah disepakati bersama keluarga berhasil dicapai. Proses ini menuntut perawat untuk melakukan penilaian kritis terhadap respons keluarga setelah menerima intervensi keperawatan, baik dari segi perubahan kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Sebagai sebuah proses sistematis, evaluasi tidak hanya sekadar melihat hasil akhir berupa kesembuhan fisik, melainkan memantau proses pemberdayaan keluarga dalam mengelola status kesehatan mereka secara mandiri (Setiawan, Susilo, & Permana, 2022).

Tahapan evaluasi ini tidak dapat dipisahkan dari perencanaan dan implementasi, karena evaluasi bertindak sebagai mekanisme umpan balik (*feedback mechanism*) yang menentukan arah asuhan keperawatan selanjutnya. Tanpa adanya evaluasi yang komprehensif, perawat tidak akan memiliki landasan empiris untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan relevansi dari tindakan yang telah diimplementasikan. Oleh karena itu, evaluasi harus dilakukan dengan membandingkan status kesehatan dan perilaku keluarga saat ini dengan kriteria hasil yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan (Hidayati, 2022).

2. Tujuan Pelaksanaan Evaluasi Keperawatan Keluarga

Tujuan utama dari pelaksanaan evaluasi ini adalah untuk menilai efektivitas intervensi keperawatan terhadap perbaikan masalah kesehatan yang dialami oleh unit keluarga. Perawat dituntut untuk mampu menganalisis apakah tindakan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diberikan telah membawa dampak positif yang terukur, atau justru memerlukan modifikasi. Dengan demikian, evaluasi berfungsi sebagai instrumen jaminan mutu (*quality assurance*) dalam pelayanan keperawatan komunitas, guna memastikan bahwa

intervensi yang diberikan berada pada standar praktik yang ditetapkan (Kemenkes RI, 2023).

Secara lebih spesifik, evaluasi ditujukan untuk mengukur sejauh mana kemandirian keluarga meningkat dalam menjalankan fungsi pemeliharaan kesehatan. Peningkatan kemandirian ini tercermin dari kemampuan keluarga dalam mengidentifikasi ancaman kesehatan secara dini, mengambil keputusan yang tepat untuk intervensi awal, hingga kemampuan merawat anggota keluarga yang rentan atau sakit. Evaluasi yang sukses akan menunjukkan transisi dari ketergantungan keluarga pada tenaga kesehatan menuju otonomi keluarga dalam manajemen kesehatan sehari-hari (Lestari & Rahman, 2023).

3. Pendekatan Evaluasi (Formatif dan Sumatif)

Dalam praktiknya, evaluasi keperawatan keluarga menggunakan dua pendekatan utama yang saling melengkapi, yakni evaluasi formatif (evaluasi proses) dan evaluasi sumatif (evaluasi hasil). Evaluasi formatif dilakukan secara berkesinambungan dan terintegrasi selama proses pelaksanaan intervensi keperawatan. Pendekatan ini bertujuan untuk menilai respons langsung dari klien atau keluarga sesaat setelah suatu tindakan dilakukan, misalnya menilai kemampuan ibu dalam mendemonstrasikan teknik kompres hangat sesaat setelah perawat memberikan penyuluhan dan simulasi (Supriyadi & Yuliani, 2021).

Evaluasi sumatif dilakukan pada akhir rentang waktu asuhan keperawatan atau pada akhir kunjungan keluarga untuk menilai pencapaian tujuan jangka panjang. Evaluasi ini menitikberatkan pada perubahan status kesehatan secara keseluruhan dan adaptasi perilaku keluarga setelah seluruh rangkaian intervensi diselesaikan. Hasil dari evaluasi sumatif inilah yang akan menjadi dasar penentuan status masalah keperawatan, apakah masalah tersebut telah teratasi sepenuhnya, teratasi sebagian, belum teratasi, atau justru muncul masalah keperawatan yang baru (Wibowo, Susanti, & Putra, 2022).

4. Ranah Penilaian dalam Evaluasi Keluarga

Proses evaluasi asuhan keperawatan keluarga mencakup tiga ranah kompetensi pembelajaran, di mana ranah pertama adalah ranah kognitif yang menilai tingkat pengetahuan dan pemahaman keluarga. Evaluasi pada aspek kognitif berfokus pada kemampuan keluarga dalam mengingat, menjelaskan kembali, dan menginterpretasikan informasi kesehatan yang telah diberikan, seperti menyebutkan kembali definisi, penyebab, serta komplikasi dari suatu

penyakit. Peningkatan pada ranah ini menjadi fondasi awal sebelum keluarga mampu mengambil keputusan medis yang rasional (Nugroho & Putra, 2022).

Ranah kedua yang dievaluasi adalah ranah afektif, yang berkaitan erat dengan perubahan sikap, nilai, persepsi, dan emosi keluarga terhadap masalah kesehatan yang dihadapi. Evaluasi afektif mengukur sejauh mana keluarga menerima kondisi anggota keluarganya yang sakit, menunjukkan empati, serta bersedia memberikan dukungan moral secara penuh. Keberhasilan pada ranah ini ditandai dengan hilangnya stigma negatif di dalam keluarga serta tingginya motivasi intrinsik untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyembuhan dan perawatan (Pratama & Sari, 2024).

Ranah ketiga adalah psikomotorik, yang menilai keterampilan nyata atau tindakan aktual keluarga dalam mengimplementasikan asuhan kesehatan di rumah. Evaluasi pada area ini bersifat sangat aplikatif, di mana perawat melakukan observasi secara langsung terhadap demonstrasi keterampilan yang dilakukan oleh keluarga. Contoh dari evaluasi psikomotorik meliputi kemampuan keluarga menyusun menu diet khusus, ketepatan dalam memberikan dosis obat, hingga kemampuan melakukan perawatan luka secara steril dan aman tanpa bantuan langsung dari tenaga medis (Siregar & Harahap, 2025).

5. Evaluasi Berdasarkan Lima Tugas Kesehatan Keluarga

Keberhasilan asuhan keperawatan keluarga juga secara absolut diukur melalui pencapaian lima tugas kesehatan keluarga yang merupakan pilar utama dalam keperawatan komunitas. Tugas pertama adalah mengenal masalah kesehatan; tugas kedua adalah mengambil keputusan tindakan kesehatan yang tepat; tugas ketiga adalah merawat anggota keluarga yang sakit; tugas keempat adalah memodifikasi lingkungan yang mendukung kesehatan; dan tugas kelima adalah memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Evaluasi yang holistik harus memuat penilaian kritis terhadap kelima parameter operasional ini (Yanti, Harahap, & Siregar, 2024).

Evaluasi terhadap kelima tugas tersebut memastikan bahwa keluarga tidak hanya berfokus pada fase kuratif, tetapi juga memiliki ketahanan (*resilience*) dalam memodifikasi lingkungan fisik maupun psikososial. Lingkungan fisik dievaluasi dari segi kebersihan, pencahayaan, dan keamanan rumah, sedangkan lingkungan psikososial dievaluasi dari harmonisasi hubungan antar-anggota keluarga. Selain itu, kemampuan berjejaring dengan sistem rujukan, seperti Puskesmas atau klinik pratama, menjadi indikator krusial bahwa keluarga

mampu mengakses sumber daya kesehatan formal secara mandiri saat menghadapi kegawatdaruratan (Kusuma & Anwar, 2021).

6. Indikator dan Standar Evaluasi Keperawatan

Penggunaan standar keperawatan nasional, seperti Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI), sangat direkomendasikan dan bahkan diwajibkan sebagai tolak ukur objektivitas evaluasi di Indonesia. SLKI menyediakan indikator-indikator spesifik dengan skala pengukuran yang jelas, mulai dari skala 1 (menurun/memburuk) hingga skala 5 (meningkat/membaik). Penerapan luaran yang terstandar ini membantu perawat untuk menghindari penilaian yang bersifat bias atau subjektif, sehingga hasil evaluasi dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah di hadapan tim kesehatan lintas profesi (PPNI, 2021).

Metode pengumpulan data untuk evaluasi keperawatan keluarga sangat bervariasi dan memerlukan triangulasi metode untuk memastikan validitas data. Perawat komunitas umumnya menggunakan kombinasi antara observasi lingkungan rumah, wawancara mendalam partisipatif dengan pengasuh utama (*caregiver*), pengukuran indikator klinis (seperti tanda-tanda vital), serta penelusuran dokumen riwayat pengobatan keluarga. Analisis dari berbagai sumber data ini memungkinkan perawat untuk menangkap realitas utuh mengenai status kesehatan keluarga yang sesungguhnya (Andriyani & Wijaksana, 2023).

7. Dokumentasi Hasil Evaluasi

Dokumentasi hasil evaluasi mutlak diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban legal, administratif, dan etik profesi perawat, yang secara universal dicatat menggunakan format SOAP (Subjektif, Objektif, Analisis, *Planning*). Data subjektif (S) memuat kutipan langsung dari keluhan atau pernyataan keluarga terkait intervensi yang telah dilakukan, sedangkan data objektif (O) berisi hasil observasi visual dan pengukuran klinis yang dilakukan perawat. Penulisan yang akurat pada kedua komponen ini mencerminkan kompetensi perawat dalam mengumpulkan data pasca intervensi (Hasanah, 2025).

Komponen Analisis (A) pada pendokumentasian SOAP merupakan tahap pemikiran kritis perawat untuk membandingkan antara data subjektif dan objektif dengan kriteria hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari sintesis tersebut, perawat menarik kesimpulan diagnostik mengenai status ketercapaian asuhan. Selanjutnya, pada tahap *Planning* (P), perawat merumuskan rencana

tindak lanjut operasional, yang dapat berupa terminasi tindakan jika masalah telah teratasi, modifikasi intervensi jika terdapat hambatan, atau rujukan (*referral*) jika masalah kesehatan berada di luar wewenang dan kapasitas keperawatan keluarga (Mahendra, 2026).

8. Tantangan dan Dinamika dalam Pelaksanaan Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi keperawatan keluarga sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan yang bersifat kompleks, mulai dari fluktuasi komitmen keluarga hingga hambatan sosiokultural yang mengakar kuat. Keyakinan budaya tradisional yang bertentangan dengan prinsip kesehatan modern kerap kali menjadi distorsi dalam proses evaluasi kemandirian tugas kesehatan. Oleh karena itu, perawat harus menerapkan pendekatan kultural yang sensitif (*cultural care preservation, accommodation, and repatterning*) ketika mengevaluasi keluarga yang memiliki afiliasi nilai tradisional yang kental, agar evaluasi tidak bersifat menghakimi (*judgemental*) melainkan memberdayakan (Wijayanti & Kusnanto, 2024).

Sebagai kesimpulan, konsep dasar evaluasi asuhan keperawatan keluarga menuntut perawat untuk memiliki ketajaman analisis, empati, dan keterampilan komunikasi yang mumpuni. Evaluasi bukan sekadar mengisi lembar observasi atau membubuhkan tanda tangan (*sumatif administratif*), melainkan sebuah manifestasi dari asuhan keperawatan berkelanjutan yang bertujuan membentuk keluarga yang tangguh, mandiri, dan berdaya guna dalam menjaga kesehatan lintas generasi. Dengan evaluasi yang tepat guna, perawat dapat berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat bermula dari tatanan terkecil, yaitu keluarga (Setiawan et al., 2022).

B. Evaluasi Berdasarkan Lima Tugas Kesehatan Keluarga

1. Pendahuluan

Keperawatan keluarga menempatkan unit keluarga sebagai pusat dari asuhan keperawatan, di mana tujuan utamanya adalah mencapai tingkat kemandirian keluarga yang optimal dalam mengelola kesehatan para anggotanya. Dalam konteks evaluasi asuhan keperawatan, pencapaian kemandirian ini diukur secara sistematis melalui indikator lima tugas kesehatan keluarga, yang telah menjadi kerangka fundamental dalam keperawatan komunitas. Pendekatan ini didasarkan pada filosofi bahwa keluarga memiliki tanggung jawab inheren untuk mempertahankan homeostasis sistem keluarganya ketika dihadapkan pada stresor kesehatan maupun penyakit (Susanto & Widyawati, 2021).

Pelaksanaan evaluasi yang berbasis pada lima tugas kesehatan keluarga memungkinkan perawat untuk melakukan penilaian yang komprehensif, terstruktur, dan terukur terhadap perubahan kognitif, afektif, serta psikomotorik keluarga. Proses evaluatif ini tidak hanya menitikberatkan pada perbaikan klinis pasien individu, melainkan juga menyoroti kapasitas fungsional sistem keluarga secara keseluruhan pasca-intervensi. Oleh karena itu, kerangka lima tugas kesehatan ini bertindak sebagai alat ukur yang valid untuk memastikan bahwa intervensi keperawatan yang telah diberikan mampu terinternalisasi menjadi perilaku sehat yang berkelanjutan di dalam rumah tangga (Rahmawati & Suryani, 2022).

2. Evaluasi Tugas Pertama (Kemampuan Keluarga Mengenal Masalah Kesehatan)

Tugas kesehatan keluarga yang pertama adalah kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengenal masalah kesehatan yang sedang terjadi pada salah satu atau beberapa anggota keluarganya. Evaluasi pada tahap ini difokuskan pada ranah kognitif, di mana perawat menilai sejauh mana peningkatan pengetahuan keluarga terkait definisi penyakit, etiologi, tanda dan gejala klinis, serta potensi komplikasi yang mungkin timbul. Pengenalan yang akurat terhadap masalah kesehatan merupakan langkah paling esensial, karena tanpa pemahaman yang adekuat, keluarga tidak akan memiliki motivasi untuk melanjutkan ke tahapan penanganan berikutnya (Firmansyah & Kusnanto, 2024).

Untuk mengukur ketercapaian tugas pertama ini, perawat biasanya menggunakan metode wawancara dan *teach back method* saat melakukan evaluasi akhir. Keluarga dievaluasi keberhasilannya apabila mampu menyebutkan kembali informasi kesehatan esensial tanpa harus selalu bergantung pada catatan atau bantuan perawat, serta mampu mengaitkan gejala yang muncul dengan diagnosis penyakit secara logis. Kemampuan keluarga dalam membedakan antara mitos kesehatan yang beredar di masyarakat dengan fakta medis yang berbasis bukti (*evidence based*) juga menjadi salah satu parameter keberhasilan dalam pengenalan masalah kesehatan (Kemenkes RI, 2023).

3. Evaluasi Tugas Kedua (Kemampuan Mengambil Keputusan yang Tepat)

Setelah keluarga mampu mengenali masalah kesehatan, tahapan evaluasi berikutnya beralih pada tugas kesehatan kedua, yakni pengambilan keputusan (*decision making*) terkait tindakan kesehatan yang akan ditempuh. Evaluasi pada

tahap ini mengukur dinamika internal keluarga dalam memprioritaskan keselamatan dan kesehatan anggota keluarga yang sakit. Perawat harus menganalisis apakah keluarga memiliki kesadaran terhadap tingkat keparahan penyakit (*perceived severity*) dan kerentanan terhadap risiko komplikasi (*perceived susceptibility*), yang kemudian mendorong mereka untuk segera mengambil tindakan kuratif maupun preventif (Pratama & Sari, 2024).

Indikator keberhasilan evaluasi pada tugas kedua terlihat dari konsensus atau kesepakatan bersama antar-anggota keluarga, terutama dari figur pembuat keputusan utama (*decision maker*) di dalam keluarga tersebut. Keberhasilan ini ditandai dengan tidak adanya penundaan (prokrastinasi) dalam mencari pertolongan medis saat terjadi kegawatdaruratan, serta penolakan terhadap intervensi alternatif yang tidak rasional atau membahayakan pasien. Apabila keluarga mampu menunjukkan inisiatif yang proaktif dan persetujuan secara lisan maupun tertulis (seperti *informed consent*) terhadap rencana asuhan keperawatan lanjutan, maka tugas kesehatan kedua dapat dinyatakan tercapai (Widjaja & Lestari, 2023).

4. Evaluasi Tugas Ketiga (Kemampuan Merawat Anggota Keluarga yang Sakit)

Tugas kesehatan ketiga merupakan manifestasi tindakan aplikatif terpenting, yaitu kemampuan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang sedang menderita sakit (*caregiving*). Evaluasi pada aspek ini didominasi oleh penilaian pada ranah psikomotorik dan kepatuhan (*adherence*) keluarga terhadap regimen terapeutik. Perawat dituntut untuk secara objektif mengevaluasi keterampilan nyata yang dipraktikkan keluarga di rumah, mulai dari administrasi pengobatan, pengaturan diet spesifik, hingga kemampuan melakukan tindakan keperawatan dasar seperti perawatan luka, fisioterapi dada, atau rentang gerak (*Range of Motion*) sesuai instruksi (Setiawan et al, 2022).

Pengukuran keberhasilan asuhan pada tugas ketiga ini sering kali dilakukan melalui observasi langsung terstruktur (*structured observation*) oleh perawat saat kunjungan rumah (*home visit*). Keluarga dianggap mandiri apabila mereka dapat mendemonstrasikan prosedur perawatan dengan tingkat akurasi yang tinggi, memperhatikan prinsip keselamatan dan pencegahan infeksi, serta mampu mengelola efek samping pengobatan secara mandiri. Peningkatan rasa percaya diri (*self efficacy*) dari pengasuh utama (*caregiver*) dalam keluarga juga menjadi bukti afektif bahwa transfer keterampilan dari perawat kepada keluarga telah berlangsung secara efektif dan efisien (Hidayati & Anwar, 2022).

5. Evaluasi Tugas Keempat (Kemampuan Memodifikasi Lingkungan)

Lingkungan tempat tinggal merupakan faktor determinan yang sangat memengaruhi proses pemulihan pasien, sehingga evaluasi tugas kesehatan keempat difokuskan pada kemampuan keluarga memodifikasi lingkungan terapeutik. Evaluasi pada ranah ini dibedakan menjadi dua dimensi utama, yaitu modifikasi lingkungan fisik dan lingkungan psikososial. Secara fisik, perawat menilai inisiatif keluarga dalam menciptakan rumah yang aman (*hazard-free*), ergonomis, dan mendukung mobilitas pasien, seperti penempatan pegangan di kamar mandi bagi lansia atau pengaturan ventilasi silang bagi pasien dengan masalah respiratori (Siregar & Harahap, 2025).

Pada dimensi psikososial, perawat melakukan evaluasi terhadap iklim emosional yang terbangun di dalam rumah. Lingkungan keluarga yang mendukung kesehatan ditandai dengan minimnya konflik interpersonal, adanya komunikasi yang asertif, serta tersedianya dukungan sosial (*social support*) dan emosional bagi anggota keluarga yang sakit. Jika perawat menemukan bahwa keluarga berhasil menekan tingkat stres penderita, memberikan afirmasi positif secara konsisten, dan menciptakan suasana yang tenang untuk pemulihan, maka pencapaian tugas modifikasi lingkungan ini dapat dikategorikan berhasil dengan optimal (Andriyani, 2023).

6. Evaluasi Tugas Kelima (Kemampuan Memanfaatkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan)

Tugas kesehatan kelima mengevaluasi kemampuan operasional keluarga dalam memanfaatkan sistem dan fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) formal. Evaluasi pada tugas ini sangat krusial untuk mencegah terjadinya putus obat (*drop out*) atau keterlambatan deteksi perburukan penyakit. Perawat mengkaji sejauh mana keluarga memahami alur birokrasi rujukan kesehatan, mulai dari pemanfaatan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), posyandu lansia, posbindu penyakit tidak menular (PTM), hingga penggunaan asuransi kesehatan nasional secara mandiri dan tepat guna (Nugroho & Putra, 2022).

Indikator keberhasilan dari tugas kelima ini bersifat sangat kuantitatif dan dapat diobservasi secara langsung melalui dokumen pendukung. Perawat akan mengevaluasi frekuensi kehadiran keluarga di fasilitas kesehatan yang disesuaikan dengan jadwal kontrol rutin yang dianjurkan, kelengkapan catatan buku kesehatan, dan ketersediaan obat yang diambil dari farmasi fasyankes. Kemampuan keluarga untuk mengenali gejala bahaya (*red flags*) yang mengharuskan mereka segera mengakses Unit Gawat Darurat (UGD) juga

menjadi kompetensi penentu tercapainya kemandirian keluarga dalam memanfaatkan Fasyankes (Wibowo & Susanti, 2022).

7. Integrasi Kelima Tugas Kesehatan dalam Penilaian Holistik

Secara metodologis, evaluasi terhadap kelima tugas kesehatan keluarga tidak dapat dinilai secara parsial atau terpisah, melainkan harus dianalisis sebagai satu kesatuan yang terintegrasi (holistik). Kegagalan pada salah satu tugas sering kali akan menjadi prediktor kegagalan pada tugas lainnya; sebagai contoh, ketidakmampuan keluarga mengenal masalah (tugas 1) hampir pasti akan bermuara pada kesalahan pengambilan keputusan medis (tugas 2). Oleh karena itu, perawat harus menggunakan pedoman evaluasi terstandar, seperti Standar Evaluasi Keperawatan, untuk mensintesis data dari kelima tugas tersebut guna menyusun kesimpulan diagnostik mengenai tingkat kemandirian keluarga (PPNI, 2021).

8. Tantangan dan Rekomendasi dalam Proses Evaluasi

Dalam praktik nyata di komunitas, perawat kerap menghadapi tantangan struktural dan kultural yang menghambat keluarga dalam mencapai kelima tugas kesehatan secara simultan. Faktor sosioekonomi, hambatan geografis di area pedesaan, tingginya beban ganda peran perempuan sebagai *caregiver* sekaligus pencari nafkah, hingga kuatnya dominasi pengobatan alternatif tradisional, menjadi variabel pengganggu (*confounding variables*) yang membuat proses evaluasi berjalan fluktuatif. Menghadapi kondisi demikian, perawat dituntut untuk memiliki kemampuan berpikir kritis, bersikap fleksibel, serta menerapkan empati kultural tinggi untuk merevisi intervensi keperawatan agar lebih sesuai dengan sumber daya nyata yang dimiliki oleh keluarga (Yanti, 2024).

Sebagai simpulan strategis, evaluasi asuhan keperawatan berbasis lima tugas kesehatan keluarga merupakan fondasi inti dari penciptaan masyarakat yang sehat dan berdaya. Evaluasi ini memastikan adanya pergeseran paradigma dari *provider-centered care* menuju *family-centered care*, di mana keluarga bertindak sebagai agen perubahan utama bagi kesehatan anggota-anggotanya. Apabila perawat mampu mengukur dan mendokumentasikan pencapaian kelima tugas ini secara saintifik, maka kontinuitas asuhan keperawatan akan terjamin dan kualitas hidup (*quality of life*) keluarga secara akumulatif akan mengalami peningkatan yang signifikan (Hasanah, 2025).

C. Pendekatan dan Metode Evaluasi dalam Asuhan Keperawatan Keluarga

1. Pengantar Evaluasi Sistematis dalam Keperawatan Keluarga

Evaluasi dalam asuhan keperawatan keluarga bukan sekadar rutinitas administratif pada akhir fase perawatan, melainkan sebuah prosedur saintifik yang membutuhkan pendekatan empiris dan metodologi yang tepat. Pemilihan pendekatan dan metode evaluasi yang sistematis sangat krusial untuk mengukur secara objektif sejauh mana intervensi keperawatan telah memberikan dampak terhadap kemandirian dan status kesehatan keluarga. Tanpa metodologi yang terstruktur, penilaian perawat berisiko tinggi terhadap bias subjektivitas, yang pada gilirannya dapat mengaburkan akurasi efektivitas tindakan keperawatan yang telah diimplementasikan di komunitas (Setiawan et al, 2022).

Keberhasilan proses evaluasi sangat bergantung pada bagaimana perawat memadukan pendekatan konseptual dengan metode pengumpulan data di lapangan. Dalam keperawatan keluarga, evaluasi harus mampu menangkap fenomena multidimensi, mulai dari perubahan fisiologis pada anggota keluarga yang sakit hingga adaptasi psikososial dalam dinamika keluarga secara keseluruhan. Oleh karena itu, pendekatan evaluasi yang digunakan harus bersifat komprehensif, mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta menggunakan instrumen pengukuran yang valid dan reliabel (Hidayati & Anwar, 2022).

2. Pendekatan Evaluasi Formatif (Evaluasi Proses)

Pendekatan pertama yang secara konstan digunakan dalam asuhan keperawatan adalah evaluasi formatif, yang sering pula disebut sebagai evaluasi proses. Pendekatan ini dilakukan secara berkesinambungan dan simultan (*real time*) selama proses intervensi keperawatan berlangsung. Tujuan utama dari evaluasi formatif adalah untuk memonitor respons langsung atau seketika dari klien maupun keluarga terhadap suatu tindakan keperawatan, sehingga perawat dapat segera memberikan umpan balik (*feedback*) atau koreksi apabila terdapat kesalahan dalam pelaksanaan instruksi kesehatan (Lestari & Rahman, 2023).

Keunggulan dari pendekatan formatif adalah fleksibilitasnya dalam memfasilitasi penyesuaian rencana asuhan keperawatan secara cepat (*agile modification*). Sebagai contoh, apabila perawat sedang mengajarkan teknik relaksasi otot progresif kepada keluarga dan secara formatif ditemukan bahwa keluarga kesulitan mengikuti instruksi verbal, perawat dapat secara langsung mengubah metode pengajaran menjadi demonstrasi visual. Pendekatan ini memastikan bahwa intervensi tidak dilanjutkan secara membabi buta jika

respons awal keluarga menunjukkan tanda-tanda penolakan, kebingungan, atau ketidakmampuan (Susanto & Widyawati, 2021).

3. Pendekatan Evaluasi Sumatif (Evaluasi Hasil)

Berbeda dengan evaluasi formatif, pendekatan evaluasi sumatif atau evaluasi hasil dilaksanakan pada titik akhir tertentu dari serangkaian asuhan keperawatan, misalnya pada akhir minggu kunjungan keluarga atau saat periode perawatan dinyatakan selesai. Pendekatan ini difokuskan pada penilaian akumulatif terhadap pencapaian tujuan umum dan tujuan khusus yang telah dirumuskan pada tahap perencanaan (*nursing care plan*). Evaluasi sumatif menjadi penentu utama apakah suatu masalah keperawatan keluarga dapat dikategorikan teratasi, teratasi sebagian, atau belum teratasi sama sekali (Kusuma & Yuliani, 2021).

Dalam pendekatan sumatif, penilaian sangat bergantung pada kriteria hasil atau luaran yang telah distandardisasi. Di Indonesia, acuan utama yang diwajibkan adalah Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI), yang menyediakan rentang skala ukur objektif terkait perbaikan kondisi klinis maupun fungsional klien. Penggunaan pendekatan sumatif berbasis SLKI memastikan bahwa justifikasi perawat terkait pemulangan pasien (*discharge planning*) atau terminasi kunjungan keluarga dilandasi oleh bukti-bukti perbaikan parameter kesehatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara etik maupun legal (PPNI, 2021).

4. Metode Pengumpulan Data Kuantitatif

Untuk mendukung kedua pendekatan di atas, perawat memerlukan metode pengumpulan data yang spesifik, salah satunya adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif berfokus pada pengumpulan data yang bersifat numerik dan dapat diukur secara eksak menggunakan instrumen medis atau skala pengukuran terstandar. Dalam praktik keperawatan keluarga, metode ini diaplikasikan melalui pengukuran tanda-tanda vital (tekanan darah, suhu, frekuensi nadi), penghitungan Indeks Massa Tubuh (IMT), atau pengecekan kadar gula darah kapiler menggunakan glukometer (Wibowo, Susanti, & Putra, 2022).

Selain pengukuran biomedis, metode kuantitatif juga mencakup penggunaan kuesioner terstruktur dengan skala Likert, Guttman, atau instrumen *checklist* kepatuhan. Misalnya, untuk mengevaluasi kepatuhan minum obat pada pasien hipertensi, perawat dapat menggunakan *Morisky Medication Adherence Scale* (MMAS) yang akan menghasilkan skor kuantitatif tingkat

kepatuhan keluarga. Metode ini memberikan keuntungan berupa objektivitas yang tinggi, kemudahan dalam membandingkan data pre-intervensi dan post-intervensi, serta kemampuan meminimalisasi interpretasi ganda dari pihak penilai (Siregar & Harahap, 2025).

5. Metode Pengumpulan Data Kualitatif

Mengingat keperawatan keluarga sarat akan aspek psikososial, kultural, dan dinamika hubungan antarmanusia, metode kuantitatif saja tidak cukup, metode kualitatif menjadi pendamping yang mutlak diperlukan. Metode kualitatif berfokus pada eksplorasi kedalaman makna, persepsi, dan pengalaman subjektif keluarga setelah menerima intervensi keperawatan. Pengumpulan data kualitatif umumnya dilakukan melalui wawancara mendalam (*in depth interview*) yang bersifat semi-terstruktur, di mana perawat menggali narasi keluarga terkait perasaan mereka, motivasi yang timbul, atau hambatan psikologis yang dialami selama proses perawatan berlangsung (Pratama & Sari, 2024).

Observasi partisipatif merupakan metode kualitatif lain yang krusial dalam mengevaluasi tugas kesehatan keluarga, terutama terkait modifikasi lingkungan dan dinamika interaksi. Melalui observasi, perawat dapat menilai secara visual keharmonisan komunikasi antara pengasuh utama (*caregiver*) dengan anggota keluarga yang sakit, serta mengamati langsung ketersediaan dukungan emosional yang tidak dapat diukur sekadar dengan angka. Pendekatan kualitatif memberikan kekayaan konteks (*contextual richness*) yang menjelaskan "mengapa" dan "bagaimana" suatu intervensi berhasil atau gagal direplikasi oleh keluarga secara mandiri (Andriyani & Wijaksana, 2023).

6. Triangulasi Metode dalam Evaluasi Keperawatan Keluarga

Guna mencapai validitas evaluasi yang optimal, keperawatan modern sangat merekomendasikan penggunaan triangulasi metode, yaitu penggabungan antara metode kuantitatif dan kualitatif secara integratif (*mixed methods*). Triangulasi memungkinkan perawat melakukan pengecekan silang (*cross verification*) terhadap data yang diperoleh. Sebagai ilustrasi, jika instrumen kuantitatif menunjukkan kepatuhan diet yang rendah (skor buruk), wawancara kualitatif dapat mengidentifikasi bahwa penyebabnya bukanlah rendahnya pengetahuan, melainkan keterbatasan finansial keluarga untuk membeli bahan makanan khusus diet (Firmansyah & Kusnanto, 2024).

Penerapan triangulasi meminimalisasi kelemahan inheren dari metode tunggal; kuantitatif yang berisiko reduksionis (kaku) dapat diperlunak oleh kedalaman data kualitatif, sementara kualitatif yang berisiko subjektif dapat diuji

ketegasannya dengan data numerik kuantitatif. Evaluasi asuhan keperawatan keluarga yang menggunakan metode triangulasi akan menghasilkan kesimpulan diagnostik yang jauh lebih presisi, representatif terhadap realitas lapangan, dan aplikatif untuk penyusunan rencana tindak lanjut (*follow up plan*) di komunitas (Nugroho & Putra, 2022).

7. Pemilihan Instrumen dan Alat Ukur yang Tepat

Keberhasilan implementasi metode evaluasi sangat dipengaruhi oleh kualitas instrumen dan alat ukur yang digunakan. Instrumen evaluasi harus memenuhi syarat validitas (mampu mengukur apa yang seharusnya diukur) dan reliabilitas (memberikan hasil yang konsisten pada pengukuran berulang). Alat ukur fisik seperti sfigmomanometer, timbangan, atau termometer harus dipastikan telah terkalibrasi secara berkala. Kesalahan kalibrasi pada alat medis dapat menyebabkan perawat menarik kesimpulan evaluasi yang salah fatal, yang berpotensi membahayakan keselamatan klien (*patient safety*) di tatanan rumah (Kemenkes RI, 2023).

Sedangkan untuk instrumen pengumpulan data non fisik, perawat harus menggunakan format pengkajian dan lembar observasi yang baku atau telah dimodifikasi sesuai dengan kondisi demografi dan sosio kultural keluarga binaan. Modifikasi bahasa instrumen ke dalam bahasa daerah setempat sering kali diperlukan agar pertanyaan evaluasi dapat dipahami dengan baik oleh klien lansia atau keluarga dengan tingkat literasi kesehatan yang rendah. Pemilihan diksi dan adaptasi kultural pada instrumen evaluasi ini merupakan manifestasi dari asuhan keperawatan yang peka budaya (*culturally competent care*) (Yanti et al, 2024).

8. Kesimpulan (Tantangan dan Ketegasan Metodologis)

Sebagai simpulan, penerapan pendekatan dan metode evaluasi dalam asuhan keperawatan keluarga merupakan proses intelektual yang menuntut ketegasan metodologis sekaligus kepekaan interpersonal perawat. Meskipun perawat dibekali dengan metode kualitatif maupun kuantitatif yang solid, tantangan di lapangan seperti inkonsistensi waktu kunjungan keluarga, resistensi perilaku, hingga keterbatasan instrumen di fasyankes primer sering kali membatasi ruang gerak evaluasi. Oleh karena itu, perawat profesional harus terus melatih ketajaman klinis dan kemampuan berpikir kritisnya agar proses evaluasi dapat tetap berjalan secara akurat, objektif, dan komprehensif demi peningkatan mutu pelayanan keperawatan komunitas secara berkelanjutan (Hasanah, 2025).

D. Dokumentasi Evaluasi Keperawatan

1. Konsep Dasar dan Urgensi Dokumentasi Evaluasi

Dokumentasi evaluasi keperawatan merupakan komponen krusial dan tahap final yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses asuhan keperawatan profesional. Secara konseptual, dokumentasi ini adalah rekam jejak tertulis atau elektronik yang memuat hasil penilaian perawat terhadap perkembangan status kesehatan klien setelah intervensi keperawatan diberikan. Dokumentasi bukan sekadar aktivitas administratif pencatatan, melainkan instrumen ilmiah yang merefleksikan proses berpikir kritis (*critical thinking*) perawat dalam membandingkan antara kondisi faktual klien dengan kriteria hasil yang telah ditetapkan pada fase perencanaan (Setiawan et al, 2022).

Urgensi dari pelaksanaan dokumentasi evaluasi terletak pada fungsinya sebagai alat komunikasi utama antar anggota tim kesehatan interprofesional (dokter, perawat, ahli gizi, dan profesi lainnya). Melalui catatan evaluasi yang akurat dan komprehensif, kontinuitas pelayanan (*continuity of care*) dapat terjamin, mengingat perawat di sisi berikutnya atau tim kesehatan lain dapat mengetahui sejauh mana intervensi sebelumnya berhasil atau gagal. Tanpa adanya dokumentasi evaluasi yang sistematis, asuhan keperawatan akan terfragmentasi, memicu terjadinya repetisi tindakan yang tidak perlu, dan meningkatkan risiko kesalahan medis (*medical error*) (Hidayati & Anwar, 2022).

Selain aspek klinis, dokumentasi evaluasi memiliki kedudukan hukum yang sangat kuat sebagai alat bukti pertanggungjawaban legal dan etik profesional. Dalam yurisprudensi medis, berlaku sebuah adagium universal yakni "*if it is not documented, it is not done*" (jika tidak didokumentasikan, maka tidak pernah dilakukan). Oleh karena itu, catatan evaluasi yang komprehensif berfungsi sebagai tameng pelindung bagi perawat dari potensi tuntutan malpraktik atau kelalaian, karena dokumentasi tersebut membuktikan bahwa perawat telah menjalankan tugasnya sesuai dengan standar operasional prosedur dan standar profesi (Kusuma & Yuliani, 2021).

2. Model Pendokumentasian Evaluasi (Format SOAP)

Model pendokumentasian evaluasi keperawatan yang paling universal dan direkomendasikan secara global adalah format SOAP (*Subjective, Objective, Assessment, Plan*). Format ini memberikan struktur berpikir yang runut dan sistematis bagi perawat dalam merangkum hasil asuhan. Komponen 'S' (Subjektif) berisi data berupa keluhan, pernyataan, atau umpan balik yang diutarakan langsung oleh klien maupun keluarganya setelah menerima intervensi. Data subjektif ini mencerminkan persepsi dan pengalaman

fenomenologis klien terhadap perubahan kondisi kesehatannya secara mandiri (Lestari & Rahman, 2023).

Komponen 'O' (Objektif) merupakan antitesis dari data subjektif, di mana bagian ini memuat data faktual yang diukur, diobservasi, dan diuji secara klinis oleh perawat. Data objektif dalam dokumentasi evaluasi mencakup pengukuran tanda-tanda vital yang presisi, hasil pemeriksaan fisik, pengamatan terhadap perubahan perilaku (misalnya kemampuan klien mendemonstrasikan teknik perawatan secara mandiri), hingga hasil pemeriksaan penunjang laboratorium terbaru. Validitas data objektif sangat esensial karena menjadi bukti empiris dari efektivitas asuhan yang tidak dapat dibantah secara ilmiah (Wibowo et al., 2025).

Selanjutnya, komponen 'A' (*Assessment* atau Analisis) adalah inti dari proses evaluasi itu sendiri. Pada tahap ini, perawat melakukan sintesis kognitif dengan cara membandingkan kolaborasi data subjektif dan objektif dengan kriteria hasil atau Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI) yang telah ditargetkan. Analisis ini akan menghasilkan tiga kemungkinan konklusi diagnostik, yaitu: masalah keperawatan teratasi seluruhnya (apabila klien memenuhi semua kriteria hasil), masalah teratasi sebagian (apabila hanya beberapa indikator yang tercapai), atau masalah belum teratasi (apabila tidak ada kemajuan atau justru terjadi perburukan klinis) (PPNI, 2021).

Komponen terakhir adalah 'P' (*Plan* atau Perencanaan tindak lanjut), yang dirumuskan secara langsung berdasarkan konklusi pada komponen Analisis. Apabila masalah dinyatakan teratasi, maka perencanaannya adalah terminasi asuhan atau pemulangan pasien (*discharge planning*). Namun, jika masalah baru teratasi sebagian atau belum teratasi, perawat harus mendokumentasikan modifikasi rencana tindakan; apakah perlu meningkatkan intensitas intervensi, merombak strategi edukasi, atau melakukan kolaborasi rujukan dengan disiplin ilmu kesehatan lain guna mengatasi hambatan pemulihan klien (Supriyadi & Yuliani, 2021).

3. Varian Model Dokumentasi (SOAPIER dan DAR)

Seiring dengan kompleksitas pelayanan kesehatan, format SOAP sering kali diekspansi menjadi SOAPIER (*Subjective, Objective, Assessment, Plan, Intervention, Evaluation, Revision*). Penambahan komponen Intervensi (I), Evaluasi lanjutan (E), dan Revisi (R) memberikan ruang pencatatan yang lebih mendetail, terutama untuk pasien di area perawatan intensif atau pasien dengan penyakit kronis komorbid. Revisi (R) secara spesifik mendokumentasikan modifikasi intervensi *real-time* yang dilakukan segera setelah evaluasi awal

menunjukkan ketidakefektifan tindakan, sehingga intervensi keperawatan bersifat jauh lebih responsif dan dinamis (Nugroho & Putra, 2022).

Selain SOAPIER, model dokumentasi evaluasi lain yang kerap diaplikasikan adalah *Focus Charting* atau format DAR (*Data, Action, Response*). Format DAR lebih berorientasi pada fokus masalah spesifik alih-alih berpusat pada diagnosis medis. Bagian 'Data' memuat pengkajian kondisi klien, 'Action' mendeskripsikan tindakan keperawatan yang telah dieksekusi, dan 'Response' merupakan representasi langsung dari evaluasi itu sendiri. Evaluasi pada komponen *Response* ini menuntut perawat untuk mencatat reaksi fisiologis dan psikologis klien seketika sesudah tindakan dilakukan, menjadikannya sangat efektif untuk evaluasi formatif jangka pendek (Firmansyah & Kusnanto, 2024).

4. Prinsip-prinsip Penulisan Dokumentasi

Kualitas sebuah dokumentasi evaluasi keperawatan ditentukan oleh kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip penulisan ilmiah standar, yang mencakup aspek keakuratan, keringkasan, objektivitas, dan keterkinian. Dokumentasi harus bersifat faktual, yang berarti perawat dilarang keras mencantumkan opini, asumsi, atau interpretasi subjektif yang tidak dilandasi oleh data klinis. Penggunaan diksi yang ambigu seperti "kondisi pasien membaik" harus dihindari dan diganti dengan deskripsi empiris yang terukur, misalnya "tekanan darah turun menjadi 130/80 mmHg dan pasien menyatakan pusing berkurang" (Siregar & Harahap, 2025).

Selain itu, keterkinian (*timeliness*) merupakan prinsip mutlak dalam pendokumentasian. Evaluasi harus dicatat sesegera mungkin (real-time) setelah intervensi selesai dilakukan atau setelah observasi dilakukan, guna mencegah fenomena hilangnya informasi akibat kelupaan (*recall bias*). Dokumentasi yang ditunda hingga akhir sif memiliki risiko tinggi terhadap inakurasi data dan berpotensi membahayakan pengambilan keputusan klinis oleh tenaga kesehatan yang menggantikan tugas jaga pada sif berikutnya (Andriyani & Wijaksana, 2023).

5. Transisi Menuju Dokumentasi Keperawatan Elektronik

Di era disrupsi teknologi digital saat ini, praktik dokumentasi evaluasi keperawatan sedang mengalami transisi masif dari sistem berbasis kertas (*paper-based*) menuju *Electronic Health Records* (EHR) atau Rekam Medis Elektronik (RME). Sistem EHR menyediakan templat dokumentasi yang terstandarisasi, mengintegrasikan data dari berbagai departemen secara sentralistik, dan dilengkapi dengan fitur *Clinical Decision Support System*

(CDSS). Penggunaan EHR secara signifikan meningkatkan efisiensi waktu perawat dalam menulis evaluasi dan meminimalisasi kesalahan baca (*illegibility*) yang sering terjadi pada tulisan tangan manual (Pratama & Sari, 2024).

Meskipun menawarkan efisiensi tinggi, implementasi EHR juga membawa tantangan adaptif yang tidak ringan bagi profesi keperawatan. Perawat dituntut untuk memiliki literasi digital yang mumpuni agar dapat menavigasi perangkat lunak rekam medis tanpa mengabaikan kontak mata dan interaksi terapeutik dengan klien di ranjang perawatan. Evaluasi keperawatan yang didokumentasikan melalui perangkat elektronik harus tetap mempertahankan aspek *caring* dan *human touch*, menghindari kecenderungan *copy paste* mekanis yang dapat menghilangkan kekayaan narasi kondisi individual setiap pasien (Hasanah, 2025).

6. Audit dan Jaminan Mutu Dokumentasi Evaluasi

Untuk memastikan standar asuhan keperawatan senantiasa terjaga, dokumentasi evaluasi tidak luput dari proses audit rekam medis yang dilakukan secara periodik oleh komite keperawatan di instansi layanan kesehatan. Audit ini berfungsi sebagai mekanisme jaminan mutu (*quality assurance*) yang mengevaluasi kelengkapan, kepatuhan terhadap format standar (seperti SLKI), serta koherensi antara diagnosis, intervensi, dan hasil evaluasi. Temuan dari audit rekam medis ini kemudian dijadikan dasar empiris bagi manajemen rumah sakit maupun puskesmas untuk menyusun program pelatihan berkelanjutan bagi staf keperawatan (Wijayanti & Lestari, 2024).

Sebagai simpulan komprehensif, dokumentasi evaluasi keperawatan adalah fondasi dari akuntabilitas profesional perawat. Melalui catatan evaluasi yang presisi, sistematis, dan terstandar, perawat tidak hanya sedang menunaikan kewajiban administratif, melainkan sedang memvalidasi kontribusi keperawatan terhadap perbaikan kualitas hidup pasien. Pemahaman mendalam dan penerapan disiplin dalam mendokumentasikan hasil asuhan merupakan indikator tak terbantahkan dari profesionalisme seorang perawat di segala tatanan layanan kesehatan (Setiawan et al, 2022).

E. Tantangan dalam Evaluasi Asuhan Keperawatan Keluarga

1. Pendahuluan (Kompleksitas Evaluasi Berbasis Keluarga)

Proses evaluasi dalam tatanan asuhan keperawatan keluarga memiliki tingkat kompleksitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan evaluasi asuhan keperawatan individu di ranah klinis rumah sakit. Kompleksitas ini bersumber dari karakteristik unit keluarga sebagai sebuah sistem sosial terbuka

yang sangat dinamis, heterogen, dan rentan terhadap berbagai determinan eksternal maupun internal. Dalam mengevaluasi keberhasilan intervensi, perawat tidak hanya dihadapkan pada indikator perbaikan patofisiologis satu individu, melainkan harus mengukur transformasi perilaku kolektif, interaksi emosional, dan restrukturisasi peran dari seluruh anggota keluarga yang terlibat (Kusnanto & Firmansyah, 2022).

Tantangan menjadi semakin manifes ketika perawat berupaya mengukur pencapaian lima tugas kesehatan keluarga yang merupakan standar otonomi kesehatan komunitas. Kegagalan adaptasi keluarga terhadap satu tugas sering kali memicu efek domino yang menggagalkan pencapaian tugas lainnya, sehingga hasil evaluasi kerap menunjukkan fluktuasi yang tidak linear. Oleh karena itu, perawat komunitas dituntut untuk memahami secara komprehensif berbagai variabel pengganggu (*confounding variables*) yang menjadi akar dari tantangan evaluasi di lapangan, agar dapat menyusun strategi modifikasi asuhan yang tepat guna (Susanto & Widyawati, 2021).

2. Hambatan Sosio Kultural Keyakinan Tradisional

Salah satu tantangan paling persisten dalam evaluasi keperawatan keluarga di Indonesia adalah kuatnya pengaruh sosio kultural dan sistem keyakinan tradisional (*traditional belief system*) terhadap pengambilan keputusan kesehatan. Banyak keluarga, terutama di kawasan rural atau semi urban, masih mempertahankan paradigma etnomedisin yang menganggap penyakit kronis sebagai akibat dari gangguan supranatural atau ketidakseimbangan kosmis, alih-alih proses biomedis. Keyakinan semacam ini sering kali terdeteksi pada tahap evaluasi kognitif, di mana keluarga menolak atau meragukan rasionalisasi medis yang telah diedukasikan oleh perawat, sehingga tujuan asuhan keperawatan gagal tercapai secara optimal (Yanti et al, 2024).

Benturan budaya ini menciptakan dilema etis dan metodologis bagi perawat saat melakukan evaluasi pelaksanaan tugas kesehatan keluarga. Misalnya, ketika perawat mengevaluasi kepatuhan farmakologis (kepatuhan minum obat), sering ditemukan bahwa keluarga secara sepihak telah mengganti obat medis dengan ramuan herbal yang belum teruji secara klinis (Saintifik Jamu yang belum terstandarisasi). Penolakan kultural ini menuntut perawat untuk tidak bersikap menghakimi (*non judgemental*), melainkan menggunakan pendekatan negosiasi budaya (*cultural care accommodation*) agar evaluasi tetap dapat memfasilitasi titik temu antara kearifan lokal dan keselamatan medis (Wibowo et al, 2022).

3. Keterbatasan Literasi Kesehatan Keluarga

Tantangan berikutnya yang sangat memengaruhi validitas hasil evaluasi adalah rendahnya tingkat literasi kesehatan (*health literacy*) di kalangan masyarakat. Literasi kesehatan tidak sekadar diartikan sebagai kemampuan membaca atau menulis, melainkan kapasitas kognitif keluarga dalam memperoleh, memproses, dan memahami informasi kesehatan dasar untuk mengambil keputusan yang berlandaskan bukti. Keluarga dengan literasi kesehatan yang marjinal cenderung mengalami kesulitan dalam memahami instruksi evaluasi yang diberikan, gagal mengenali gejala perburukan (*red flags*), dan tidak mampu membaca label peringatan pada kemasan obat (Pratama & Sari, 2024).

Dampak dari rendahnya literasi kesehatan ini sangat terasa saat perawat mengevaluasi ranah psikomotorik dan kognitif keluarga. Evaluasi formatif kerap menunjukkan bahwa keluarga salah dalam menginterpretasikan dosis pengobatan atau gagal mendemonstrasikan teknik perawatan dasar (seperti perawatan luka diabetik) karena instruksi verbal sebelumnya tidak dapat diserap secara konseptual. Situasi ini memaksa perawat untuk berulang kali memodifikasi alat evaluasi menggunakan media visual yang sangat disederhanakan, yang tentunya memperpanjang durasi waktu asuhan dan menguras sumber daya keperawatan di fasilitas kesehatan primer (Lestari & Rahman, 2023).

4. Dinamika Internal dan Konflik Peran dalam Keluarga

Keluarga bukanlah sebuah entitas yang selalu harmonis; dinamika internal dan relasi kekuasaan (*power relations*) antar-anggota keluarga sering kali menjadi kendala tak kasat mata dalam proses evaluasi asuhan. Konflik peran, terutama hilangnya figur pembuat keputusan (*decision maker*) yang definitif, dapat menyebabkan stagnasi dalam manajemen kesehatan pasien. Evaluasi pencapaian tugas mengambil keputusan medis sering kali terkendala oleh adanya perselisihan pendapat antara pasangan suami-istri atau antara anak-anak yang telah dewasa mengenai metode perawatan mana yang harus dipilih atau siapa yang bertanggung jawab membiayai perawatan tersebut (Andriyani & Wijaksana, 2023).

Selain itu, tantangan psikologis berupa *caregiver burden* atau kelelahan pengasuh utama memberikan dampak destruktif terhadap hasil evaluasi asuhan berkelanjutan. Saat mengevaluasi kemampuan merawat anggota keluarga yang sakit kronis (seperti stroke atau demensia), perawat sering kali menemukan bahwa *caregiver* mengalami depresi, kelelahan fisik ekstrem, hingga isolasi

sosial. Kondisi keletihan ini menyebabkan menurunnya kualitas perawatan yang diberikan di rumah, sehingga hasil evaluasi objektif klien (misalnya status nutrisi atau kebersihan diri) mengalami perburukan meskipun intervensi edukasi telah diberikan secara komprehensif (Hasanah, 2025).

5. Kendala Sosioekonomi dan Modifikasi Lingkungan Fisik

Variabel determinan sosial ekonomi merupakan rintangan struktural yang paling sulit dimodifikasi oleh perawat dalam waktu singkat. Ketidakstabilan finansial atau status ekonomi menengah ke bawah secara langsung menggagalkan upaya pencapaian target evaluasi terkait kepatuhan diet dan penciptaan lingkungan terapeutik. Sebagai contoh, evaluasi terkait kemampuan keluarga menyajikan diet rendah purin atau rendah natrium sering kali gagal bukan karena keluarga tidak memahami teorinya, melainkan karena ketidakmampuan daya beli keluarga terhadap bahan pangan spesifik yang disarankan (Nugroho & Putra, 2022).

Kondisi ekonomi ini berkorelasi linear dengan ketidakmampuan keluarga dalam memodifikasi lingkungan fisik yang sehat dan aman. Ketika perawat mengevaluasi tugas kesehatan keluarga yang keempat (memodifikasi lingkungan), perumahan yang padat penduduk, sanitasi yang buruk, ventilasi yang tidak memadai, serta ketiadaan ruang isolasi bagi penderita penyakit menular komunal (seperti Tuberkulosis) menjadi hambatan absolut. Dalam konteks ini, perawat menyadari bahwa hasil evaluasi yang buruk pada asuhan keperawatan keluarga sesungguhnya adalah manifestasi dari kegagalan sistemik terkait distribusi kesejahteraan sosial di masyarakat (Setiawan et al, 2022).

6. Tantangan Metodologis bagi Profesi Keperawatan

Dari perspektif penyedia layanan (*provider*), perawat juga menghadapi hambatan metodologis dan operasional saat melakukan evaluasi di tatanan komunitas. Tingginya beban kerja perawat di Puskesmas akibat rasio perawat-klien yang tidak seimbang menyebabkan keterbatasan alokasi waktu untuk melakukan evaluasi kunjungan rumah (*home visit*) secara mendalam. Akibatnya, dokumentasi evaluasi sering kali dibuat secara dangkal, tidak mencerminkan eksplorasi fenomenologis keluarga secara utuh, dan lebih berorientasi pada penyelesaian target administratif kuantitatif semata (Hidayati & Anwar, 2022).

Selanjutnya, ketiadaan instrumen pengumpulan data yang tervalidasi lintas budaya untuk populasi pedesaan terpencil menyulitkan objektivitas penilaian. Perawat terkadang harus menggunakan instrumen evaluasi berbahasa

Indonesia baku yang terminologinya sulit dipahami oleh keluarga dengan latar belakang bahasa ibu (daerah) yang kental. Hal ini menimbulkan bias pengukuran, di mana data respons yang didokumentasikan dalam rekam medis tidak merepresentasikan kondisi aktual dan kemampuan literasi sejati dari keluarga binaan tersebut (PPNI, 2021).

7. Hambatan Geografis dan Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan

Evaluasi terkait kemampuan keluarga memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) sering kali terbentur oleh disparitas akses geografis dan infrastruktur transportasi. Bagi keluarga yang bermukim di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), jarak fisik antara rumah dengan klinik kesehatan atau rumah sakit rujukan menjadi faktor penghambat utama yang menyebabkan ketidakpatuhan kunjungan medis. Evaluasi yang menyimpulkan bahwa "keluarga tidak patuh" atau "kurang kooperatif" sering kali tidak adil karena mengabaikan konteks struktural berupa biaya transportasi yang mahal dan medan jalan yang ekstrem (Wijayanti, 2024).

Selain jarak fisik, sistem rujukan berjenjang pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang kompleks terkadang membingungkan keluarga, memicu keengganan mereka untuk berurusan dengan birokrasi layanan kesehatan. Hal ini memunculkan tantangan baru dalam proses evaluasi asuhan keperawatan keluarga, karena perawat harus mengambil peran tambahan sebagai navigator sistem kesehatan (*health system navigator*) atau advokat bagi keluarga untuk menjembatani kesenjangan akses tersebut, sebelum tujuan akhir asuhan dapat benar-benar dievaluasi keberhasilannya (Kusuma & Yuliani, 2021).

8. Strategi Mengatasi Tantangan Evaluasi Keperawatan Keluarga

Menghadapi konstelasi tantangan tersebut, profesi keperawatan perlu mengadopsi pendekatan holistik berbasis pemberdayaan (*empowerment*) dan kolaborasi interprofesional. Untuk mengatasi hambatan kultural dan literasi, perawat harus memodifikasi instrumen evaluasi menjadi pendekatan naratif-partisipatif yang menggabungkan bahasa lokal dengan media audiovisual sederhana. Selain itu, optimalisasi peran kader kesehatan desa (*community health workers*) sebagai mitra kolaborasi perawat dapat memperpanjang jangkauan pemantauan evaluasi secara kultural dan mengatasi krisis kekurangan sumber daya keperawatan di layanan primer (Siregar & Harahap, 2025).

Sebagai kesimpulan konseptual, tantangan dalam proses evaluasi asuhan keperawatan keluarga tidak boleh dipandang sekadar sebagai titik kegagalan,

melainkan harus dikonstruksikan sebagai katalis umpan balik kritis untuk inovasi keperawatan komunitas. Mengidentifikasi masalah sosiokultural, ekonomi, dan psikodinamika yang mengakar di keluarga memaksa perawat untuk bergeser dari asuhan mekanistik menuju seni keperawatan yang penuh empati dan peka konteks (*context-sensitive care*). Pada akhirnya, penanganan tantangan ini secara komprehensif akan mempercepat transisi keluarga menuju otonomi kesehatan dan resiliensi sistem yang sejati (Kemenkes RI, 2023).

F. Simpulan

Evaluasi asuhan keperawatan keluarga merupakan tahapan sistematis dan berkesinambungan yang berfungsi sebagai mekanisme umpan balik untuk mengukur pencapaian kemandirian keluarga dalam mengelola status kesehatan mereka. Melalui pendekatan formatif dan sumatif, perawat melakukan penilaian holistik pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang disintesis berdasarkan kemampuan keluarga dalam menjalankan lima tugas kesehatan keluarga. Proses ini menuntut ketajaman analisis perawat dalam menghadapi berbagai tantangan kompleks, seperti hambatan sosiokultural, literasi kesehatan yang rendah, hingga dinamika internal keluarga, guna menghasilkan dokumentasi yang akuntabel secara legal melalui format terstandarisasi seperti SOAP atau SLKI. Secara strategis, keberhasilan evaluasi yang didukung oleh metodologi triangulasi dan kolaborasi interprofesional akan memfasilitasi transisi paradigma menuju *family centered care* yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

G. Referensi

- Andriyani, S., & Wijaksana, A. (2023). Triangulasi Metode Pengumpulan Data dalam Penilaian Kesehatan Komunitas dan Keluarga. *Jurnal Keperawatan Komprehensif Nasional*, 11(2), 145-156.
- Firmansyah, A., & Kusnanto, H. (2024). Evaluasi Kognitif Keluarga dalam Pengenalan Masalah Kesehatan Kronis. *Jurnal Keperawatan Profesional*, 12(2), 112-120.
- Hasanah, U. (2025). Tantangan Etik dan Interaksi Terapeutik dalam Penggunaan Rekam Medis Elektronik oleh Perawat. *Indonesian Journal of Nursing Analytics*, 8(3), 200-215.
- Hidayati, R., & Anwar, S. (2022). Objektivitas Pengukuran dalam Asuhan Keperawatan Komunitas. *Jurnal Praktik Keperawatan Profesional*, 10(3), 200-212.
- Kemenkes RI. (2023). Panduan Penggunaan Instrumen Evaluasi pada Perawatan

- Kesehatan Masyarakat (Perkesmas). Jakarta: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI.
- Kusnanto, H., & Firmansyah, A. (2022). Kompleksitas Asuhan Keperawatan Sistem Keluarga Terbuka. *Jurnal Keperawatan Profesional*, 10(1), 22-35.
- Kusuma, A., & Yuliani, R. (2021). Aspek Legal, Akuntabilitas, dan Etik dalam Dokumentasi Asuhan Keperawatan Komprehensif. *Jurnal Keperawatan Klinis dan Hukum*, 9(4), 310-322.
- Lestari, D., & Rahman, A. (2023). Mengukur Transisi Kemandirian Keluarga dalam Manajemen Penyakit Kronis Berbasis Komunitas. *Jurnal Keperawatan Komunitas Indonesia*, 14(3), 210-222.
- Mahendra, Y. (2026). Berpikir Kritis dalam Perumusan Rencana Tindak Lanjut Asuhan Keperawatan Keluarga. *Indonesian Journal of Nursing Analytics*, 5(1), 34-45.
- Nugroho, T., & Putra, R. (2022). Determinan Sosial Ekonomi dalam Kemandirian Manajemen Penyakit Tidak Menular pada Keluarga. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Epidemiologis*, 12(4), 175-188.
- PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia). (2021). Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan (Edisi 1). Jakarta: DPP PPNI.
- Pratama, B., & Sari, I. P. (2024). Dinamika Evaluasi Afektif: Studi Fenomenologi Dukungan Emosional Keluarga pada Pasien Paliatif. *Jurnal Psikologi dan Keperawatan Klinis*, 12(4), 301-315.
- Rahmawati, I., & Suryani, L. (2022). Indikator Evaluasi Asuhan Keperawatan Komunitas dan Keluarga. *Jurnal Ilmu Keperawatan Komunitas*, 8(1), 45-56.
- Setiawan, M., Susilo, A., & Permana, R. (2022). Buku Ajar Keperawatan Keluarga: Konsep Dasar, Asuhan, dan Evaluasi. Bandung: Refika Aditama.
- Siregar, F. A., & Harahap, J. (2025). Kemitraan Perawat dan Kader Kesehatan dalam Optimalisasi Evaluasi Asuhan Komunitas. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat dan Keperawatan*, 13(1), 112-124.
- Supriyadi, E., & Yuliani, R. (2021). Signifikansi Evaluasi Formatif dalam Membentuk Perilaku Sehat Keluarga Perkotaan. *Jurnal Riset Keperawatan*, 8(3), 190-201.
- Susanto, T., & Widyawati. (2021). Keperawatan Keluarga: Pendekatan Berbasis Bukti dan Metodologi Intervensi. Jakarta: EGC.
- Wibowo, A., Susanti, E., & Putra, R. (2022). Analisis Keberhasilan Evaluasi Sumatif pada Asuhan Keperawatan Pasien Pasca Stroke di Tatanan Keluarga. *Jurnal Rehabilitasi Medis dan Keperawatan*, 7(2), 88-99.
- Widjaja, K., & Lestari, D. (2023). Kemandirian Keluarga dalam Kedaruratan Medis dan Pengambilan Keputusan. *Jurnal Keperawatan Klinis*, 10(4), 310-322.
- Wijayanti, L., & Kusnanto, H. (2024). Hambatan Sosiokultural dalam Pelaksanaan

Evaluasi Keperawatan Keluarga di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Kesehatan*, 15(1), 40-52.

Yanti, N., Harahap, J., & Siregar, M. (2024). Optimalisasi Lima Tugas Kesehatan Dasar sebagai Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Keluarga. *Jurnal Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat Cendekia*, 13(2), 175-188.

H. Glosarium

CDSS = *Clinical Decision Support System*

DAR = *Data, Action, Response*

HER = *Electronic Health Records*

IMT = Indeks Massa Tubuh

JKN = Jaminan Kesehatan Nasional

MMAS = *Morisky Medication Adherence Scale*

SLKI = Standar Luaran Keperawatan Indonesia

SOAP = Subjektif, Objektif, Analisis, *Planning*

SOAPIER = *Subjective, Objective, Assessment, Plan, Intervention, Evaluation, Revision*

UGD = Unit Gawat Darurat

PROFIL PENULIS



Noor Rochmah Ida Ayu Trisno Putri., S.Kep.Ns., M.Kep. Lahir di Yogyakarta, 19 Januari 1990. Pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 dan Ners pada Program Studi Keperawatan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2017. Saat ini bekerja di Universitas Harapan Bangsa dan memiliki pengalaman sebagai pengajar Keperawatan Keluarga, Keperawatan Komunitas, dan Keperawatan Gerontik. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan sebagai reviewer di berbagai jurnal. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: idaayutrisno@gmail.com



Rizqy Iftitah Alam, S.Kep, Ns, M.Kes. Lahir di Makassar, 02 September 1990. Telah menyelesaikan pendidikan Strata 1 pada program studi Ilmu Keperawatan di Universitas Muslim Indonesia, Makassar (tahun 2008-2012). Kemudian, melanjutkan pendidikan Profesi Ners di Universitas Mega Rezky Makassar (2012-2014). Selanjutnya, kembali melanjutkan pendidikan Magister pada program studi Magister Kesehatan di Universitas Muslim Indonesia (2014-2016). Saat ini sedang menempuh pendidikan Doktor Ilmu Keperawatan di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia sejak tahun 2024 (hingga saat ini). Pernah bekerja sebagai Perawat Pelaksana di RS Ibnu Sina Makassar (2014-2016). Saat ini penulis bekerja sebagai seorang Dosen di program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Muslim Indonesia sejak tahun 2016 hingga saat ini dan mengampu mata kuliah Keperawatan Keluarga. Penulis aktif dalam melaksanakan berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, melaksanakan penelitian, kegiatan pengabdian pada masyarakat, serta mengikuti berbagai kegiatan ilmiah seperti seminar, workshop, maupun pelatihan yang dapat menunjang penulis. Penulis dapat dihubungi melalui email : qkyiftitah90@gmail.com.

PROFIL PENULIS



Barto Mansyah, S.Pd.,MH. Lahir di Muara Montallat, 17 Agustus 1963. Pendidikan Tinggi yang ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D III pada AKPER Depkes Otten Bandung lulus tahun 1988. Kemudian melanjutkan S1 pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Palangka Raya tahun 2000. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Brawijaya lulus pada tahun 2007. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1985 PNS sebagai tenaga Pembantu Paramedis di Puskesmas Kalampangan Palangka Raya. Tahun 1988 bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Palangka Raya. Tahun 1994 bekerja di Sekolah Perawat Kesehatan Depkes Palangka Raya. Kemudian tahun 2001 sampai sekarang bekerja di Poltekkes Kemenkes Palangka Raya sebagai dosen. Mata kuliah yang diampu adalah Keperawatan Keluarga. Penulis aktif publikasi ke jurnal nasional dan internasional juga mengikuti seminar-seminar lokal, regional, nasional dan internasional

PROFIL PENULIS



Syaiful, S.Pd., S.Kep., Ns., M.Pd., M.Kes., lahir di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, pada 23 Mei 1968. Penulis merupakan dosen keperawatan pada Poltekkes Kemenkes Mataram dengan jabatan akademik Lektor Kepala. Penulis memiliki pengalaman panjang hampir empat dekade dalam pendidikan keperawatan, pengembangan akademik, dan pengabdian kepada masyarakat. Sejak tahun 2000, penulis mengabdikan diri di Program Studi Keperawatan Bima yang sebelumnya berada di bawah Akper Depkes Mataram dan kini menjadi bagian dari Poltekkes Kemenkes Mataram.

Pendidikan tinggi penulis ditempuh pada Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya dan lulus tahun 2002. Penulis kemudian menyelesaikan pendidikan magister di Universitas Adibuana Surabaya dengan gelar M.Pd. pada tahun 2009, serta memperoleh gelar M.Kes. dari Universitas Badaruddin Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, pada tahun 2023.

Dalam kegiatan akademik, penulis mengampu mata kuliah Metodologi Penelitian, Konsep Dasar Keperawatan, Manajemen Keperawatan, Keperawatan Jiwa, serta Keperawatan Keluarga dan Komunitas. Bidang minat akademik penulis berfokus pada keperawatan komunitas, promosi kesehatan, pemberdayaan keluarga dan masyarakat, serta penguatan peran perawat dalam pencegahan penyakit berbasis lingkungan dan perilaku.

Relevansi kepakaran penulis tampak dalam pembahasan diagnosis keperawatan keluarga pada keluarga dengan anggota yang menderita hipertensi. Melalui perspektif keperawatan keluarga dan komunitas, penulis menekankan pentingnya pengkajian keluarga secara komprehensif, penetapan diagnosis keperawatan yang tepat, edukasi gaya hidup sehat, dukungan kepatuhan pengobatan, penguatan fungsi perawatan kesehatan keluarga, serta kolaborasi keluarga dengan pelayanan kesehatan primer untuk mencegah komplikasi hipertensi.

Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, antara lain penulisan buku, publikasi ilmiah, kegiatan seminar dan workshop sebagai narasumber serta pengabdian kepada masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui email: syaiful6823mpd@gmail.com.

Motto: *Diagnosis yang tepat adalah awal dari asuhan yang bermakna; keluarga yang berdaya adalah kunci pengendalian hipertensi.*

PROFIL PENULIS



Ns. Prima Trisna Aji, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.MB. Lahir di kota Surakarta pada tanggal 22 Maret 1987 di kota Surakarta, Jawa Tengah. Menjalani pendidikan D3 di Akper Panti Kosala Surakarta lulus pada tahun 2007, kemudian melanjutkan S1 di Universitas Muhammadiyah Surakarta lulus pada tahun 2009, kemudian melanjutkan sekolah Profesi di Universitas Muhammadiyah Surakarta dan lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 di UMY Yogyakarta dan lulus pada tahun 2017.

Kemudian melanjutkan Pendidikan Spesialis KMB di Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan spesialisasi Jantung dan Pembuluh darah dan lulus pada tahun 2022. Pernah bekerja di Rumah Sakit Khusus Bedah Diponegoro Klaten dibangsal dan Kamar Operasi sebagai asisten bedah (2008), Rumah Sakit Cakra Husada Klaten di ruang IGD (2010), menjadi Dosen tetap Akper Mambaul Ulum Surakarta (2012), STIKES Mambaul Ulum Surakarta sebagai kepala BAAK (2014), Universitas Kusuma Husada Surakarta (2019), Dosen tetap Poltekkes Kemenkes Surakarta (2019) dan mengajar di Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon (2023), menjadi Dosen di Universitas Muhammadiyah Purwokerto (2022) dan saat ini menjadi Dosen prodi Spesialis Medikal Bedah di Universitas Muhammadiyah Semarang (2025). Prestasi Prima Trisna Aji pernah menjadi pembicara seminar tindakan mandiri keperawatan nasional di kota Solo dan sekitarnya dari tahun 2015 - 2019, Kuliah Pakar, pembicara di Guangxi Medical University China (2016). Prestasi Juara 1 Opini terbaik Surat Kabar di Solo Raya (2022), Volunter berdedikasi di ASEAN PARAGAMES tahun 2022, Juara 2 Lomba Video Pertolongan Pertama Henti Jantung Hipgabi Jawa Timur, Juara Harapan Lomba Video Pertolongan Pertama di Kejuaran Optimal, Juara Harapan 2 Lomba Artikel Ilmiah dosen se Indonesia di OPTIMAL, Best Papper Presenter Award ICHAS Seminar Internasional Malaysia (2025) dan Juara Penulis Terbaik Nasional 1 Lomba Astero Indonesia (2026). Dan saat ini sedang menjalani studi lanjut S3 PhD Doctor Of Philosophy in Nursing di Lincoln College University Malaysia. Penulis juga memiliki karya tulis baik Book Chapter, Buku Ajar, Buku referensi, Buku monograf dan karya lainnya yang sudah terpublikasi baik penerbit nasional ataupun penerbit internasional. Email Penulis: primatrisnaaji@unimus.ac.id

PROFIL PENULIS



Antonius Yogi Pratama, S.Kep.,Ns.,MSN. lahir di Wonogiri pada 27 Desember 1990. Penulis menempuh pendidikan S1 Keperawatan di STIKES Bethesda Yakkum Yogyakarta dan Magister Keperawatan dengan Spesialisasi Keperawatan Kesehatan Komunitas di St.Paul University Manila, Filipina. Penulis merupakan Dosen di STIKES Bethesda Yakkum Yogyakarta. Bidang Studi yang diampu diantaranya: Keperawatan Komunitas dan Keluarga, Promosi Kesehatan, Sistem Informasi

Keperawatan, *Entrepreneuership* dan Antropologi dan Sosiologi Kesehatan. Penulis aktif dalam melakukan Penelitian dan juga Pengabdian kepada Masyarakat yang didanai oleh internal perguruan tinggi maupun Kemenristek DIKTI. Penelitian berfokus pada Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak menular. Salah satu penelitian yang telah dilakukan berjudul: "Strategi pemberdayaan kader dengan inovasi *ginger hot pack* untuk menurunkan tekanan darah dan kolesterol". Sedangkan, pengabdian kepada masyarakat penulis terlibat dalam Program Institusi maupun Pemerintah daerah. Salah satunya adalah penanganan Covid-19, sebagai vaksinator, pembentuk Satgas Covid tingkat RT dan juga penyuluh bagi masyarakat.

Penulis aktif menulis buku sejak tahun 2021 dengan judul pertama: "Kewirusahaan untuk mahasiswa kesehatan". Pada tahun 2023 menulis pada Book Chapter Digital: Konsep Dan Aplikasi Dokumentasi Keperawatan Berbasis Digital tentang Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi. 2025 Menulis Pengembangan Nanoteknologi dalam Pengembangan Obat dan Pemberian Obat dalam Keperawatan dan Transformasi Posyandu di Era Digital. Penulis tertarik Menulis Book Chapter ini sebagai pengembangan diri dan kontribusi akademisi dalam perkembangan teknologi berbasis digital. Penulis akan terus mengembangkan diri untuk menjadi pendidik yang berguna baik untuk dunia pendidikan maupun masyarakat secara umum.

Email Penulis: yogi@stikesbethesda.ac.id

PROFIL PENULIS



Dr. Prasanti Adriani, S.SiT., S.Kep., Ns., M.Kes. lahir dan tinggal di Purbalingga, Jawa Tengah. Menyelesaikan studi dasar sampai menengah di kampung halaman. Alumni Magister Promosi Kesehatan Universitas Diponegoro (UNDIP) Tahun 2014 dan menyelesaikan studi Doktoral di Universitas Sebelas Maret (UNS) Tahun 2026. Penulis aktif sebagai dosen Keperawatan Universitas Harapan Bangsa, menulis buku, melaksanakan pengabdian masyarakat, penelitian, menulis artikel ilmiah dan sebagai reviewer jurnal Scopus. Email: pra.adriani@gmail.com.

Sinopsis

Bunga Rampai "Asuhan Keperawatan Keluarga pada Keluarga dengan Anggota yang Menderita Hipertensi" membahas secara komprehensif konsep, proses, dan implementasi asuhan keperawatan keluarga dalam pengelolaan hipertensi. Buku ini diawali dengan pembahasan mengenai konsep dasar keperawatan keluarga, meliputi pengertian keluarga, konsep keperawatan keluarga, prinsip dan pendekatan keperawatan keluarga, serta peran perawat dalam mendukung kesehatan keluarga. Selanjutnya, buku ini menguraikan tugas kesehatan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang mengalami hipertensi, termasuk konsep hipertensi, pendekatan evidence-based practice, strategi pemberdayaan keluarga, serta berbagai hambatan yang dihadapi keluarga dalam pengendalian tekanan darah.

Pembahasan dalam buku ini juga menitikberatkan pada proses keperawatan keluarga, dimulai dari pengkajian keperawatan keluarga pada masalah hipertensi. Materi yang disajikan meliputi pengkajian kondisi anggota keluarga dengan hipertensi, pemantauan tekanan darah di rumah, pola makan, aktivitas fisik, kebiasaan harian, lingkungan rumah, dukungan sosial, hingga identifikasi masalah berdasarkan hasil pengkajian. Buku ini juga menguraikan diagnosis keperawatan keluarga yang sering muncul, penentuan prioritas diagnosis, integrasi SDKI-SLKI-SIKI dengan NANDA-I, NOC, dan NIC, serta berbagai kesalahan yang sering terjadi dalam penegakan diagnosis keperawatan keluarga.

Selain itu, buku ini menyajikan berbagai intervensi edukasi yang aplikatif, seperti edukasi diet, aktivitas fisik, kepatuhan minum obat, dan pemantauan tekanan darah sebagai bagian penting dalam pengelolaan hipertensi berbasis keluarga. Pembahasan diperkuat dengan konsep pemberdayaan keluarga dalam pengambilan keputusan dan pencegahan komplikasi hipertensi, serta strategi perawat dalam memfasilitasi keluarga agar mampu menjalankan tugas kesehatan secara optimal. Pada bagian akhir, buku ini membahas evaluasi hasil asuhan keperawatan keluarga, metode evaluasi, dokumentasi keperawatan, dan tantangan dalam evaluasi pelayanan keluarga. Buku ini sangat relevan bagi mahasiswa keperawatan, dosen, perawat komunitas, tenaga kesehatan, dan pemerhati kesehatan keluarga sebagai referensi dalam meningkatkan kualitas asuhan keperawatan keluarga pada masalah hipertensi.

Bunga Rampai “Asuhan Keperawatan Keluarga pada Keluarga dengan Anggota yang Menderita Hipertensi” membahas secara komprehensif konsep, proses, dan implementasi asuhan keperawatan keluarga dalam pengelolaan hipertensi. Buku ini diawali dengan pembahasan mengenai konsep dasar keperawatan keluarga, meliputi pengertian keluarga, konsep keperawatan keluarga, prinsip dan pendekatan keperawatan keluarga, serta peran perawat dalam mendukung kesehatan keluarga. Selanjutnya, buku ini menguraikan tugas kesehatan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang mengalami hipertensi, termasuk konsep hipertensi, pendekatan evidence-based practice, strategi pemberdayaan keluarga, serta berbagai hambatan yang dihadapi keluarga dalam pengendalian tekanan darah.

Pembahasan dalam buku ini juga menitikberatkan pada proses keperawatan keluarga, dimulai dari pengkajian keperawatan keluarga pada masalah hipertensi. Materi yang disajikan meliputi pengkajian kondisi anggota keluarga dengan hipertensi, pemantauan tekanan darah di rumah, pola makan, aktivitas fisik, kebiasaan harian, lingkungan rumah, dukungan sosial, hingga identifikasi masalah berdasarkan hasil pengkajian. Buku ini juga menguraikan diagnosis keperawatan keluarga yang sering muncul, penentuan prioritas diagnosis, integrasi SDKI-SLKI-SIKI dengan NANDA-I, NOC, dan NIC, serta berbagai kesalahan yang sering terjadi dalam penegakan diagnosis keperawatan keluarga. Selain itu, buku ini menyajikan berbagai intervensi edukasi yang aplikatif, seperti edukasi diet, aktivitas fisik, kepatuhan minum obat, dan pemantauan tekanan darah sebagai bagian penting dalam pengelolaan hipertensi berbasis keluarga. Pembahasan diperkuat dengan konsep pemberdayaan keluarga dalam pengambilan keputusan dan pencegahan komplikasi hipertensi, serta strategi perawat dalam memfasilitasi keluarga agar mampu menjalankan tugas kesehatan secara optimal. Pada bagian akhir, buku ini membahas evaluasi hasil asuhan keperawatan keluarga, metode evaluasi, dokumentasi keperawatan, dan tantangan dalam evaluasi pelayanan keluarga. Buku ini sangat relevan bagi mahasiswa keperawatan, dosen, perawat komunitas, tenaga kesehatan, dan pemerhati kesehatan keluarga sebagai referensi dalam meningkatkan kualitas asuhan keperawatan keluarga pada masalah hipertensi.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620



ISBN 978-634-7756-30-5 (PDF)

